ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 20 · GO

Manual de

GINECOLOGÍA

& Oncología Ginecológica

Módulo 3 · Materno - Infantil · 16 clases

Índice general

01 **Endocrinología Ginecológica, Ciclo Menstrual & SUA** 3

20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea 5
20.2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo 10
20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo 14
20.4. Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis 20

02 **Endometriosis, Piso Pélvico, Infertilidad & Anticoncepción** 25

20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado 27
20.6. Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia 32
20.7. Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida 35
20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia 40

03 **Infecciones Ginecológicas, Patología Vulvar & Climaterio** 46

20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis 48
20.10. Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso 54
20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos 58
20.12. Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos 64

04 **Oncología Ginecológica & Patología Mamaria** 68

20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía 70
20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna 76
20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores 81
20.16. Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico 86

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 91

MANUAL EUNACOM DE GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

20.1	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	5
20.2	Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	10
20.3	Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	14
20.4	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	20

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.012, 1.03.1.010, 1.03.1.016, 1.03.4.008, 3.01.3.011, 1.03.3.001	Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Específico	Completo	Completo
3.01.3.015, 3.01.1.022, 1.03.1.008	Síndrome de Ovario Poliquístico	Específico	Completo	Completo
3.01.1.018, 3.01.2.008, 3.01.1.023, 2.01.1.129	Sangrado Uterino Anormal	Específico	Completo	Completo
3.01.1.021, 1.09.5.006	Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Fase folicular: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.
- Pico de LH: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por 48h; induce la ovulación a las 36 horas.
- **! TRAMPA** · Primer paso ante amenorrea secundaria: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.
- Test de progesterona positivo (sangra): Indica anovulación con estrógenos presentes (clásico de SOP).
- Test de estrógeno + progestágeno negativo (no sangra): Causa anatómica en tracto de salida (Sd. de Asherman).
- FSH marcadamente elevada en amenorrea: Falla ovárica primaria (Insuficiencia ovárica precoz o Sd. Turner).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	EUNACOM Diciembre 2025 · #113 · EUNACOM Julio 2024 · #84 · EUNACOM Julio 2024 · #25 · EUNACOM Julio 2024 · #131
Síndrome de Ovario Poliquístico	EUNACOM Julio 2025 · #157 · EUNACOM Agosto 2021 · #115 · EUNACOM Julio 2018 · #117 · EUNACOM Diciembre 2018 · #110
Sangrado Uterino Anormal	EUNACOM Diciembre 2025 · #46 · EUNACOM Julio 2025 · #122 · EUNACOM Diciembre 2024 · #117 · EUNACOM Julio 2024 · #120
Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina	EUNACOM Diciembre 2025 · #43 · EUNACOM Diciembre 2025 · #162 · EUNACOM Julio 2024 · #51 · EUNACOM Agosto 2021 · #79

20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.012 | 1.03.1.010 | 1.03.1.016 | 1.03.4.008 | 3.01.3.011 | 1.03.3.001

¿POR QUÉ?

El ciclo menstrual femenino es regulado por la secreción pulsátil de GnRH hipotalámica, que induce la liberación de FSH y LH por la adenohipófisis para orquestar la foliculogénesis ovárica y la preparación endometrial. La amenorrea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología y una pregunta clásica garantizada en el examen EUNACOM. El alumno debe dominar con absoluta precisión dos algoritmos indispensables: el estudio sistemático de la amenorrea secundaria (donde el primer paso obligatorio es SIEMPRE descartar embarazo con β-hCG, seguido del test de progesterona) y la diferenciación diagnóstica de las amenorreas primarias basada en la presencia o ausencia de caracteres sexuales secundarios y útero.

1. FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL FEMENINO

• **Fase Folicular (Días 1 a 14):** La secreción pulsátil de GnRH estimula la síntesis de **FSH**. La FSH recluta una cohorte de folículos y selecciona el **folículo dominante** (de De Graaf), el cual secreta cantidades crecientes de **Estradiol** gracias a la aromatización de andrógenos en las células de la granulosa mediada por FSH (teoría de las dos células: Teca produce andrógenos bajo LH; Granulosa los aromatiza a estrógenos bajo FSH). El estradiol induce la fase proliferativa del endometrio. **(ver Imagen 20.1C)**

• **Pico Ovulatorio (Día 14):** Cuando el estradiol sérico supera un umbral crítico (> 200 pg/mL durante más de 48 horas), ejerce una **retroalimentación positiva sobre la hipófisis**, desencadenando el **pico masivo de LH** (y menor de FSH). La ovulación ocurre entre **36 horas después del inicio del pico de LH** (o 10 a 12 horas tras el pico máximo).

• **Fase Lútea o Secretora (Días 15 a 28):** El folículo colapsado se transforma en el **Cuerpo Lúteo** bajo influencia de la LH, secretando grandes cantidades de **Progesterona** (y estradiol). La progesterona transforma el endometrio en fase secretora apto para la implantación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera a los 14 días (cuerpo albicans), caen bruscamente los niveles de estrógeno y progesterona, desencadenando la descamación endometrial por isquemia de las arteriolas espirales (**Menstruación**).

2. AMENORREA PRIMARIA: ALGORITMO Y SÍNDROMES CLÁSICOS

• **Definición:** Ausencia de menarquia a los **13 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios** (ausencia de telarquia/pubarquia), o a los **15 años si existen caracteres sexuales secundarios normales**. 3.01.1.012 1.03.1.010

• **Clasificación Semiológica Inicial (Pregunta Fija EUNACOM):**

- **1) Con Caracteres Sexuales (+) y Útero AUSENTE:**

• **Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (Agenesia Mülleriána):** Cariotipo **46,XX**. Ovarios normales y funcionantes, niveles normales de estrógenos, mamas y vello púbico normales. Existe agenesia congénita de los 2/3 superiores de vagina y útero. No menstrúan nunca.

• **Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (Morris / Feminización Testicular):** Cariotipo **46,XY**. Mutación del receptor de andrógenos. Fenotipo femenino con mamas desarrolladas (por aromatización de testosterona) pero **ausencia total de vello axilar y púbico**. Testículos intraabdominales o inguinales (riesgo de gonadoblastoma/seminoma; deben extirparse postpubertad).

- **2) Con Caracteres Sexuales (-) y FSH Elevada (Hipogonadismo Hipergonadotropo):**

• **Síndrome de Turner (45,X0):** Talla baja, cuello alado (pterygium colli), tórax en escudo, coartación aórtica y disgenesia gonadal con 'cintillas ováricas'. Ovarios afuncionales -> FSH y LH marcadamente elevadas. **(ver Imagen 20.1B)**



Síndrome de Turner

• **Disgenesia Gonadal Pura (Sd. Swyer, 46,XY):** Fenotipo femenino sin desarrollo puberal, con estrías gonadales fibrosas y riesgo tumoral alto.

- **3) Con Caracteres Sexuales (-) y FSH Baja (Hipogonadismo Hipogonadotropo):**

• **Síndrome de Kallmann:** Falla en la migración de neuronas GnRH y axones olfatorios. Cursa con **amenorrea primaria + ANOSMIA / HIPOSMIA** con FSH y LH muy bajas.

TABLA 20.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE AMENORREA PRIMARIA 3.01.1.012, 1.03.1.010, 1.03.1.016, 1.03.4.008, 3.01.3.011, 1.03.3.001

SÍNDROME	CARIOTIPO	FENOTIPO	MAMAS / VELLO	ÚTERO / VAGINA	GONADOTROFINAS (FSH/LH)
Rokitansky-Küster (Agenesia)	46, XX	Femenino normal	Mamas normales / Vello normal	AUSENTE (fondo ciego)	NORMALES (Ovarios funcionan)
Morris (Insensibilidad Andrógenos)	46, XY	Femenino alto	Mamas desarrolladas / SIN VELLO	AUSENTE (fondo ciego)	LH y Testosterona elevadas
Turner (Disgenesia gonadal)	45, X0	Talla baja, cuello alado	Mamas infantiles / Vello escaso	PRESENTE (pequeño)	ELEVADAS (Falla ovárica)
Kallmann (Hipogonadotropo)	46, XX o XY	Femenino o masculino	Infantilismo sexual	PRESENTE	MUY BAJAS (+ Anosmia)
Himen Imperforado	46, XX	Femenino normal	Normales	PRESENTE (Criptomenorrea)	NORMALES

20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea — Enfrentamiento Diagnóstico

3. AMENORREA SECUNDARIA: ALGORITMO DIAGNÓSTICO ESCALONADO

• **Definición:** Cese de las menstruaciones durante **≥ 3 meses** en mujeres con ciclos regulares previos, o durante **≥ 6 meses** en mujeres oligomenorreicas. 3.01.1.012 1.03.1.010

• **Secuencia Diagnóstica Escalonada Oficial:**

- **Paso 1: Descartar Embarazo:** Solicitar **β-hCG**. Es la causa más común de amenorrea secundaria.

- **Paso 2: TSH y Prolactina (PRL):** Descartar Hipotiroidismo primario (la elevación de TRH estimula la prolactina) e **Hiperprolactinemia / Prolactinoma** (produce galactorrea y frena los pulsos de GnRH). Si la prolactina está elevada: solicitar RMN de hipófisis. 3.01.1.012 1.03.1.010 1.03.1.016 1.03.4.008

- **Paso 3: Test de Progesterona (Medroxiprogesterona 10 mg/día VO por 5-10 días):** 3.01.1.012 1.03.1.010

• **Test (+) (Regla presente / hemorragia por deprivación):** Indica que el eje produce estrógenos suficientes para proliferar el endometrio, pero la paciente **NO OVULA (Anovulación)**. Diagnóstico más frecuente: **Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)**.

• **Test (-) (No sangra):** Indica que el endometrio no proliferó (falta de estrógenos) o existe una obstrucción anatómica en el tracto de salida.

- **Paso 4: Test Combinado de Estrógenos + Progesterona (Estradiol 2 mg/día x 21 días + Progesterona los últimos 10 días):**

• **Si NO sangra:** Problema anatómico en el canal uterino o vaginal -> **Síndrome de Asherman (sinequias uterinas post-legrados)** o estenosis cervical. Diagnóstico con histeroscopía.

• **Si SANGRA:** El tracto de salida es permeable y el endometrio responde. El problema es una deficiencia hormonal ovárica o hipofisaria/hipotalámica.

- **Paso 5: Medición de Gonadotrofinas (FSH y LH séricas):** 3.01.1.012 1.03.1.010 1.03.4.008

• **FSH ELEVADA (> 30-40 UI/L):** Falla ovárica primaria -> **Insuficiencia Ovárica Prematura (Menopausia precoz)** en mujeres menores de 40 años.

• **FSH BAJA o Normal (< 5 UI/L):** Falla central -> **Amenorrea Hipotalámica Funcional** (estrés crónico, pérdida severa de peso, anorexia nerviosa, ejercicio físico extenuante como maratonistas o bailarinas) o Síndrome de Sheehan (necrosis isquémica hipofisaria postparto).



A. CICLO DE VEINTIOCHO DÍAS **B.** CUELLO ALADO EN TURNER **C.** MACROPROLACTINOMA (RM)

Imagen 20.1

FIGURA 20.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO ESCALONADO DE LA AMENORREA SECUNDARIA

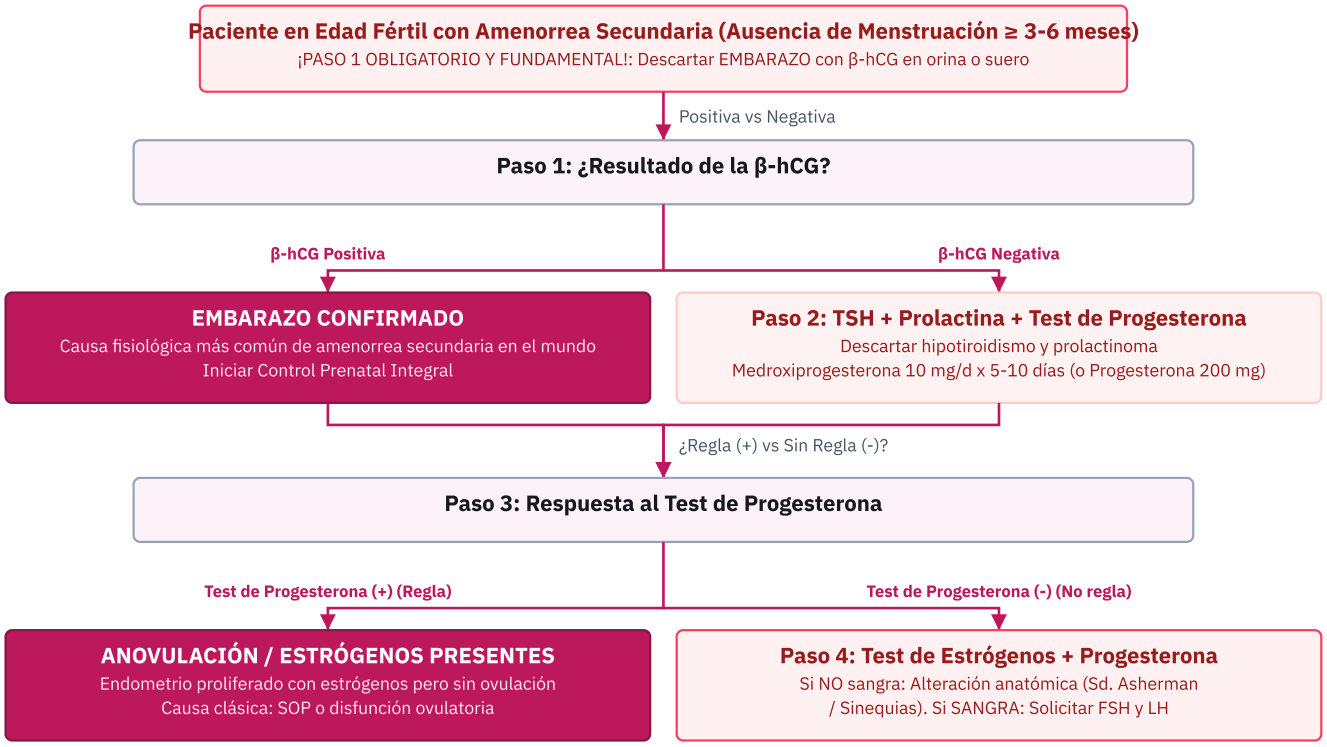


TABLA 20.1.B · COMPLICACIONES CRÍTICAS Y HALLAZGOS DE ALARMA EN AMENORREA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ENTIDAD CLÍNICA	RIESGOS Y SIGNOS DE GRAVEDAD	CONDUCTA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA INMEDIATA
Macroprolactinoma Hipofisario	Tumor > 10 mm con compromiso quiasmático: hemianopsia bitemporal, cefalea hipertensiva y amaurosis	RMN cerebral de urgencia + Cabergolina oral a dosis crecientes (o descompresión neuroquirúrgica transesfenoidal)
Gónadas Disgenéticas con Cromosoma Y	Presencia de línea celular Y (46,XY en Morris o Swyer) -> Riesgo de 30% de Gonadoblastoma y Disgerminoma maligno	Gonadectomía profiláctica laparoscópica una vez completado el desarrollo puberal en Morris, o inmediata en Swyer
Insuficiencia Ovárica Prematura (FOP)	Pérdida de función folicular en < 40 años -> Osteoporosis acelerada severa y riesgo cardiovascular temprano	Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) sustitutiva obligatoria hasta los 50 años para proteger hueso y endotelio
Hematocolpos por Himen Imperforado	Dolor pélvico cíclico progresivo intenso sin sangrado visible + Masa abombada azulada en introito	Himenotomía quirúrgica en cruz para evacuación inmediata de sangre acumulada

20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PUBERTAD NORMAL, HIPERPROLACTINEMIA E INTERPRETACIÓN HORMONAL EN AMENORREA

• **Pubertad normal en la mujer:** el primer signo es la **telarquia (botón mamario, Tanner M2) entre los 8 y 13 años**, seguida de pubarquia, **estirón puberal** (pico de velocidad de crecimiento en Tanner M3, *antes* de la menarquia) y **menarquia a los 12-13 años** (en Chile en promedio ~12,5 años), 2 a 2,5 años después de la telarquia. Se inicia por la reactivación de la secreción pulsátil de GnRH (eje hipotálamo-hipófisis-ovario) con aumento de LH/FSH y estradiol. 3.01.3.011 1.03.3.001

- **Estadios de Tanner:** M1-M5 (mama) y P1-P5 (vello pubiano). Los primeros ciclos suelen ser anovulatorios e irregulares hasta 2-3 años posmenarquia: no requieren estudio si no superan los 90 días ni son muy abundantes.

- **Pubertad precoz** (telarquia o pubarquia **antes de los 8 años**): sospecha y **derivación a endocrinología** (edad ósea, LH/FSH, RMN si es central). **Retraso puberal**: ausencia de telarquia a los **13 años** o más de 5 años entre telarquia y menarquia. Es el mismo umbral de la amenorrea primaria sin caracteres sexuales secundarios.

• **Hiperprolactinemia (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar):** la prolactina inhibe los pulsos de GnRH (amenorrea, oligomenorrea, infertilidad) y produce **galactorrea**. **Causas:** embarazo y lactancia, **fármacos** (antipsicóticos, metoclopramida, metildopa, ISRS, verapamilo, anticonceptivos con estrógenos), hipotiroidismo primario, insuficiencia renal crónica, estrés/estimulación mamaria y **prolactinoma** (adenoma hipofisario más frecuente). 1.03.1.016

- **Estudio:** prolactina en reposo (idealmente en ayunas, sin examen mamario previo), β-hCG y TSH; excluir fármacos. Una PRL **> 100 ng/mL** sugiere prolactinoma y **> 200 ng/mL** un macroadenoma (> 10 mm) casi seguro; en cifras bajas pensar en fármacos o *efecto tallo*. Si se confirma: **RMN de silla turca** y campos visuales ante macroadenoma (hemianopsia bitemporal).

- **Tratamiento: agonistas dopaminérgicos** de primera línea para micro y macroprolactinomas: **cabergolina** 0,25-0,5 mg 1-2 veces por semana (mejor tolerada) o bromocriptina; normalizan PRL, reducen el tumor y restablecen ciclos y fertilidad. La cirugía transesfenoidal se reserva para resistencia o intolerancia. Se **deriva a endocrinología** para el seguimiento.

• **Interpretación de FSH, estradiol y prolactina (Interpreta y emplea):** se miden al inicio del ciclo (día 2-3) si hay ciclos; en amenorrea, en cualquier momento. **(ver Imagen 20.1A)** 1.03.4.008

- **FSH alta (> 30-40 UI/L) + estradiol bajo (< 20-30 pg/mL):** falla ovárica primaria (insuficiencia ovárica prematura, Turner, menopausia).

- **FSH/LH bajas o normales + estradiol bajo:** hipogonadismo hipogonadotropo (hipotalámico funcional, hipofisario, Kallmann).

- **Estradiol normal o alto con FSH normal:** eje conservado (anovulación, SOP). Un estradiol alto aislado en un ciclo estimulado o con tumor ovárico secretor se confirma con ecografía. **PRL alta:** ver arriba; siempre repetir ante un valor levemente elevado y descartar macroprolactinemia. 1.03.4.008 1.03.1.016

TABLA 20.1.C · ABORDAJE FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN TRASTORNOS DEL CICLO Y AMENORREA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CAUSA SUBYACENTE	FÁRMACO / INTERVENCIÓN	MECANISMO Y DOSIS	META TERAPÉUTICA PRINCIPAL
Anovulación por SOP	Medroxiprogesterona o Progesterona micronizada	10 mg/d o 200 mg/d por 10-12 días al mes (o ACOs)	Prevenir hiperplasia y adenocarcinoma de endometrio por estímulo estrogénico no balanceado.
Hiperprolactinemia / Prolactinoma	Cabergolina (o Bromocriptina)	Agonista dopaminérgico D2: 0.5 mg 1 a 2 veces por semana	Normalizar prolactina, inducir regresión tumoral y restablecer fertilidad.
Amenorrea Hipotalámica Funcional	Manejo nutricional + Apoyo psicológico	Aumento ponderal, reducción del gasto energético, IMC > 19	Reactivar la secreción pulsátil fisiológica de GnRH en hipotálamo.
Síndrome de Asherman	Lisis histeroscópica de sinequias + Sonda Foley	Resección de bridas intrauterinas guiada + estrógenos a altas dosis	Restaurar la arquitectura y permeabilidad de la cavidad endometrial.

20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL, EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO Y ESTUDIO DE LA AMENORREA)

- Fase folicular: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.
- Primer paso ante amenorrea secundaria: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.
- Test de estrógeno + progestágeno negativo (no sangra): Causa anatómica en tracto de salida (Sd. de Asherman).
- FSH baja en amenorrea: Causa central hipotalámica funcional (estrés, anorexia, pérdida de peso) o hipofisaria.
- Síndrome de Morris (46,XY): Fenotipo femenino con mamas, pero SIN vello púbico/axilar, testículos intraabdominales y sin útero.
- Pico de LH: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por 48h; induce la ovulación a las 36 horas.
- Test de progesterona positivo (sangra): Indica anovulación con estrógenos presentes (clásico de SOP).
- FSH marcadamente elevada en amenorrea: Falla ovárica primaria (Insuficiencia ovárica precoz o Sd. Turner).
- Síndrome de Rokitansky (46,XX): Amenorrea primaria con mamas y vello normales, ovarios normales pero SIN útero.
- Síndrome de Kallmann: Amenorrea primaria por hipogonadismo hipogonadotropo asociada a ANOSMIA.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.1

Adolescente de 16 años acude a la consulta ginecológica acompañada de su madre por no haber presentado nunca una menstruación. Al examen físico: desarrollo mamario Tanner IV y vello pubiano Tanner IV normales y acordes a la edad. Presión arterial de 115/70 mmHg, talla de 1.62 m. Al examen ginecológico: genitales externos femeninos normales, pero al intentar introducir el hisopo o explorador se constata una vagina corta que termina en fondo de saco ciego de aproximadamente 2 cm. Se solicita ecografía pelviana que informa ausencia de útero, con ambos ovarios presentes de aspecto y volumen normales. El cariotipo solicitado resulta 46,XX.

Conducta oficial razonada. Nos encontramos ante una paciente con Amenorrea Primaria que presenta desarrollo de caracteres sexuales secundarios normales (mamas y vello púbico Tanner IV), cariotipo femenino normal 46,XX, presencia de ovarios normales funcionantes pero con AUSENCIA congénita de útero y de los dos tercios superiores de la vagina. Esta constelación clínica y genética es diagnóstica y patognomónica del Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (Agenesia Mülleriána). A diferencia del Síndrome de Morris (Insensibilidad completa a los andrógenos), las pacientes con Rokitansky tienen cariotipo 46,XX, vello pubiano normal y niveles de testosterona normales femeninos. El manejo consiste en apoyo psicológico multidisciplinario y la creación de una neovagina mediante dilatadores progresivos de Frank o vaginoplastía quirúrgica para permitir una vida sexual normal; la paciente es biológicamente fértil a través de sus propios ovocitos mediante fertilización in vitro y maternidad subrogada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

1. Una paciente de 25 años, con antecedentes de menstruaciones regulares, consulta por amenorrea de 5 meses. No utiliza métodos anticonceptivos hormonales. La prueba de β-hCG en orina resulta negativa. El médico administra Medroxiprogesterona 10 mg al día por vía oral durante 10 días, presentando la paciente un sangrado genital abundante de características menstruales 3 días después de suspender el fármaco (Test de Progesterona positivo). ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica de este resultado?

A) Falla ovárica prematura con agotamiento folicular irreversible
B) Presencia de un endometrio adecuadamente proliferado por estrógenos endógenos pero con anovulación
C) Estenosis cervical obstructiva secundaria con retención hemática intrauterina
D) Síndrome de Asherman con sinequias uterinas completas
E) Hipogonadismo hipogonadotropo por tumor selar destructor

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

2. Una joven de 17 años es evaluada por amenorrea primaria. Al examen físico presenta una talla de 1.70 m, excelente desarrollo mamario Tanner V, pero llama la atención la ausencia casi completa de vello axilar y pubiano (Tanner I). Al examen ginecológico se constata una vagina ciega de 3 cm de profundidad, sin palparse cuello uterino ni útero en la ecografía pelviana. En ambos conductos inguinales se palpan masas móviles no dolorosas. El estudio citogenético informa un cariotipo 46,XY. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
B) Síndrome de Turner
C) Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (Síndrome de Morris)
D) Disgenesia gonadal pura (Síndrome de Swyer)
E) Hiperplasia suprarrenal congénita clásica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

3. Una paciente de 33 años, con antecedente de legrado uterino instrumental por aborto incompleto hace 6 meses, consulta por ausencia de menstruación desde el procedimiento. La β-hCG es negativa, TSH y prolactina normales. Se realiza un test de progesterona que resulta negativo. Posteriormente se administra una prueba combinada de estrógenos más progesterona por 21 días, no presentándose sangrado de deprivación. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico sospechado?

A) Resonancia magnética de hipófisis
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Cariotipo en sangre periférica
D) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E) Medición seriada de hormona antimülleriana

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

4. Una mujer de 19 años es evaluada por amenorrea primaria y ausencia total de desarrollo puberal (Tanner mamario I). Durante la anamnesis refiere que desde niña no es capaz de percibir los olores (anosmia). Al laboratorio se encuentra FSH de 0.8 mUI/mL y LH de 0.5 mUI/mL (ambas muy disminuidas). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Turner
B) Síndrome de Kallmann
C) Craneofaringioma
D) Insuficiencia ovárica prematura
E) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Más preguntas online de Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea →

20.2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.3.015 3.01.1.022 1.03.1.008

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) o Síndrome de Stein-Leventhal es la endocrinopatía más prevalente en mujeres en edad reproductiva (afecta al 8-13% de la población femenina) y la principal causa de anovulación crónica e infertilidad anovulatoria. Se caracteriza por un desbalance neuroendocrino y metabólico donde la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria estimulan la síntesis de andrógenos ováricos por las células de la teca y suprimen la proteína transportadora SHBG, disparando la testosterona libre. En el EUNACOM se evalúa con rigor el diagnóstico mediante los Criterios de Rotterdam, el descarte de diagnósticos diferenciales (hiperplasia suprarrenal no clásica) y la elección terapéutica según el deseo de fertilidad.

1. FISIOPATOLOGÍA Y RESISTENCIA A LA INSULINA EN SOP

• **Pilar Neuroendocrino:** Aumento de la frecuencia de los pulsos de GnRH hipotalámica, lo que favorece la síntesis preferencial de **LH por sobre FSH** (relación LH/FSH > 2:1 clásica). 3.01.3.015 3.01.1.022
La LH estimula excesivamente a las células de la teca ovárica para sintetizar andrógenos (androstenediona y testosterona). El relativo déficit de FSH impide la aromatización completa a estrógenos, produciendo detención del desarrollo folicular en etapa antral y anovulación crónica. **(ver Imagen 20.2A)**

• **Pilar Metabólico (Resistencia a la Insulina e Hiperinsulinemia):** Presente en el 70-80% de las pacientes con SOP (incluso en mujeres no obesas). La hiperinsulinemia actúa sinérgicamente con la LH sobre el ovario para aumentar la producción androgénica, y en el hígado **inhibe la síntesis de SHBG (globulina transportadora de hormonas sexuales)**, lo que dispara drásticamente la fracción de **Testosterona Libre** biológicamente activa. 3.01.3.015

• **Riesgos Oncológicos a Largo Plazo:** La anovulación crónica genera un estado de **estímulo estrogénico continuo sin oposición de progesterona** (por ausencia de cuerpo lúteo), lo que condiciona un riesgo 3 a 4 veces mayor de desarrollar **Hiperplasia Endometrial y Adenocarcinoma de Endometrio**.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ROTTERDAM (CONSENSO INTERNACIONAL)

• Se requiere la presencia de al menos **DOS de los siguientes TRES criterios**, tras la exclusión obligatoria de otras patologías (hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica y tumores secretores): 3.01.3.015

- **1) Oligo-ovulación o Anovulación:** Ciclos menstruales infrecuentes (oligomenorrea con intervalos > 35 días o < 8 ciclos al año) o amenorrea. 3.01.3.015 3.01.1.022

- **2) Signos Clínicos y/o Bioquímicos de Hiperandrogenismo:** 3.01.3.015

• Clínico: **Hirsutismo** evaluado mediante Escala de Ferriman-Gallwey (puntaje ≥ 8 en población latina/caucásica), acné vulgar severo/refractario o alopecia androgénica. **(ver Imagen 20.2C)** 3.01.3.015 1.03.1.008



Hirsutismo facial / escala de Ferriman-Gallwey

• Bioquímico: Elevación de la testosterona total, testosterona libre o índice de andrógenos libres.

- **3) Morfología de Ovario Poliquístico en Ecografía Transvaginal:** Presencia de **≥ 20 folículos** (de 2 a 9 mm de diámetro distribuidos en la periferia en 'collar de perlas') o un **volumen ovárico aumentado > 10 mL** en al menos uno de los ovarios (sin quistes dominantes ni cuerpo lúteo). **(ver Imagen 20.2B)** 3.01.3.015

• **Descarte de Diagnósticos Diferenciales (Pregunta EUNACOM):**

- Solicitar **17-hidroxiprogesterona (17-OHP) matinal**: si es > 2 ng/mL (o > 200 ng/dL), sospechar **Hiperplasia Suprarrenal Congénita No Clásica** (déficit de 21-hidroxilasa). 3.01.3.015 1.03.1.008

- Solicitar TSH (hipotiroidismo) y Prolactina (prolactinoma). 3.01.3.015

3. MANEJO TERAPÉUTICO INTEGRAL SEGÚN DESEO REPRODUCTIVO

• **1. Medidas Generales y Estilo de Vida (Pilar Universal de Primera Línea):** Dieta hipocalórica, ejercicio aeróbico regular y reducción del 5 al 10% del peso corporal. Esta sola intervención disminuye la resistencia a la insulina, reduce los andrógenos libres y restablece la ovulación espontánea en más del 50% de las pacientes. 3.01.3.015 3.01.1.022

• **2. Paciente que NO DESEA Embarazo:**

- **Anticonceptivos Orales Combinados (ACOs):** Tratamiento de elección. Mecanismo: suprimen la LH hipofisaria (frenan la síntesis androgénica ovárica), estimulan la SHBG hepática por su componente estrogénico (reducen la testosterona libre) y protegen al endometrio con el progestágeno regular. Se prefieren ACOs con progestágenos antiandrogénicos: **Acetato de Ciproterona, Dienogest o Drospirenona**. 3.01.3.015 3.01.1.022 1.03.1.008

- **Espironolactona (50 a 100 mg/d):** Antagonista del receptor de andrógenos, útil como coadyuvante en hirsutismo severo si persiste tras 6 meses de ACOs.

- **Metformina (850 a 1.500 mg/d):** Indicada ante intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional previa o resistencia a la insulina comprobada. 3.01.3.015 3.01.1.022

• **3. Paciente que SÍ DESEA Embarazo (Infertilidad Anovulatoria):**

- Fármaco inductor de ovulación de primera línea actual: **LETROZOL** (Inhibidor de la aromatasa; 2.5 a 5 mg/día en días 3 a 7 del ciclo). Mayor tasa de ovulación, embarazo y nacidos vivos en SOP comparado con el Citrato de Clomifeno.

- Alternativa clásica: **Citrato de Clomifeno** (modulador selectivo de receptores estrogénicos que aumenta la FSH hipofisaria).

4. HIRSUTISMO: OTRAS CAUSAS Y ESTUDIO ETIOLÓGICO

• **Hirsutismo (nivel Sospecha / tratamiento Inicial):** vello terminal en zonas andrógeno-dependientes (Ferriman-Gallwey ≥ 8). Es un signo, no un diagnóstico: el **SOP explica cerca del 70-80%**, pero antes de rotular hay que descartar otras causas. 1.03.1.008

- **Hirsutismo idiopático** (andrógenos normales, ciclos regulares; aumento de la actividad 5α-reductasa) y **hiperplasia suprarrenal congénita no clásica** (déficit de 21-hidroxilasa: 17-OH-progesterona basal en fase folicular > 2 ng/mL, confirmar con test de ACTH).

- **Hiperprolactinemia, hipotiroidismo y síndrome de Cushing** (cortisol libre urinario o supresión con dexametasona 1 mg); **fármacos** (danazol, es-

teroides anabólicos, valproato, ciclosporina, minoxidil).

- **Tumor secretor de andrógenos** (ovario o suprarrenal): sospechar si el inicio es **brusco y rápidamente progresivo**, hay **virilización** (clitoromegalia, voz grave, alopecia temporal, masa muscular) o **testosterona total > 150-200 ng/dL** o DHEA-S > 700 µg/dL; se solicita imagen (ecografía TV/TAC) y se deriva de inmediato.

- **Estudio básico inicial:** testosterona total (± libre), DHEA-S, 17-OH-progesterona, TSH y prolactina. Tratamiento inicial: medidas cosméticas (depilación, láser), ACO combinado y, tras 6 meses sin respuesta, antiandrógeno (espironolactona); se deriva si hay hallazgos atípicos.



A. ACANTOSIS NIGRICANS



B. OVARIO POLIQUÍSTICO (ECO)



C. ESCALA DE FERRIMAN-GALLWEY

Imagen 20.2

FIGURA 20.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

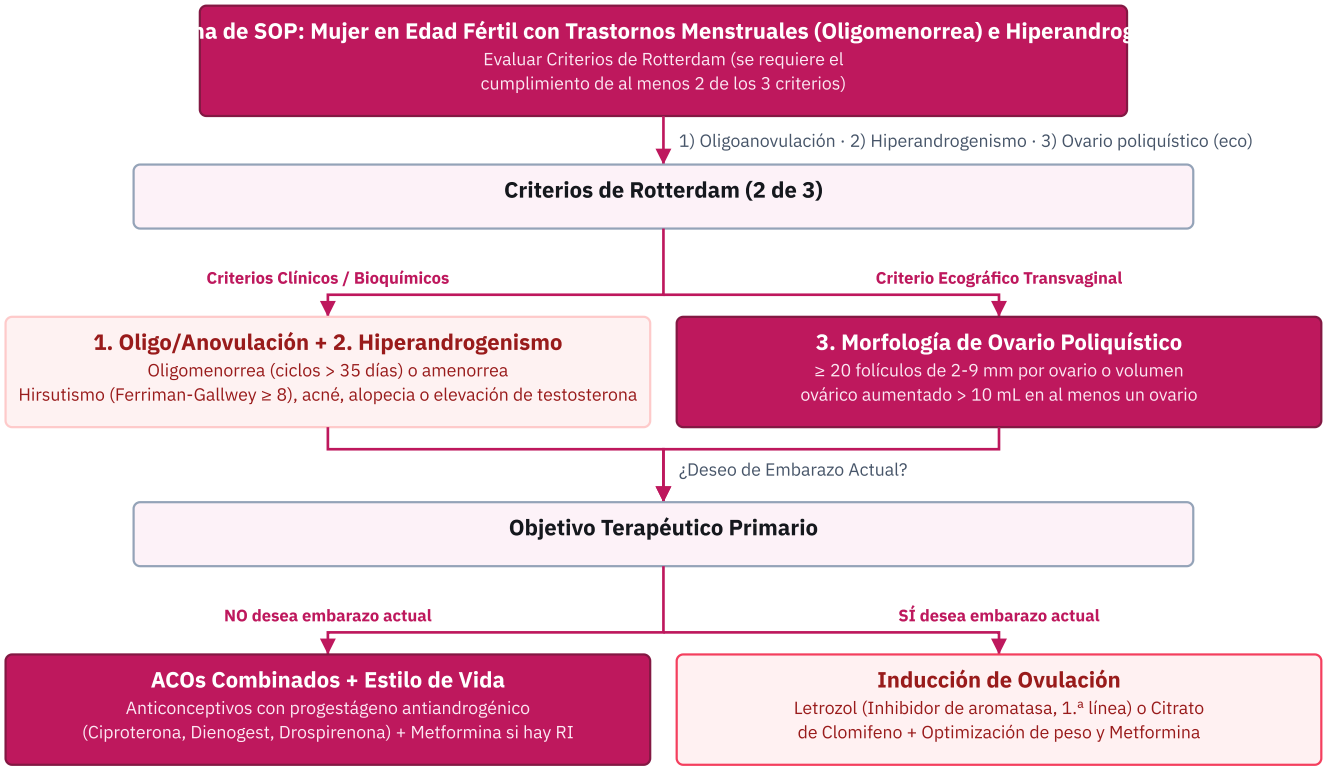


TABLA 20.2 · CRITERIOS DE ROTTERDAM PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 3.01.3.015, 3.01.1.022, 1.03.1.008

CRITERIO DIAGNÓSTICO	DEFINICIÓN OPERATIVA EUNACOM	MÉTODO DE EVALUACIÓN
1. Disfunción Ovulatoria	Oligomenorrea (ciclos > 35 días) o Amenorrea (ausencia > 3 meses)	Anamnesis ginecológica y calendario menstrual
2. Hiperandrogenismo	Hirsutismo clínico, acné severo, alopecia o testosterona elevada	Score de Ferriman-Gallwey ≥ 8 / Testosterona libre
3. Ovario Poliquístico	≥ 20 folículos (2-9 mm) por ovario o volumen ovárico > 10 mL	Ecografía transvaginal ginecológica (fase folicular)
Exclusión Obligatoria	Descartar hiperplasia suprarrenal no clásica, hipotiroidismo, hiperprolactinemia	17-OH Progesterona, TSH, Prolactina séricas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.2

Mujer de 24 años, con sobrepeso (IMC 28.5 kg/m²), consulta por acné facial persistente y reglas irregulares que se presentan cada 45 a 60 días desde la menarquia. Al examen físico: presencia de vello grueso terminal en bozo, mentón, línea alba y cara interna de muslos, con un puntaje de Ferriman-Gallwey de 12 puntos. En el cuello se observa una placa hiperpigmentada aterciopelada compatible con acantosis nigricans. La paciente refiere no estar buscando embarazo y solicita tratamiento para regularizar sus reglas y mejorar su piel.

Conducta oficial. La paciente presenta la tríada clásica del Síndrome de Ovario Poliquístico: disfunción ovulatoria (oligomenorrea), hiperandrogenismo clínico (hirsutismo severo con Ferriman-Gallwey de 12 y acné) y estigmas marcados de resistencia a la insulina (acantosis nigricans e IMC aumentado), cumpliendo con los Criterios de Rotterdam. Dado que la paciente no desea fertilidad inmediata, el tratamiento médico de elección consiste en cambios terapéuticos del estilo de vida (dieta y ejercicio) combinados con Anticonceptivos Orales Combinados (ACOs) con progestágeno de perfil antiandrogénico (como Dienogest, Drospirenona o Acetato de Ciproterona) para suprimir los andrógenos ováricos, regularizar las menstruaciones y otorgar protección endometrial indispensable frente al riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Criterios de Rotterdam (se requieren 2 de 3): Oligo/anovulación + Hiperandrogenismo + Ecografía ovárica característica.
- Criterio ecográfico actual: ≥ 20 folículos de 2-9 mm en al menos un ovario o volumen ovárico > 10 mL.
- Descarte obligatorio de hiperplasia suprarrenal no clásica: Medir 17-OH Progesterona matinal.
- Fisiopatología central: Hiperinsulinemia suprime la SHBG hepática, aumentando la testosterona libre.
- Riesgo oncológico principal del SOP no tratado: Hiperplasia y Cáncer de Endometrio por estrógenos sin oposición.
- Tratamiento de elección si no desea embarazo: Estilo de vida + ACOs con progestágeno antiandrogénico.
- Tratamiento de elección si desea fertilidad: Letrozol (inhibidor de aromatasa) como inductor de ovulación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.015

1. Una mujer de 22 años consulta por ciclos menstruales que se presentan cada 50 a 70 días, asociados a aumento de vello facial en mentón y patillas. En la ecografía ginecológica transvaginal se aprecian ambos ovarios con 24 microfolículos periféricos de 3 a 7 mm y un volumen ovárico de 13 mL cada uno. La paciente no desea embarazo en este momento. Además de recomendar cambios en el estilo de vida y baja de peso, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

A) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno
B) Anticonceptivos orales combinados con progestágeno antiandrogénico (ej. Etinilestradiol con Dienogest o Ciproterona)
C) Dexametasona oral a altas dosis de por vida
D) Resección ovárica en cuña por laparoscopía
E) Danazol oral continuo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.015

2. ¿Cuál es la complicación neoplásica ginecológica a largo plazo cuya incidencia se encuentra significativamente aumentada en mujeres jóvenes con Síndrome de Ovario Poliquístico y anovulación crónica que no reciben tratamiento hormonal progestativo periódico?

A) Cáncer de cuello uterino por virus del papiloma humano
B) Carcinoma de endometrio tipo I (endometrioide)
C) Cáncer epitelial seroso de ovario de alto grado
D) Coriocarcinoma gestacional persistente
E) Sarcoma del estroma endometrial

Más preguntas online de Síndrome de Ovario Poliquístico →

20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.018 | 3.01.2.008 | 3.01.1.023 | 2.01.1.129

¿POR QUÉ?

El Sangrado Uterino Anormal (SUA) es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica tanto en atención primaria como en urgencias. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) estandarizó su etiología mediante la regla mnemotécnica PALM-COEIN, dividiéndolas en causas estructurales objetivables por imagen/anatomopatología (Pólipos, Adenomiosis, Leiomiomas, Malignidad e hiperplasia) y no estructurales (Coagulopatía, Disfunción Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica y No clasificada). Para el EUNACOM es mandatorio saber cuándo está indicada una biopsia endometrial ambulatoria (cánula de Pipelle) para descartar cáncer de endometrio: toda mujer ≥ 45 años con SUA, cualquier mujer con sangrado en la postmenopausia o menores de 45 años con factores de riesgo.

1. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN FIGO: SISTEMA PALM-COEIN

• Se define SUA como cualquier alteración en la frecuencia, regularidad, duración o volumen del sangrado menstrual en una mujer no gestante. 3.01.1.018 2.01.1.129

• **Grupo PALM (Causas Estructurales Anatómicas):**

- **P (Pólipo endometrial):** Proliferación hiperplásica focal benigna de glándulas y estroma endometrial. Es la causa estructural más frecuente de sangrado intermenstrual y metrorragia en perimenopausia. Diagnóstico: ecografía TV / histerosonografía. Tratamiento: polipectomía histeroscópica. 3.01.1.018 3.01.1.023 2.01.1.129



Pólipo endometrial en ecografía transvaginal

- **A (Adenomiosis):** Presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio, con hipertrofia muscular concéntrica reactiva. Cursa con hipermenorrea y dismenorrea secundaria severa, con útero globuloso y doloroso. 3.01.1.018 2.01.1.129

- **L (Leiomioma / Miomatosis):** Tumores benignos de músculo liso miometrial. Los que más sangran son los **submucosos (FIGO 0, 1 y 2)** al distorsionar la cavidad endometrial.

- **M (Malignidad e Hiperplasia):** Hiperplasia endometrial con atipias y adenocarcinoma de endometrio. Es la causa que SIEMPRE debe descartarse en mujeres mayores. 3.01.1.018 3.01.1.023 2.01.1.129

• **Grupo COEIN (Causas No Estructurales Funcionales):** (ver Imagen 20.3A)

- **C (Coagulopatía):** Trastornos de la hemostasia. La **Enfermedad de von Willebrand** es la causa más común en adolescentes con hipermenorrea severa desde la menarquia (hasta el 20% de los casos). 3.01.1.018 2.01.1.129

- **O (Disfunción Ovulatoria):** Anovulación crónica (típica de extremos de la vida reproductiva y de pacientes con SOP o disfunción tiroidea).

- **E (Endometrial):** Disfunción primaria en la producción local de prostaglandinas vasoconstrictoras y hemostasia endometrial en ciclos ovulatorios regulares.

- **I (Iatrogénica):** Uso de DIU de cobre, implantes de progestágeno, anticonceptivos, anticoagulantes o psicofármacos.

- **N (No clasificada):** Malformaciones arteriovenosas uterinas, etc.

2. INDICACIONES MANDATORIAS DE BIOPSIA ENDOMETRIAL

• El objetivo primordial del estudio en SUA es descartar patología preneoplásica (hiperplasia endometrial con atipias) y neoplásica (adenocarcinoma de endometrio). 3.01.1.018 3.01.1.023

• **Criterios Oficiales de Indicación de Biopsia de Endometrio (ACOG / MINSAL):**

- **1) Toda mujer de 45 años o más que consulte por SUA.**

- **2) Toda mujer con Sangrado Uterino en la Postmenopausia** (cualquier sangrado ocurrido tras más de 12 meses de amenorrea en la menopausia, especialmente si el grosor endometrial ecográfico es **> 4 a 5 mm**).

- **3) Pacientes menores de 45 años con Factores de Riesgo para Cáncer de Endometrio:** Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m²), anovulación crónica prolongada (SOP), nuliparidad, uso de Tamoxifeno, diabetes mellitus o antecedente familiar de Síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario no polipósico).

- **4) Falla o persistencia del sangrado** tras tratamiento médico farmacológico de primera línea.

• **Método de Elección: Biopsia por aspiración con cánula de Pipelle** en box ambulatorio (sensibilidad > 95% para adenocarcinoma). Si la muestra es insuficiente, el canal cervical está estenótico o persisten dudas: **Histeroscopía con biopsia dirigida**.

TABLA 20.3.A · CLASIFICACIÓN FIGO PALM-COEIN DE LAS CAUSAS DE SANGRADO UTERINO ANORMAL

3.01.1.018, 3.01.2.008, 3.01.1.023, 2.01.1.129

CATEGORÍA	ETIOLOGÍA	NATURALEZA	DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO HABITUAL
P	Pólipos Endometriales	Estructural	Ecografía TV / Histerosonografía	Polipectomía por histeroscopía
A	Adenomiosis	Estructural	RMN pélvica / Eco TV Doppler	DIU-LNG / AINEs / Histerectomía
L	Leiomiomas (Miomas)	Estructural	Ecografía TV (mapeo FIGO)	Miomectomía / DIU-LNG / Embolización
M	Malignidad e Hiperplasia	Estructural	Biopsia Pipelle / Histeroscopía	Oncológico: Cirugía etapificadora
C	Coagulopatías	No estructural	Estudio hemostasia (vWF, plaquetas)	Ácido tranexámico / Desmopresina
O	Disfunción Ovulatoria	No estructural	Historia clínica (anovulación, SOP)	Progestágenos / ACOs combinados
E	Causas Endometriales	No estructural	Diagnóstico de exclusión	DIU-LNG / Ácido tranexámico / AINEs
I	Causas Iatrogénicas	No estructural	Fármacos (anticoagulantes, DIU-Cu)	Retiro o cambio de método
N	No Clasificadas	No estructural	Malformaciones arteriovenosas	Angiografía / Embolización

20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO TERAPÉUTICO DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL

• **Manejo de la Hemorragia Uterina Aguda Severa (Urgencia):** 3.01.1.018 3.01.2.008

- Estabilización hemodinámica con fluidos.

- Fármaco de 1.ª línea: **Estrógenos conjugados equinos EV (25 mg c/4-6h)** o anticonceptivos orales combinados en altas dosis escalonadas (ej. 1 comprimido cada 8 horas hasta el cese, luego reducir progresivamente) + **Ácido Tranexámico 1g EV cada 8 horas**.

- Si la hemorragia es incontrolable o hay inestabilidad: **Legrado Uterino Instrumental hemostático de urgencia** o taponamiento con sonda Foley intrauterina.

• **Manejo Médico Crónico de Causas No Estructurales (COEIN):** 3.01.1.018 2.01.1.129

- **Dispositivo Intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG / Mirena): ESTÁNDAR DE ORO** médico de máxima eficacia. Reduce el sangrado en más de un 90% a los 6 meses y protege el endometrio.

- **Ácido Tranexámico oral (1g cada 8h durante los días de menstruación):** Antifibrinolítico no hormonal, reduce la pérdida sanguínea en 40-50%. Excelente opción en mujeres que desean embarazarse o con contraindicaciones hormonales.

- **AINEs (Ácido Mefenámico, Ibuprofeno):** Inhiben prostaglandinas inflamatorias vasodilatadoras endometriales, reduciendo el sangrado en 30% y aliviando la dismenorrea. **(ver Imagen 20.3B)**

- **Anticonceptivos Hormonales Combinados o Progestágenos orales continuos.**





A. CLASIFICACIÓN PALM-COEIN B. PÓLIPOS ENDOMETRIALES (ECO) C. CÁNCER CERVICOUTERINO

Imagen 20.3

FIGURA 20.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL (PALM-COEIN)

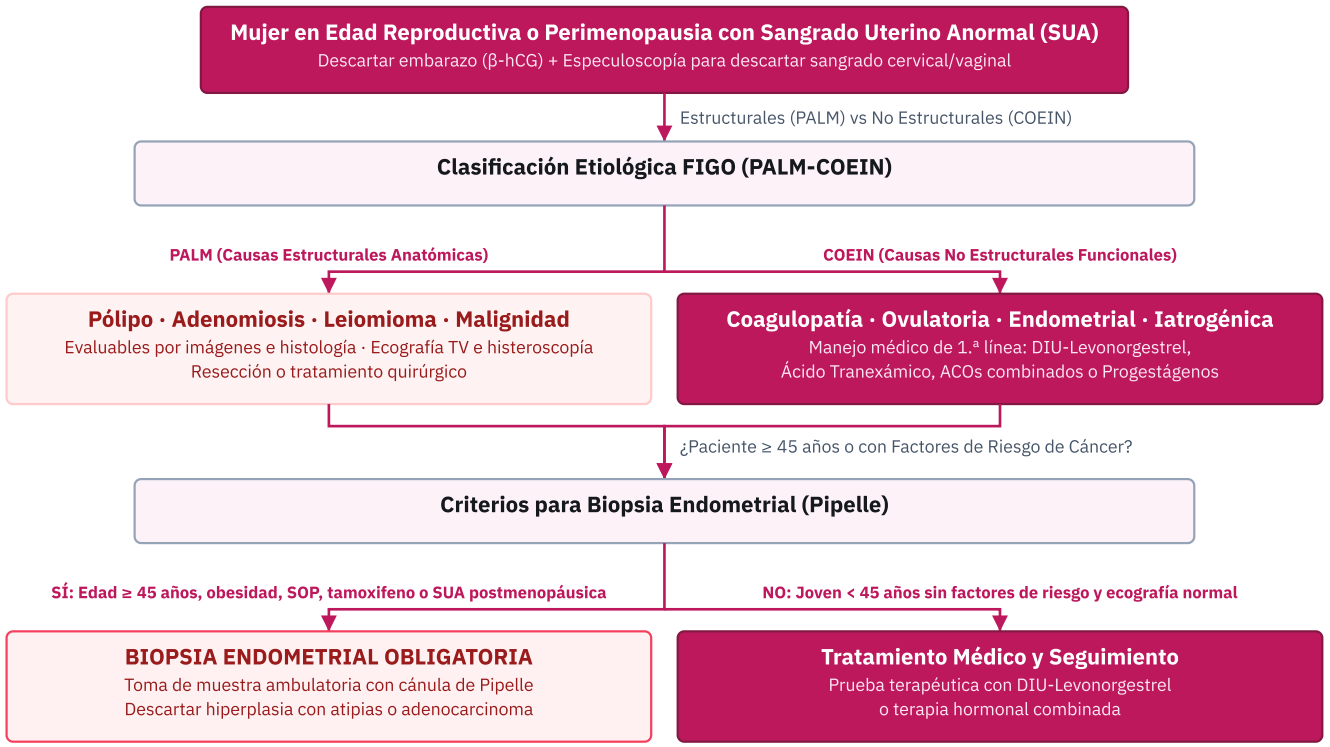


TABLA 20.3.B · CRITERIOS DE BIOPSIA ENDOMETRIAL OBLIGATORIA EN SANGRADO UTERINO ANORMAL CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRUPO DE POBLACIÓN	CRITERIO CLÍNICO MANDATORIO	RAZÓN ONCOLÓGICA FUNDAMENTAL
Mujeres ≥ 45 años	Cualquier SUA (hipermenorrea, sangrado intermenstrual o sangrado frecuente)	Pico de incidencia de hiperplasia con atipias y cáncer de endometrio perimenopáusico.
Mujeres Postmenopáusicas	Cualquier metrorragia tras > 12 meses de amenorrea (especialmente si endometrio > 4 mm)	El 10-15% de las metrorragias postmenopáusicas corresponden a cáncer de endometrio.
Mujeres < 45 años con Riesgo	Obesidad (IMC ≥ 30), anovulación crónica por SOP, uso de tamoxifeno o Síndrome de Lynch	Exposición continua a estrógenos no balanceados que induce mutaciones carcinogénicas.
Falla de Terapia Médica	Persistencia de hipermenorrea tras 3-6 meses de tratamiento médico adecuado	Descartar lesiones endometriales focales no visualizadas previamente.

20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CERVICORRAGIA POR CÁNCER CERVICOUTERINO E HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

• **Hemorragia genital aguda de origen cervical (urgencia: Sospecha / Inicial):** 3.01.2.008 sospechar **cáncer cervicouterino** ante sangrado poscoito, intermenstrual o posmenopáusico, flujo fétido y cuello **friable, ulcerado o exofítico** a la especuloscopia. Una cervicorragia abundante puede producir shock hipovolémico. **(ver Imagen 20.3C)**

- **Manejo inicial:** dos vías venosas, reposición de volumen, hemograma y pruebas cruzadas; **taponaje vaginal** compresivo (gasas en ácido tranexámico o povidona, sonda Foley vesical), ácido tranexámico EV y **derivación urgente a oncología ginecológica** (radioterapia hemostática, embolización o cirugía). **Biopsia del cuello** dirigida una vez estable. Evitar el legrado uterino: el origen no es endometrial. En la sospecha de CaCu se activa el GES con la derivación.

• **Hiperplasia endometrial (Sospecha / Inicial / Derivar):** 3.01.1.023 proliferación glandular por **estrógenos sin oposición de progesterona** (anovulación crónica/SOP, obesidad, TRH sin progestágeno, tamoxifeno, tumores de la granulosa). Se manifiesta como SUA y se diagnostica por **biopsia endometrial** (Pipelle) o histeroscopía.

- **Sin atipia** (simple o compleja): bajo riesgo de cáncer (< 5% a 20 años). Tratamiento: **progestágenos** (DIU de levonorgestrel 52 mg de primera elección, o acetato de medroxiprogesterona oral 10 mg/día 12-14 días al mes) y control con nueva biopsia a los 3-6 meses; corregir obesidad.

- **Con atipia** (neoplasia intraepitelial endometrioide): hasta 25-40% tiene un adenocarcinoma concomitante. Tratamiento: **histerectomía total** (± salpingooforectomía) en mujeres con paridad cumplida; si desea fertilidad, progestágenos a dosis altas con biopsias seriadas, derivando a ginecología oncológica. Pólipos: polipectomía histeroscópica.

TABLA 20.3.C · ARSENAL TERAPÉUTICO EN SANGRADO UTERINO ANORMAL NO ESTRUCTURAL (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA	FÁRMACO Y DOSIS	EFICACIA REDUCCIÓN SANGRADO	VENTAJAS Y CONSIDERACIONES
DIU-Levonorgestrel (Mirena)	Dispositivo intrauterino (libera 20 mcg/día de LNG)	85 - 95% a los 6 meses	Estándar de oro médico. Anticonceptivo y protector endometrial por 5 a 8 años.
Ácido Tranexámico	1 g cada 8 horas vía oral durante los días de sangrado activo	40 - 50%	No hormonal; ideal si desea fertilidad futura o contraindicación de estrógenos.
AINEs (Ácido Mefenámico)	500 mg cada 8 horas durante la menstruación	25 - 35%	Alivia simultáneamente la dismenorrea asociada. Reduce síntesis de PGs endometriales.
ACOs Combinados	Formulaciones monofásicas con 30 mcg etinilestradiol	50 - 60%	Regulariza el ciclo, reduce sangrado y aporta anticoncepción.
Estrógenos Conjugados EV	25 mg EV cada 4 a 6 horas (máximo 24-48 horas)	Control agudo de urgencia	Estimula epitelización endotelial rápida en hemorragia masiva inestable.

20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA))

- Clasificación FIGO PALM-COEIN: PALM = Estructurales (Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma, Malignidad).
- Causa más común de sangrado abundante severo en adolescentes: Coagulopatía (Enfermedad de von Willebrand).
- Toda paciente postmenopáusica con sangrado uterino DEBE recibir biopsia de endometrio (corte ecográfico > 4 mm).
- Tratamiento médico de máxima eficacia para SUA no estructural: DIU liberador de Levonorgestrel (Mirena).
- Tratamiento de urgencia en hemorragia masiva: Estrógenos conjugados EV o legrado hemostático.
- COEIN = No Estructurales (Coagulopatía, Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica, No clasificada).
- Biopsia endometrial ambulatoria (Pipelle): OBLIGATORIA en toda mujer ≥ 45 años con SUA.
- Mujeres < 45 años requieren biopsia si tienen factores de riesgo: Obesidad, SOP, tamoxifeno, Lynch.
- Ácido tranexámico oral: Antifibrinolítico no hormonal de elección si la paciente busca embarazo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 20.3

Mujer de 48 años, multípara de 2, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por menstruaciones abundantes con presencia de coágulos grandes, que duran entre 8 y 10 días, con intervalos irregulares de 21 a 40 días. Su último hemograma revela una hemoglobina de 9.2 g/dL y microcitosis. Al examen físico ginecológico: genitales externos normales, cuello uterino sano a la especuloscopía y útero de tamaño normal e indoloro. La ecografía transvaginal muestra un útero de 75 mm, miometrio homogéneo sin miomas y un grosor endometrial de 14 mm regular y homogéneo sin imágenes focales intrauterinas. La paciente pregunta cuál es el paso médico que corresponde realizar a continuación.

Conducta oficial razonada. Nos encontramos ante una paciente de 48 años que presenta un Sangrado Uterino Anormal (hipermenorrea y sangrado irregular) que le ha provocado anemia ferropénica. De acuerdo a las guías clínicas de la FIGO, ACOG y el consenso nacional del MINSAL, TODA paciente de 45 años o más que presente un sangrado uterino anormal tiene indicación estricta y mandatoria de una BIOPSIA ENDOMETRIAL (preferentemente mediante aspiración ambulatoria con cánula de Pipelle), con el fin primordial de descartar una hiperplasia endometrial con atipias o un adenocarcinoma de endometrio. Ningún tratamiento hormonal definitivo ni dispositivo intrauterino debe instalarse antes de tener confirmada la benignidad histológica del endometrio.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

1. Una paciente de 47 años consulta por sangrado uterino anormal de 4 meses de evolución, con menstruaciones abundantes y sangrados intermenstruales ocasionales. Al examen físico no se palpan masas pelvianas y la especuloscopía muestra cuello uterino macroscópicamente sano. La ecografía transvaginal informa útero de dimensiones normales y endometrio de 12 mm de grosor sin miomas ni pólipos identificables. ¿Cuál es la conducta médica de primera línea más adecuada antes de iniciar cualquier terapia hormonal?

A) Instalación inmediata de un DIU liberador de levonorgestrel sin estudios adicionales
B) Realización de una biopsia de endometrio ambulatoria con cánula de Pipelle
C) Histerectomía total abdominal profiláctica
D) Prescripción de ácido tranexámico oral y alta sin seguimiento
E) Observación durante 6 meses con calendario menstrual

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

2. Una adolescente de 14 años es traída a la urgencia por metrorragia abundante de 10 días de evolución desde su menarquia hace 4 meses, asociando astenia y palidez. No tiene antecedentes de actividad sexual. El hemograma muestra hemoglobina de 8.0 g/dL. En la anamnesis remota la madre refiere que la niña siempre ha presentado epistaxis frecuentes y equimosis fáciles ante traumatismos mínimos. ¿Cuál es la sospecha etiológica de causa no estructural (clasificación FIGO) más probable?

A) Adenomiosis uterina difusa
B) Coagulopatía congénita (Enfermedad de von Willebrand)
C) Adenocarcinoma de células claras de endometrio
D) Pólipo endometrial gigante
E) Leiomioma submucoso pediculado

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

3. ¿Cuál de los siguientes métodos terapéuticos médicos ha demostrado la mayor tasa de reducción del volumen de sangrado menstrual (superior al 90% a los 6 meses) y constituye el tratamiento médico de elección para el sangrado uterino anormal de causa endometrial o disovulatoria?

A) Ácido acetilsalicílico oral en dosis bajas
B) Dispositivo intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG)
C) Dispositivo intrauterino de Cobre (T de Cobre)
D) Anticonceptivos orales de solo progestágeno en dosis intermitentes
E) Vitamina K intramuscular semanal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

4. Una paciente de 56 años, menopáusica desde hace 5 años sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un episodio de sangrado vaginal rojo oscuro de 3 días de evolución. La especuloscopía descarta lesiones en cérvix y vagina. La ecografía transvaginal revela un endometrio engrosado de 9 mm, heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial prioritario que debe descartarse y la conducta obligatoria?

A) Descartar Cáncer de Endometrio mediante Biopsia Endometrial (Pipelle o histeroscópica)
B) Tratar como vaginitis atrófica con óvulos de estriol sin necesidad de biopsia
C) Indicar progestágenos orales por 10 días y reevaluar ecográficamente en 1 año
D) Indicar reposo en cama y control en APS si no repite el sangrado
E) Realizar laparoscopía exploradora de urgencia para ooforectomía bilateral

Más preguntas online de Sangrado Uterino Anormal →

20.4. Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.021 1.09.5.006

¿POR QUÉ?

Los Leiomiomas Uterinos (o fibromiomas) son los tumores benignos sólidos más comunes del aparato genital femenino, presentes en más del 50-70% de las mujeres a los 50 años. Se originan a partir de la proliferación clonal de células del músculo liso miometrial y su crecimiento es estrógeno y progesterona dependiente. La clasificación FIGO (grados 0 al 8) divide a los miomas según su relación con la cavidad endometrial y la serosa: los miomas submucosos (grados 0, 1 y 2) son los principales responsables de la hipermenorrea y la infertilidad por distorsión endometrial. Por su parte, la Adenomiosis es la presencia ectópica de glándulas endometriales en el miometrio, causando útero doloroso aumentado de tamaño y dismenorrea severa.

1. CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DE LOS MIOMAS (SISTEMA FIGO)

• **Submucosos (en contacto con la cavidad endometrial):** 3.01.1.021 Son los más sintomáticos y los que provocan **mayor sangrado (hipermenorrea abundante) e infertilidad**: **(ver Imagen 20.4A)**

- **FIGO 0:** Totalmente intracavitario, pediculado.

- **FIGO 1:** Intracavitario con componente intramural < 50%. **(ver Imagen 20.4B)**

- **FIGO 2:** Intracavitario con componente intramural ≥ 50%.

• **Intramurales (dentro del espesor miometrial):**

- **FIGO 3:** 100% intramural pero en contacto con el endometrio.

- **FIGO 4:** 100% intramural sin contacto con endometrio ni serosa.

- **FIGO 5:** Intramural con componente subseroso < 50%.

• **Subserosos (hacia la cavidad peritoneal):** Producen síntomas compresivos (polaquiuria, constipación) pero **habitualmente NO producen sangrado uterino aumentado**:

- **FIGO 6:** Subseroso con componente intramural < 50%.

- **FIGO 7:** Subseroso pediculado.

• **FIGO 8:** Otros (cervicales, parasitarios del ligamento ancho).

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DEGENERACIONES DE LOS MIOMAS

• **Clínica:** La gran mayoría (> 50-60%) son **completamente asintomáticos**. En sintomáticos: 3.01.1.021

- **Hemorragia Uterina Anormal:** Síntoma más frecuente (hipermenorrea / sangrado menstrual abundante y prolongado con coágulos, llevando a anemia ferropénica).

- **Síntomas Compresivos y Dolor Pélvico:** Sensación de peso hipogástrico, tenesmo vesical o polaquiuria por compresión de vejiga, hidronefrosis por compresión ureteral y constipación por compresión rectal.

• **Degeneraciones Típicas:**

- **Degeneración Hialina:** La más frecuente (60%). Sustitución por tejido conjuntivo acelular.

- **Degeneración Roja (Necrobiosis aséptica):** Complicación típica durante el **segundo o tercer trimestre del EMBARAZO** por rápido crecimiento que supera el aporte vascular, provocando infarto hemorrágico miomatoso con dolor abdominal agudo severo, fiebre moderada y leucocitosis (tratamiento conservador con analgesia e hidratación; ¡NO se opera durante el embarazo!).

- **Degeneración Quística y Calcificada:** Frecuente en la postmenopausia.

- **Degeneración Sarcomatosa (Leiomiosarcoma):** Extraordinariamente rara (< 0.5%). Sospechar ante un mioma que crece rápidamente en una mujer postmenopáusica. **(ver Imagen 20.4C)**

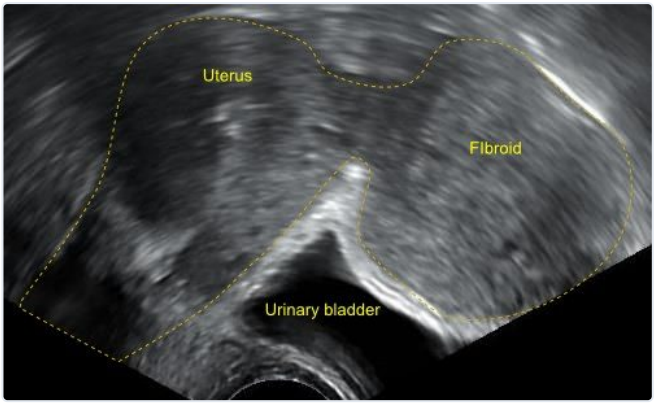
3. MANEJO FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO DE LA MIOMATOSIS

• **Miomas Asintomáticos: CONDUCTA EXPECTANTE**. No requieren tratamiento médico ni quirúrgico; solo controles periódicos. 3.01.1.021

• **Manejo Médico Farmacológico:**

- Sintomático de sangrado: **DIU liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG)** (reduce sangrado en miomas intramurales que no distorsionan la cavidad); Ácido Tranexámico y AINEs.

- **Análogos de GnRH (Leuprolide):** Producen hipoestrogenismo profundo con reducción del 30-50% del volumen del mioma. Indicados exclusivamente como **terapia preoperatoria por 3 a 6 meses** para corregir anemia severa y reducir el tamaño antes de la cirugía.



Ecografía transvaginal legible de mioma

• **Manejo Quirúrgico (Indicado ante hipermenorrea refractaria con anemia, compresión de órganos vecinos o miomas submucosos que causan infertilidad):**

- **Miomectomía Histeroscópica:** De elección para miomas **submucosos FIGO 0 y 1** (y algunos FIGO 2 seleccionados) menores de 4-5 cm.

- **Miomectomía Laparoscópica o por Laparotomía:** Extirpación exclusiva de los miomas conservando el útero. De elección en **mujeres que desean preservar la fertilidad**.

- **Histerectomía Total:** Extirpación del útero (laparoscópica, abdominal o vaginal). Es el **tratamiento curativo y definitivo de elección en mujeres con paridad satisfecha**.

- **Embolización de Arterias Uterinas (EAU):** Opción no quirúrgica mediante cateterismo femoral para ocluir las arterias uterinas, produciendo necrosis isquémica de los miomas.

4. TACTO GINECOLÓGICO (BIMANUAL Y RECTOVAGINAL): TÉCNICA Y HALLAZGOS

• **Tacto ginecológico (procedimiento: Realizar):** con la paciente en **posición de litotomía**, vejiga vacía, explicando cada paso y con guantes lubricados. Se examina primero la vulva y se palpan glándulas de Bartolino y Skene; luego se introducen el índice y el medio en la vagina mientras la **mano abdominal** comprime hacia abajo el hipogastrio (**tacto bimanual**). 1.09.5.006

- **Útero:** posición (anteversoflexión vs retroversión), tamaño, forma, consistencia, movilidad y dolor. Miomatosis: aumentado, **irregular, duro y generalmente indoloro**; adenomiosis: **globuloso, blando y doloroso**; embarazo: blando y aumentado de tamaño; fijo y con nódulos en los ligamentos uterosacros: endometriosis profunda.

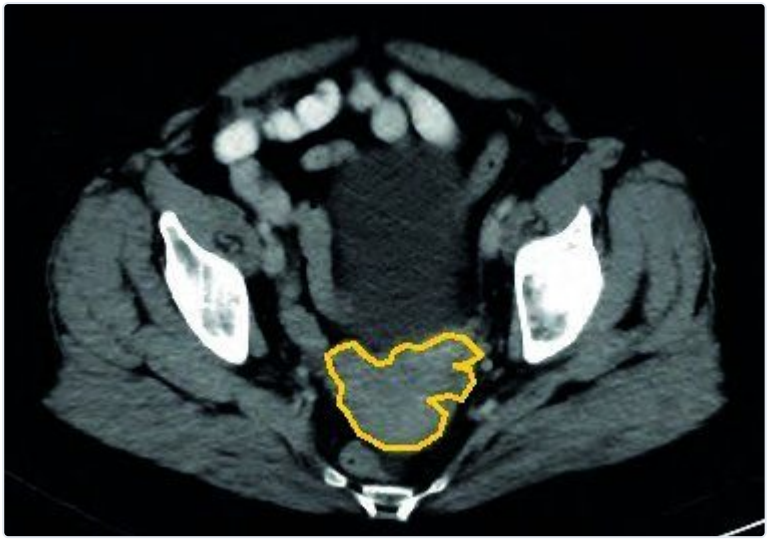
- **Anexos y fondos de saco:** masas anexiales (tamaño, consistencia, movilidad, dolor), dolor a la **movilización del cuello** (EIP) y abombamiento doloroso del fondo de saco de Douglas (absceso o hemoperitoneo). El **tacto rectovaginal** evalúa septum rectovaginal, ligamentos uterosacros y parametrios (extensión del cáncer cervicouterino).

- **Masas u obstrucción:** un mioma grande, un útero grávido retroverso incarcerado o una masa pelviana pueden comprimir la uretra o los uréteres y producir **retención urinaria o hidronefrosis**: el tacto ginecológico permite identificar la masa causal y se complementa con ecografía.



A. CLASIFICACIÓN FIGO

B. MIOMA INTRAMURAL



C. MIOMA QUE COMPRIME EL RECTO

Imagen 20.4

FIGURA 20.4 · ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA MIOMATOSIS UTERINA SEGÚN SÍNTOMAS Y DESEO DE FERTILIDAD

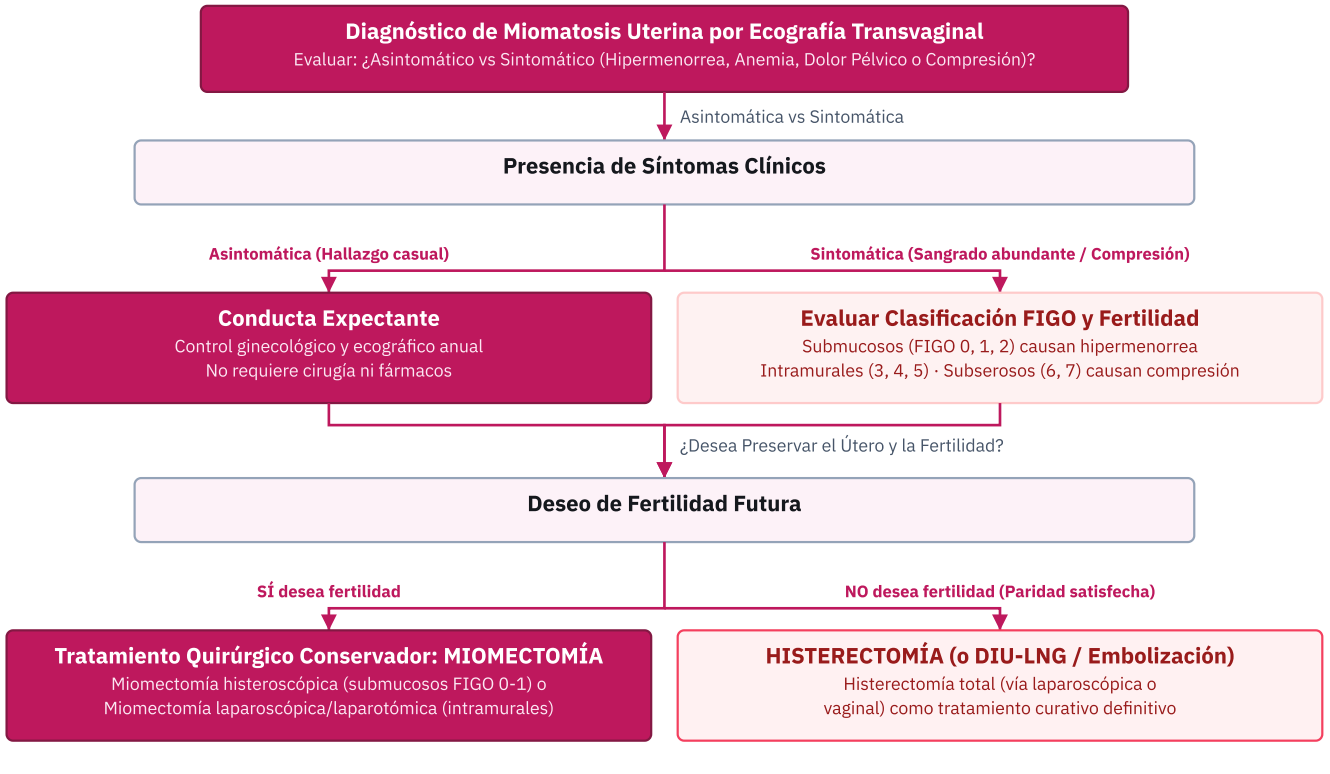


TABLA 20.4 · CLASIFICACIÓN FIGO DE LOS LEIOMIOMAS UTERINOS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 3.01.1.021, 1.09.5.006

CLASIFICACIÓN FIGO	LOCALIZACIÓN ANATÓMICA	MANIFESTACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	ABORDAJE QUIRÚRGICO PREFERENTE
FIGO 0	Submucoso pediculado 100% intracavitario	Hipermenorrea severa, sangrado intermenstrual	Miomectomía Histeroscópica
FIGO 1	Submucoso con extensión intramural < 50%	Hipermenorrea, anemia ferropénica	Miomectomía Histeroscópica
FIGO 2	Submucoso con extensión intramural ≥ 50%	Hipermenorrea, dismenorrea	Miomectomía Histeroscópica / Laparoscópica
FIGO 3	100% Intramural en contacto con endometrio	Hipermenorrea moderada	Miomectomía Laparoscópica / Histerectomía
FIGO 4	100% Intramural puro sin contacto seroso/mucoso	Asintomático o hipermenorrea	Manejo médico / Miomectomía
FIGO 5	Subseroso con extensión intramural ≥ 50%	Síntomas compresivos leves	Laparoscopía si sintomático
FIGO 6	Subseroso con extensión intramural < 50%	Compresión vesical / rectal	Miomectomía Laparoscópica
FIGO 7	Subseroso pediculado peritoneal	Masa palpable, riesgo de torsión aguda	Miomectomía Laparoscópica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.4

Paciente de 38 años, multípara de 2 con paridad cumplida, consulta por menstruaciones extremadamente abundantes con coágulos gigantes de 8 días de duración desde hace 1 año, asociando astenia progresiva. Su hemoglobina actual es de 8.8 g/dL. Al examen físico se palpa un útero aumentado de tamaño equivalente a 12 semanas de gestación, de superficie nodular e indoloro. La ecografía transvaginal revela un útero con tres miomas intramurales de 4, 5 y 6 cm de diámetro que no contactan con la cavidad endometrial. El legrado biopsia endometrial ambulatorio resultó proliferativo benigno sin atipias. La paciente refiere haber completado su deseo de tener hijos y solicita una solución definitiva que resuelva su sangrado y anemia.

Conducta oficial. Nos encontramos ante una paciente con Miomatosis Uterina Sintomática (hipermenorrea severa con anemia ferropénica secundaria y útero aumentado de tamaño a 12 semanas). Al tratarse de una mujer con paridad cumplida que no desea fertilidad futura, con confirmación de benignidad endometrial previa y fracaso o desestimación del manejo médico, el tratamiento curativo definitivo de elección es la Histerectomía Total (preferentemente por vía laparoscópica o abdominal según experiencia quirúrgica). Si la paciente hubiera manifestado deseo de conservar el útero o tener más hijos, la alternativa conservadora de elección habría sido una miomectomía o la colocación de un DIU-Levonorgestrel.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Los miomas son los tumores benignos sólidos más comunes del aparato genital femenino.
- Miomas submucosos (FIGO 0, 1 y 2): Son los que más sangran y causan infertilidad.
- Miomas subserosos (FIGO 6 y 7): Provocan síntomas compresivos (vejiga/recto) sin aumentar el sangrado.
- Miomas asintomáticos: Conducta expectante y control anual (NO se operan de rutina).
- Degeneración roja: Infarto aséptico doloroso típico del embarazo; manejo médico analgésico.
- Tratamiento de mioma submucoso FIGO 0-1 sintomático: Miomectomía histeroscópica ambulatoria.
- Mujer que desea preservar fertilidad: Miomectomía conservadora.
- Mujer con paridad satisfecha y sangrado severo: Histerectomía total como curación definitiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.021

1. Una paciente de 34 años, nuligesta, que desea embarazarse en el corto plazo, consulta por hipermenorrea de 7 meses de evolución. En la ecografía transvaginal e histerosonografía se identifica un leiomioma submucoso único de 3.5 cm de diámetro localizado en la pared anterior con protrusión del 80% hacia la cavidad endometrial (FIGO 1). El resto del miometrio es normal. ¿Cuál es el tratamiento de elección para esta paciente?

A) Histerectomía total por vía laparoscópica
B) Resección del mioma mediante Miomectomía Histeroscópica
C) Embolización de arterias uterinas bilateral
D) Administración continua de análogos de GnRH durante 5 años
E) Radioterapia pélvica fraccionada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.021

2. Una embarazada de 22 semanas consulta en la urgencia por dolor abdominal agudo intenso en hipogastrio y flanco derecho de 12 horas de evolución, asociado a febrícula de 37.8°C y náuseas. Al examen físico: abdomen muy sensible a la palpación en fosa ilíaca derecha, donde se palpa una masa nodular de 7 cm dolorosa dependiente del miometrio anterior, sin dinámica uterina. El monitoreo cardiofetal muestra feto reactivo de 145 lpm. La ecografía confirma un mioma intramural con ecos heterogéneos internos y áreas de licuefacción. El hemograma muestra leucocitosis de 13.500 /mm³ sin desviación izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada?

A) Apendicitis aguda complicada; laparotomía de urgencia
B) Degeneración roja (necrobiosis) de un mioma uterino; manejo médico conservador con reposo, hidratación y analgesia
C) Rotura uterina inminente; cesárea de emergencia
D) Leiomiosarcoma uterino; histerectomía total inmediata
E) Corioamnionitis clínica; inducción inmediata del parto

Más preguntas online de Patología Benigna Uterina →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 20.1 A 20.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	Fase folicular: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.	**Pico de LH: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por 48h; induce la...**	Primer paso ante amenorrea secundaria: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.
Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	Criterios de Rotterdam (se requieren 2 de 3): Oligo/anovulación + Hiperandrogenismo +...	**Criterio ecográfico actual: ≥ 20 folículos de 2-9 mm en al menos un ovario o volumen...**	—
Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	Clasificación FIGO PALM-COEIN: PALM = Estructurales (Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma...	**COEIN = No Estructurales (Coagulopatía, Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica, No...**	Toda paciente postmenopáusica con sangrado uterino DEBE recibir biopsia de endometrio...
Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis	Los miomas son los tumores benignos sólidos más comunes del aparato genital femenino.	**Miomas submucosos (FIGO 0, 1 y 2): Son los que más sangran y causan infertilidad.**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Fase folicular: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.

Pico de LH: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por 48h; induce la ovulación a las 36 horas.

Primer paso ante amenorrea secundaria: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.

Test de progesterona positivo (sangra): Indica anovulación con estrógenos presentes (clásico de SOP).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Pico de LH: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por 48h; induce la ovulación a las 36 horas.
- Primer paso ante amenorrea secundaria: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.
- Criterio ecográfico actual: ≥ 20 folículos de 2-9 mm en al menos un ovario o volumen ovárico > 10 mL.
- Descarte obligatorio de hiperplasia suprarrenal no clásica: Medir 17-OH Progesterona matinal.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Fase folicular: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.	Tema 20.1 →
Criterios de Rotterdam (se requieren 2 de 3): Oligo/anovulación + Hiperandrogenismo + Ecografía ovárica...	Tema 20.2 →
Clasificación FIGO PALM-COEIN: PALM = Estructurales (Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma, Malignidad).	Tema 20.3 →
Los miomas son los tumores benignos sólidos más comunes del aparato genital femenino.	Tema 20.4 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
20.5	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	27
20.6	Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	32
20.7	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	35
20.8	Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	40

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.015, 3.01.1.014	Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Específico	Completo	Completo
3.01.1.026, 3.01.1.032	Prolapso de Órganos Pélvicos	Específico	Completo	Completo
3.01.1.020, 3.01.4.001, 4.03.1.017, 1.03.4.009	Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Específico	Inicial	Completo
3.01.3.008, 3.01.3.006	Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Fisiopatología: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica estrógeno-dependiente.
- Tríada cardinal clásica: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad.
- Localización anatómica más frecuente: Ovarios (Endometrioma o 'quiste de chocolate').
- Ecografía transvaginal del endometrioma: Quiste homogéneo con ecos finos en 'vidrio esmerilado' sin papilas.
- Estándar de oro imagenológico en endometriosis profunda: Resonancia Magnética (RMN) de pelvis.
- Estándar de oro diagnóstico definitivo: Laparoscopía quirúrgica con confirmación histopatológica.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	EUNACOM Julio 2025 · #54 · EUNACOM Diciembre 2025 · #53 · EUNACOM Diciembre 2024 · #136 · EUNACOM Enero 2023 · #60
Prolapso de Órganos Pélvicos	EUNACOM Julio 2019 · #45 · EUNACOM Julio 2018 · #110 · EUNACOM Julio 2017 · #143 · EUNACOM Julio 2015 · #47
Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	EUNACOM Agosto 2021 · #146 · EUNACOM Julio 2019 · #109 · EUNACOM Diciembre 2019 · #108 · EUNACOM Diciembre 2017 · #162
Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	EUNACOM Diciembre 2024 · #10 · EUNACOM Enero 2023 · #44 · EUNACOM Enero 2023 · #45 · EUNACOM Diciembre 2022 · #172

20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.015 3.01.1.014

¿POR QUÉ?

La Endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial funcional (glándulas y estroma) fuera de la cavidad uterina. Afecta al 10-15% de las mujeres en edad reproductiva y hasta al 40-50% de las mujeres con dolor pélvico crónico o infertilidad. Su patogenia clásica se atribuye a la teoría de la menstruación retrógrada de Sampson, con adhesión, invasión y proliferación estrógeno-dependiente de células endometriales en el peritoneo pélvico y ovarios. La tríada clínica clásica de dismenorrea progresiva severa que no cede con AINEs habituales, dispareunia profunda e infertilidad es de altísima rentabilidad para el EUNACOM. El pilar médico actual descansa en los progestágenos continuos (Dienogest) y el abordaje quirúrgico laparoscópico reservado para dolor refractario o endometriomas voluminosos.

1. FISIOPATOLOGÍA Y LOCALIZACIONES DE LA ENDOMETRIOSIS

• **Fisiopatología:** Es una enfermedad inflamatoria crónica estrógeno-dependiente. La teoría más aceptada es la **menstruación retrógrada (Sampson)**, donde fragmentos endometriales viables refluyen a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad peritoneal durante la menstruación, logrando implantarse gracias a un ambiente peritoneal de disfunción inmunológica, angiogénesis patológica y resistencia a la progesterona. 3.01.1.015

• **Localizaciones Anatómicas Más Frecuentes:**

- **1. Ovarios (la localización más común, > 60-70%):** Forma los llamados **Endometriomas ováricos o 'quistes de chocolate'** (colecciones quísticas de sangre degradada y hemosiderina).

- **2. Fondo de saco de Douglas y ligamentos útero-sacros:** Provocan retroversión uterina fija y dolor exquisito al tacto.

- **3. Tabique rectovaginal y serosa del colon sigmoides / recto:** Causan disquecia cíclica.

- **4. Vejiga y uréteres:** Disuria cíclica y hematuria catamenial.

- **5. Localizaciones extrapélvicas raras:** Pleura y diafragma (neumotórax catamenial) o cicatriz de cesárea previa.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y HALLAZGOS DIAGNÓSTICOS

• **La Tríada Clásica de Síntomas Cardinales (Pregunta Fija EUNACOM):** 3.01.1.015

- **1) Dismenorrea Secundaria Progresiva e Incapacitante:** Dolor cólico pelviano intenso que empeora con el paso de los años, comienza días antes de la regla, persiste durante el sangrado y es refractario al uso de AINEs comunes. 3.01.1.015 3.01.1.014

- **2) Dispareunia Profunda:** Dolor intenso durante las relaciones sexuales con la penetración profunda (por tracción de los ligamentos uterosacros y tabique rectovaginal afectados).

- **3) Infertilidad / Esterilidad (30-50% de las pacientes):** Por distorsión anatómica tubárica, adherencias pélvicas densas ('pelvis congelada') y citocinas inflamatorias que alteran la motilidad espermática y la implantación. 3.01.1.015

- *Otros síntomas asociados:* Dolor pélvico crónico no cíclico, **disquecia** (dolor al defecar durante la menstruación) y disuria catamenial. 3.01.1.015 3.01.1.014

• **Examen Físico:** Útero en retroversión fija, dolor exquisito a la lateralización cervical y **palpación de nódulos dolorosos firmes en el fondo de saco posterior y ligamentos uterosacros**. 3.01.1.015

• **Estudio por Imágenes y Estándar de Oro:**

- **Ecografía Transvaginal Especializada:** Identifica con alta precisión el **Endometrioma Ovárico** como una masa quística con **ecos internos finos homogéneos en 'vidrio esmerilado' (ground glass)**, sin tabiques gruesos ni vascularización Doppler interna. **(ver Imagen 20.5A y B)**

- **Resonancia Magnética (RMN) Pélvica:** Es el estándar de oro imagenológico para mapear la **Endometriosis Profunda Infiltrante (EPI)** en ligamentos uterosacros, tabique rectovaginal e intestino.

- **Laparoscopía Quirúrgica con Biopsia:** Es el estándar de oro diagnóstico definitivo, permitiendo visualizar los implantes endometriósicos (lesiones en 'quemadura de pólvora', rojas o vesiculares) y confirmar glándulas y estroma endometrial con macrófagos cargados de hemosiderina. **(ver Imagen 20.5C)**

TABLA 20.5.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y TERAPÉUTICO ENTRE ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS 3.01.1.015, 3.01.1.014

PARÁMETRO	ENDOMETRIOSIS PÉLVICA	ADENOMIOSIS UTERINA
Definición Histológica	Glándulas y estroma endometrial FUERA del útero (ovarios, peritoneo)	Glándulas y estroma endometrial EN EL ESPESOR del miometrio
Edad Típica	Mujeres jóvenes en edad reproductiva (20 a 35 años)	Mujeres multíparas de 35 a 50 años
Síntomas Cardinales	Dismenorrea progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad	Hipermenorrea abundante + Dismenorrea secundaria tardía
Examen Físico	Útero en retroversión fija, ligamentos uterosacros nodulares dolorosos	Útero aumentado de tamaño difuso, blando, globuloso y doloroso
Ecografía Transvaginal	Endometrioma ovárico en 'vidrio esmerilado', adherencias	Miometrio heterogéneo con sombras en 'rayos solares' y asimetría
Manejo Médico	Dienogest 2 mg continuo, ACOs continuos, DIU-LNG	DIU-Levonorgestrel (Mirena), Ácido Tranexámico, AINEs
Tratamiento Quirúrgico	Cistectomía ovárica laparoscópica / escisión de implantes	Histerectomía total (curativo en paridad satisfecha)

20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO DE LA ENDOMETRIOSIS

• **Objetivo del Tratamiento:** El tratamiento depende estrictamente de si el motivo de consulta principal es el **Dolor Pélvico** o el **Deseo de Embarazo (Infertilidad)**. 3.01.1.015

• **Manejo del DOLOR PÉLVICO (Mujer sin deseo gestacional inmediato):** 3.01.1.015

3.01.1.014

- **1.ª Línea: PROGESTÁGENOS CONTINUOS: DIENOGEST 2 mg al día vía oral continuo** (progestágeno de 4.ª generación que induce decidualización y atrofia marcada de los focos endometriósicos sin efectos androgénicos). Alternativas excelentes: DIU liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG), implante de Etonogestrel o Anticonceptivos Hormonales Combinados en pauta continua sin descansos (para inducir amenorrea).

- **2.ª Línea: Análogos de la GnRH (Leuprolide, Goserelina):** Suprimen completamente el eje hipotálamo-hipofisario induciendo una 'menopausia médica temporal'. Limitados a un máximo de 6 meses por riesgo de desmineralización ósea severa, salvo que se asocien a terapia 'add-back' (dosis bajas de estrógenos/progestágenos).

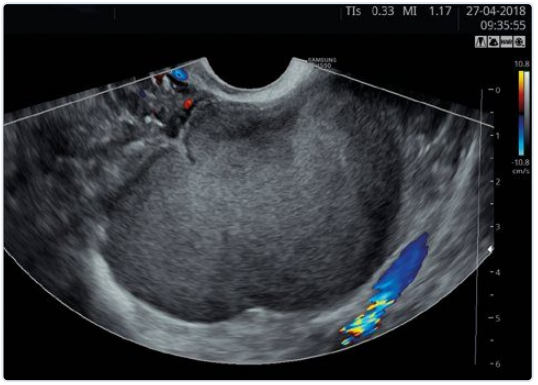
• **Manejo de la INFERTILIDAD:** 3.01.1.015

- ¡El tratamiento hormonal médico (ACOs, dienogest, GnRH) **NO mejora la fertilidad** y solo retrasa la búsqueda de embarazo!

- La conducta consiste en **Laparoscopía quirúrgica conservadora** (cistectomía ovárica de endometriomas > 3-4 cm respetando la corteza sana y lisis de adherencias) para restaurar la anatomía o derivación directa a **Técnicas de Reproducción Asistida de Alta Complejidad (FIV)**.



A. ENDOMETRIOMA



B. ENDOMETRIOMA CON DOPPLER



C. IMPLANTES EN LAPAROSCOPÍA

Imagen 20.5

FIGURA 20.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ENDOMETRIOSIS

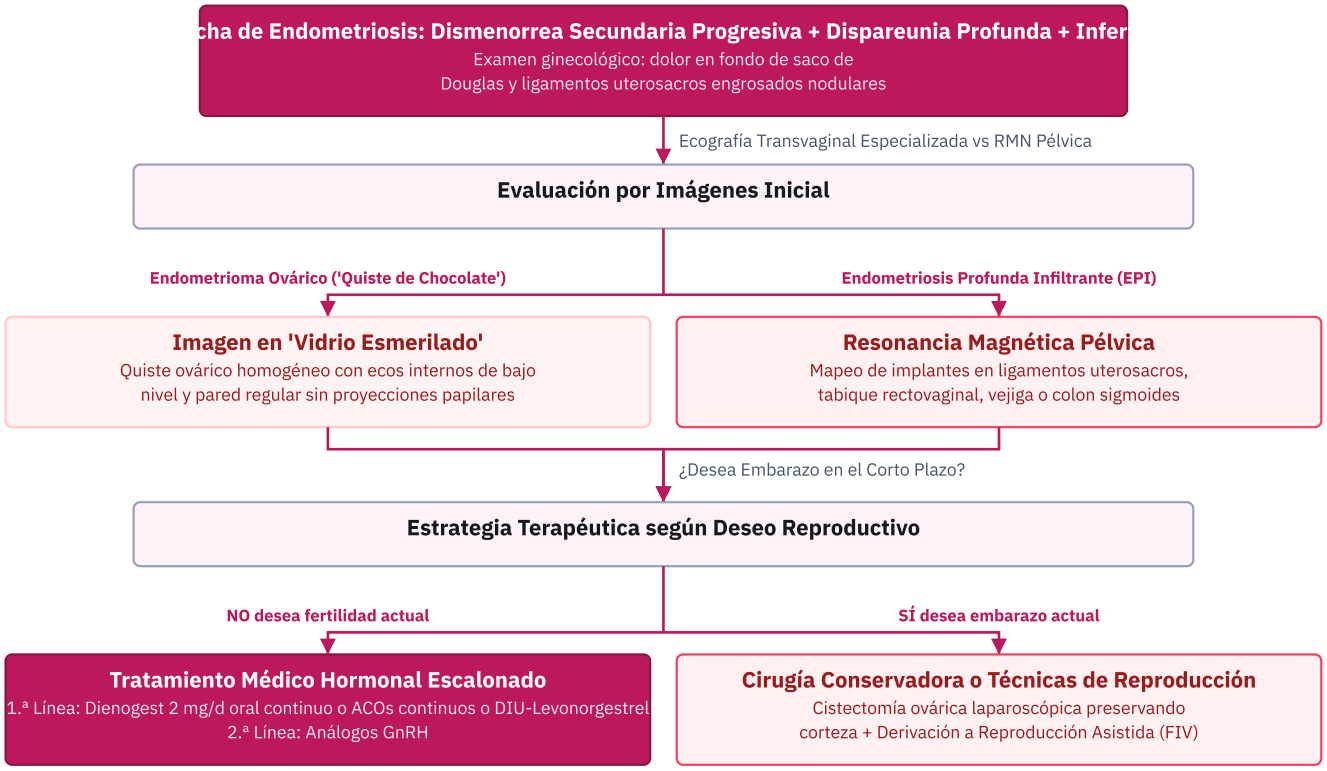


TABLA 20.5.B · CRITERIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA LAPAROSCÓPICA EN ENDOMETRIOSIS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

INDICACIÓN QUIRÚRGICA	HALLAZGOS CLÍNICOS Y PARÁMETROS	TÉCNICA QUIRÚRGICA DE ELECCIÓN
Endometrioma Ovárico Voluminoso	Quiste ovárico endometriósico ≥ 3 a 4 cm de diámetro o dolor refractario	Cistectomía ovárica laparoscópica por enucleación de cápsula (evitar ooforectomía)
Dolor Pélvico Refractario Severo	Falla persistente de al menos dos líneas de terapia médica hormonal continua	Laparoscopía diagnóstica y terapéutica con escisión/vaporización de implantes peritoneales
Endometriosis Infiltrante con Obstrucción	Compromiso urétrico con hidronefrosis o estenosis luminal intestinal sintomática	Cirugía laparoscópica multidisciplinaria con resección segmentaria
Infertilidad Mecánica Tuboperitoneal	Distorsión anatómica con bloqueo tubárico por adherencias densas	Salpingolisis, fimbrioplastía y remoción de bridas para permeabilizar trompas

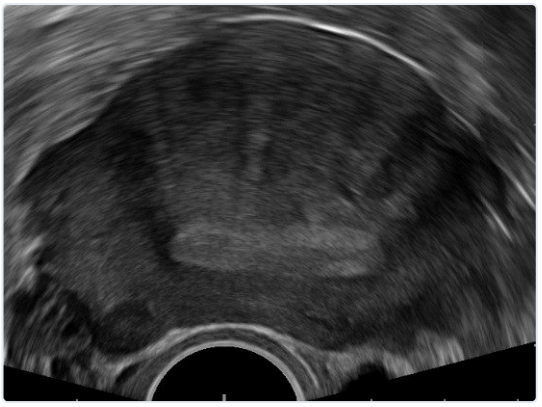
20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DISMENORREA PRIMARIA Y OTRAS CAUSAS DE DOLOR PELVIANO

• **Dismenorrea primaria (Sospecha / Inicial / Derivar):** dolor 3.01.1.014 cólico hipogástrico que comienza con el sangrado o pocas horas antes y dura **8-72 horas**, irradiado a la región lumbar y muslos, con náuseas, diarrea o cefalea. Aparece **6-12 meses tras la menarquia** (al instalarse los ciclos ovulatorios) y el examen físico y la ecografía son normales. Se debe a exceso de **prostaglandinas F2α** endometriales.

- **Tratamiento: AINE** (ibuprofeno 400 mg c/8 h, naproxeno 500 mg c/12 h o ácido mefenámico 500 mg c/8 h) iniciados al comenzar el dolor o el sangrado, calor local y ejercicio; **anticonceptivos hormonales** si además desea anticoncepción o hay falla de AINE. Si no responde en 3 meses: buscar causa secundaria (laparoscopía).

- **Dismenorrea secundaria:** endometriosis, adenomiosis, miomas, EIP, DIU de cobre, estenosis cervical o malformaciones müllerianas obstructivas; el dolor es progresivo, de inicio tardío y a veces no cíclico.



Ecografía de adenomiosis

• **Dolor pelviano crónico** (> 6 meses): causas ginecológicas (endometriosis, adherencias por EIP, congestión pélvica, ovario residual), urinarias (cistitis intersticial/síndrome de vejiga dolorosa), digestivas (colon irritable, constipación), musculoesqueléticas (miofascial, neuralgia del pudendo) y psicosociales (antecedente de abuso). Se estudia con anamnesis dirigida, tacto bimanual, ecografía TV y, si persiste, laparoscopía; se **deriva** a ginecología.

TABLA 20.5.C · ESQUEMAS TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS OFICIALES EN ENDOMETRIOSIS (MINSAL / ESHRE) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / MODALIDAD	DOSIS Y POSOLOGÍA	MECANISMO DE ACCIÓN	EFECTOS SECUNDARIOS PRINCIPALES
Dienogest (1.ª Línea de Elección)	2 mg vía oral una vez al día de forma continua (sin descansos)	Progestágeno sintético: anovulación, decidualización y atrofia de focos	Spotting irregular en primeros meses, cefalea, cambios de humor.
ACOs Combinados Continuos	1 comprimido diario continuo sin descanso de 7 días	Inhibición del eje y amenorrea inducida farmacológicamente	Riesgo trombótico según criterios de elegibilidad OMS.
DIU-Levonorgestrel	Dispositivo intrauterino (20 mcg/día)	Atrofia endometrial profunda local y reducción de dismenorrea	Sangrado intermenstrual inicial, excelente tolerancia a largo plazo.
Análogos GnRH (Leuprolide)	3.75 mg IM mensual o 11.25 mg trimestral por máximo 6 meses	Hipoestrogenismo severo ('menopausia médica')	Sofocos, sequedad vaginal, pérdida de densidad mineral ósea (osteopenia).

20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS)

- Fisiopatología: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica estrógeno-dependiente.
- Localización anatómica más frecuente: Ovarios (Endometrioma o 'quiste de chocolate').
- Estándar de oro imagenológico en endometriosis profunda: Resonancia Magnética (RMN) de pelvis.
- Tratamiento médico de elección para dolor pélvico: Dienogest 2 mg/día oral continuo o ACOs continuos.
- Tratamiento ante infertilidad y endometrioma > 4 cm: Cistectomía ovárica laparoscópica o FIV.
- Tríada cardinal clásica: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad.
- Ecografía transvaginal del endometrioma: Quiste homogéneo con ecos finos en 'vidrio esmerilado' sin papilas.
- Estándar de oro diagnóstico definitivo: Laparoscopía quirúrgica con confirmación histopatológica.
- Los fármacos hormonales NO mejoran la fertilidad; no deben administrarse si desea embarazo inmediato.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 20.5

Paciente de 27 años, nuligesta, consulta por dismenorrea intensa e invalidante de 3 años de evolución, que ha empeorado progresivamente y no cede con ibuprofeno ni ketoprofeno. Además, refiere dolor profundo durante las relaciones sexuales (dispareunia profunda) y refiere haber intentado concebir con su pareja sin éxito durante 18 meses. Al examen ginecológico se constata útero en retroversión fija, con exquisita sensibilidad y palpación de pequeños nódulos firmes dolorosos en el fondo de saco de Douglas y ligamentos uterosacros. La ecografía transvaginal revela en el ovario izquierdo una formación quística unilocular de 4.2 cm con contenido ecogénico fino homogéneo en 'vidrio esmerilado', sin nódulos sólidos murales ni flujo al Doppler color.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico de dismenorrea secundaria progresiva severa refractaria a AINEs, dispareunia profunda e infertilidad conyugal primaria de 18 meses, asociado al hallazgo semiológico de nódulos dolorosos en fondo de saco de Douglas y la imagen ecográfica patognomónica de un endometrioma ovárico en 'vidrio esmerilado' (quiste de chocolate) de 4.2 cm, confirma el diagnóstico de Endometriosis Moderada a Severa (con endometrioma ovárico). Dado que la paciente consulta primordialmente por deseo de fertilidad activa y presenta un endometrioma mayor a 4 cm con sospecha de adherencias pelvianas, la conducta médica indicada es la derivación a ginecología para resolución quirúrgica conservadora mediante laparoscopía (cistectomía ovárica conservando corteza sana, lisis de adherencias y confirmación histopatológica) o derivación expedita a Técnicas de Reproducción Asistida de Alta Complejidad (FIV). No se debe indicar tratamiento médico hormonal exclusivo si la paciente desea un embarazo inmediato.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

1. Una paciente de 26 años consulta por dismenorrea secundaria severa que le impide asistir al trabajo durante sus menstruaciones, dispareunia profunda y dispareunia al defecar (disquecia) durante los días de sangrado. Al tacto bimanual se palpa el útero en retroversoflexión fija con gran sensibilidad en los ligamentos uterosacros. La ecografía ginecológica muestra un quiste ovárico derecho de 3.5 cm con ecos internos homogéneos de bajo nivel en 'vidrio esmerilado'. La paciente no desea embarazo en la actualidad. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico oral de primera línea de elección para el control de sus síntomas dolorosos?

A) Paracetamol 500 mg cada 12 horas solo durante el sangrado
B) Dienogest 2 mg al día por vía oral de forma continua
C) Metotrexato intramuscular a dosis única
D) Citrato de Clomifeno oral por 5 días cada mes
E) Terapia de reemplazo hormonal con estrógenos equinos solos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

2. Una mujer de 30 años, con antecedente de dolor pélvico crónico e infertilidad primaria de 2 años, se somete a una ecografía transvaginal que revela un quiste ovárico de 5 cm de diámetro de pared delgada, regular, con ecogenicidad interna difusa y homogénea de bajo nivel ('aspecto en vidrio esmerilado'), sin flujo Doppler al interior y sin excrecencias papilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta lesión ovárica?

A) Cistoadenocarcinoma seroso de ovario
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma quístico maduro (quiste dermoide)
D) Quiste folicular simple funcional
E) Absceso tubo-ovárico roto

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

3. ¿Por qué razón farmacológica el tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales combinados o progestágenos continuos NO está indicado como tratamiento de la infertilidad en una paciente con endometriosis que busca activamente un embarazo?

A) Porque son teratogénicos irreversibles para cualquier ovocito futuro
B) Porque suprimen la ovulación y no mejoran las tasas de fertilidad ni de nacidos vivos tras suspenderlos, retrasando el tratamiento reproductivo efectivo
C) Porque causan oclusión tubárica bilateral irreversible por fibrosis miometrial
D) Porque aumentan la incidencia de embarazo molar recurrente
E) Porque aceleran la apoptosis de la reserva folicular ovárica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

4. Una paciente de 42 años, multípara de 3, consulta por hipermenorrea severa y dismenorrea secundaria progresiva. Al examen físico se palpa un útero aumentado de tamaño difusamente de 11 semanas, simétrico, reblandecido y difusamente doloroso al tacto bimanual. La ecografía transvaginal muestra engrosamiento asimétrico del miometrio posterior con estriaciones lineales y microquistes miometriales. La biopsia endometrial es benigna. Tras fallar el tratamiento médico, se decide una histerectomía total. ¿Qué hallazgo anatomopatológico confirmará el diagnóstico definitivo?

A) Glándulas y estroma endometrial ectópicos en el espesor del miometrio con hipertrofia muscular concéntrica (Adenomiosis)
B) Proliferación clonal de células fusiformes de músculo liso miometrial (Leiomioma)
C) Infiltración estromal por células mesenquimatosas malignas con atipias (Leiomiosarcoma)
D) Pólipo vascular fibroepitelial endocervical
E) Tejido decidual ectópico confinado exclusivamente a la serosa peritoneal

Más preguntas online de Endometriosis y Adenomiosis →

20.6. Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.026 3.01.1.032

¿POR QUÉ?

Los trastornos del suelo pélvico comprenden el Prolapso de Órganos Pélvicos (POP) y la Incontinencia Urinaria (IU), patologías que impactan severamente la calidad de vida de las mujeres adultas. La clasificación POP-Q de la ICS estandariza la cuantificación del prolapso utilizando el himen como plano de referencia anatómico cero. Por su parte, la diferenciación semiológica y terapéutica entre la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) y la Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU) es una pregunta obligada de examen: la IUE es un problema anatómico de soporte que se resuelve con cabestrillos mediouretrales (TOT/TVT), mientras que la IUU es una disfunción funcional del detrusor que se trata con medidas conductuales y antimuscarínicos (oxibutinina/solifenacina) o mirabegrón, estando FORMALMENTE CONTRAINDICADA la cirugía en la urgencia pura.

1. PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS (POP) Y SISTEMA POP-Q

• **Definición:** Descenso de uno o más de los compartimentos 3.01.1.026 de la pared vaginal y órganos pélvicos adyacentes: pared anterior (cistocele / uretrocele), pared posterior (rectocele) y compartimento apical (histerocele o prolapso de cúpula vaginal tras histerectomía). **(ver Imagen 20.6A)**



Prolapso genital / cistocele

• **Factores de Riesgo Mayores:** Multiparidad y partos vaginales traumáticos instrumentales (fórceps), edad avanzada y menopausia (hipoestrogenismo con pérdida de colágeno), sobrepeso u obesidad, y aumento crónico de la presión intraabdominal (tos crónica, constipación, esfuerzos físicos pesados).

• **Estadificación POP-Q (Referencia: Anillo Himenal = 0 cm):**

- **Estadio 0:** Sin prolapso; todos los puntos se encuentran a -3 cm.

- **Estadio I:** El punto de mayor descenso está a **más de 1 cm por encima del himen (< -1 cm)**.

- **Estadio II:** El punto de mayor descenso se sitúa **entre 1 cm por encima y 1 cm por debajo del himen (entre -1 cm y +1 cm)**.

- **Estadio III:** El punto de mayor descenso se encuentra a **más de 1 cm por debajo del himen (> +1 cm)**, pero sin evertir totalmente la vagina.

- **Estadio IV:** Prolapso total / Procidencia uterina completa (eversión completa de la longitud vaginal total). **(ver Imagen 20.6B)**

• **Tratamiento:** Asintomático: observación. Sintomático: *Conservador* (ejercicios de Kegel para fortalecimiento de suelo pélvico o **Pesarios vaginales** en pacientes con alto riesgo quirúrgico o que rechazan cirugía); *Quirúrgico* (colporrafia anterior para cistocele, colporrafia posterior para rectocele, histerectomía vaginal o sacrocolpopexia con malla).

2. INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO (IUE)

• **Definición y Fisiopatología:** Pérdida involuntaria de orina 3.01.1.032 sincrónica con el aumento de la presión intraabdominal (**al toser, reír, estornudar, correr o levantar peso**), en ausencia de contracción del detrusor.

• Causa principal: **Hipermovilidad uretral** por pérdida del soporte conectivo pubocervical del suelo pélvico (daño perineal obstétrico), y menos frecuentemente deficiencia esfinteriana intrínseca.

• **Diagnóstico:** Anamnesis típica, examen ginecológico con **prueba de esfuerzo positiva** (escape de orina al toser con vejiga llena), Test de Bonney o Marshall (el escape cede al elevar digitalmente el cuello vesical a ambos lados de la uretra sin ocluirla) y Test de Q-tip / hisopo (movilidad uretral > 30° respecto a la horizontal).

• **Tratamiento Escalonado:**

- Leve a moderada: Fisioterapia del suelo pélvico (ejercicios de contracción del elevador del ano - **Kegel**).

- Moderada a severa / Fracaso kinesiológico: **CIRUGÍA DE ELECCIÓN MEDIOURETRAL CON CINTAS LIBRES DE TENSIÓN (SLINGS)**: **TOT (Trans-Obturator Tape)** o **TVT (Tension-free Vaginal Tape)**. Colocación de una malla de polipropileno libre de tensión debajo del tercio medio de la uretra por vía vaginal ambulatoria. Tasas de curación > 85-90%.

3. INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA (IUU) Y VEJIGA HIPERACTIVA

• **Definición y Fisiopatología:** Pérdida involuntaria de orina 3.01.1.032 precedida de forma inmediata por un **deseo miccional imperioso, súbito y difícil de postergar ('urgencia')**. Fisiopatología: **Hiperactividad del músculo detrusor** (contracciones musculares involuntarias no inhibidas de la vejiga durante la fase de llenado vesical).

• **Síndrome de Vejiga Hiperactiva (VHA):** Complejo sintomático caracterizado por urgencia miccional, habitualmente acompañada de **polaquiuria (≥ 8 micciones al día) y nicturia (≥ 2 micciones nocturnas)**, con o sin incontinencia de urgencia, en ausencia de infección urinaria demostrada.

• **¡REGLA DE ORO TERAPÉUTICA (Pregunta Clásica EUNACOM)!: LA INCONTINENCIA DE URGENCIA NUNCA SE OPERA**. La cirugía de cabestrillos (slings) empeora catastróficamente la urgencia y puede causar retención urinaria.

• **Tratamiento Médico Escalonado:**

- **1. Medidas No Farmacológicas:** Modificación del estilo de vida (reducir café, té, alcohol, edulcorantes artificiales, tabaco) y **reeducación vesical con micciones programadas por horario**.

- **2. Fármacos Antimuscarínicos / Anticolinérgicos (1.ª Línea):** Bloquean receptores M2 y M3 del detrusor, frenando las contracciones involuntarias: **Solifenacina (5-10 mg/día)**, **Oxibutinina (5 mg c/8-12h)** o Tolterodina. Efectos adversos: sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa. ¡Contraindicados en glaucoma de ángulo estrecho!

- **3. Agonistas Beta-3 Adrenérgicos: MIRABEGRÓN (25-50 mg/día)**. Relaja activamente el detrusor durante el llenado vesical sin efectos anticolinérgicos (ideal en ancianas con boca seca o deterioro cognitivo). Precaución en HTA no controlada.

- **4. Terapia Avanzada Refractaria:** Inyección intravesical de Toxina Botulínica tipo A o neuromodulación sacra.



A. SISTEMA POP-Q **B.** PROCIDENCIA GENITAL

Imagen 20.6

FIGURA 20.6 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA



TABLA 20.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO Y DE URGENCIA 3.01.1.026, 3.01.1.032

CARACTERÍSTICA	INCONTINENCIA DE ESFUERZO (IUE)	INCONTINENCIA DE URGENCIA (IUU)
Mecanismo Desencadenante	Aumento brusco de presión intraabdominal (tos, risa, esfuerzo)	Deseo miccional repentino e incontrolable ('no alcanza a llegar al baño')
Volumen de Pérdida	Escaso a moderado (en chorro o gotas sincrónicas con el esfuerzo)	Moderado a abundante (vaciado vesical completo súbito)
Fisiopatología	Falla anatómica del soporte uretral (hipermovilidad uretral)	Contracciones involuntarias del músculo detrusor (hiperactividad)
Síntomas Asociados	Habitualmente no tiene polaquiuria ni nicturia	Polaquiuria diurna (> 8 veces) y nicturia (> 2 veces) frecuentes
Prueba de Esfuerzo al Examen	POSITIVA sincrónica inmediata con la tos	NEGATIVA (salvo contracción inducida tardía)
Tratamiento Médico	Poco eficaz (solo fisioterapia de Kegel en casos leves)	MUY EFICAZ: Reeducación vesical + Anticolinérgicos / Mirabegrón
Tratamiento Quirúrgico	ESTÁNDAR DE ORO: Cintas mediouretrales TOT / TVT	¡CONTRAINDICADO! (Empeora la hiperactividad del detrusor)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.6

Mujer de 52 años, multípara de 3 partos vaginales eutócicos con recién nacidos de más de 3.800 g, consulta por pérdida involuntaria de orina desde hace 2 años. Refiere que los escapes de orina ocurren de forma automática e inmediata al toser fuerte, reírse o realizar ejercicios en el gimnasio, manchando su ropa interior. Niega tener deseos urgentes de orinar antes del escape, no tiene polaquiuria y duerme de corrido sin levantarse en la noche a orinar. Al examen ginecológico en posición ginecológica con vejiga cómodamente llena, se le solicita toser, observándose de inmediato un chorro de escape de orina sincrónico con el golpe de tos. El urocultivo es negativo.

Conducta oficial. El cuadro clínico de escapes involuntarios de orina sincrónicos exclusivamente con el aumento de la presión intraabdominal (tos, risa, ejercicio) en ausencia de urgencia miccional o polaquiuria, con demostración objetiva de la fuga al toser en el examen físico y urocultivo estéril, configura con certeza el diagnóstico de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) por hipermovilidad uretral secundaria a daño del piso pélvico obstétrico. En esta paciente, el manejo inicial conservador incluye ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico (Kegel); ante la persistencia de los síntomas o afectación moderada-severa de su calidad de vida, el tratamiento curativo de elección y estándar de oro indiscutido es la colocación quirúrgica de un cabestrillo mediouretral libre de tensión por vía transobturatriz (TOT) o retropúbica (TVT).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Incontinencia de esfuerzo: Pérdida sincrónica con tos, risa o ejercicio por hipermovilidad uretral.
- Tratamiento quirúrgico de elección en IUE: Cintas o cabestrillos mediouretrales libres de tensión (TOT / TVT).
- Incontinencia de urgencia / Vejiga hiperactiva: Escape tras deseo imperioso súbito por hiperactividad del detrusor.
- ¡LA CIRUGÍA ESTÁ FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la incontinencia de urgencia pura!
- Tratamiento médico de IUU: Reeducación vesical + Antimuscarínicos (Solifenacina, Oxibutinina) o Mirabegrón.
- POP-Q: Sistema de estadificación donde el plano de referencia himenal es el punto 0 cm.
- POP Estadio II: Descenso de órganos entre -1 cm y +1 cm del himen.
- POP Estadio IV: Procidencia o eversión completa de la longitud vaginal.
- Pesarios vaginales: Tratamiento conservador de elección para POP en pacientes con contraindicación quirúrgica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.032

1. Una paciente de 62 años consulta por sensación de peso genital y escapes de orina involuntarios que ocurren exclusivamente cuando estornuda, tose o levanta objetos pesados. No presenta nicturia ni deseos miccionales apremiantes. Al examen físico se evidencia salida de orina sincrónica con la maniobra de Valsalva y un prolapso de la pared vaginal anterior cuyo punto de mayor descenso se sitúa a 2 cm por fuera del anillo himenal (+2 cm, Estadio III). Tras fracasar la kinesioterapia de piso pélvico, se programa cirugía. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver la incontinencia urinaria de esfuerzo?

A) Colocación de cabestrillo mediouretral libre de tensión (cinta TOT o TVT)
B) Inyección intravesical de toxina botulínica en el músculo detrusor
C) Prescripción oral de oxibutinina a dosis altas
D) Cistoplastía de aumento con parche intestinal
E) Denervación quirúrgica de los plexos hipogástricos inferiores

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.032

2. Una mujer de 68 años acude a control refiriendo que con frecuencia experimenta una sensación urgente, súbita e incontenible de orinar, no alcanzando a llegar al baño y perdiendo abundantes volúmenes de orina. Además, orina 12 veces al día y se despierta 3 a 4 veces por noche para miccionar. El examen físico y el sedimento de orina son normales. ¿Cuál de las siguientes conductas terapéuticas es la más apropiada?

A) Indicar colocación de cabestrillo suburetral transobturador (TOT)
B) Iniciar reeducación vesical combinada con un fármaco anticolinérgico como Solifenacina o un agonista beta-3 como Mirabegrón
C) Indicar restricción total de líquidos a menos de 500 mL al día
D) Realizar uretrotomía interna bajo anestesia
E) Indicar tratamiento antibiótico empírico continuo con ciprofloxacino por 6 meses

Más preguntas online de Prolapso de Órganos Pélvicos →

20.7. Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.020 | 3.01.4.001 | 4.03.1.017 | 1.03.4.009

¿POR QUÉ?

Se define Infertilidad como la incapacidad de una pareja en edad reproductiva de lograr un embarazo clínico tras un año (12 meses) de relaciones sexuales coitales regulares sin el uso de ningún método anticonceptivo (plazo que se acorta a 6 meses si la mujer tiene 35 años o más, o ante antecedentes de cirugía tubárica, endometriosis o criptorquidia). La infertilidad es un problema conyugal donde las causas se distribuyen equitativamente entre ambos miembros: 30-40% masculina, 30-40% femenina (tubárica, ovulatoria, uterina) y 10-20% mixta o de origen desconocido. El EUNACOM evalúa de manera sistemática los cuatro exámenes del estudio básico inicial y los criterios de derivación a técnicas de baja o alta complejidad.

1. DEFINICIONES Y DISTRIBUCIÓN ETIOLÓGICA DE LA INFERTILIDAD

• **Definición Temporal:** 3.01.1.020

- En mujeres **menores de 35 años**: Tras **12 meses** de búsqueda sin protección.

- En mujeres de **35 años o más**: El estudio debe iniciarse a los **6 meses** debido al acelerado declive fisiológico de la reserva ovárica y la calidad ovocitaria.

- Inmediato: Ante factores de riesgo mayores conocidos (amenorrea/oligomenorrea severa, endometriosis en estadios III-IV, antecedente de EIP grave, varicocele voluminoso o criptorquidia corregida tardíamente).

• **Distribución de Causas:**

- **Factor Masculino (35%):** Varicocele, infecciones accesorias, azoospermia obstructiva o secretora, tabaquismo y exposición a tóxicos. 3.01.1.020 | 4.03.1.017

- **Factor Tuboperitoneal (30%):** Secuelas de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (salpingitis), endometriosis pélvica o cirugías previas que causan obstrucción tubárica bilateral. 3.01.1.020

- **Factor Ovárico / Ovulatorio (20%):** Síndrome de Ovario Poliquístico (la causa anovulatoria más frecuente), insuficiencia ovárica prematura o disfunción tiroidea/prolactina.

- **Factor Uterino / Cervical (5-10%):** Miomas submucosos, pólipos endometriales, síndrome de Asherman o malformaciones müllerianas.

- **Infertilidad Sin Causa Aparente (ISCA) (10-15%):** Cuando el estudio básico completo resulta normal.

2. ESTUDIO BÁSICO INICIAL EN CUATRO PILARES FUNDAMENTALES

• **1) Estudio del Factor Masculino (ESPERMIOGRAMA):** 3.01.1.020 | 4.03.1.017

- Examen inicial de rigor. Requiere **3 a 5 días de abstinencia sexual previa**. Valores normales de referencia (criterios OMS 2021 / 6.ª edición):

• Volumen eyaculado: **≥ 1.4 a 1.5 mL**.

• Concentración espermática: **≥ 15 a 16 millones/mL** (o ≥ 39 millones totales). Oligozoospermia si es menor.

• Motilidad progresiva (PR): **≥ 30 a 32%**. Astenozoospermia si es menor.

• Morfología normal (Kruger estricto): **≥ 4% de formas normales**. Teratozoospermia si es menor.

• Si el espermiograma resulta alterado, DEBE **repetirse una segunda muestra a las 4 a 12 semanas** para confirmarlo antes de etiquetar al paciente.

• **2) Estudio del Factor Ovulatorio:** 3.01.1.020

- **Progesterona sérica en fase lútea media (Día 21 del ciclo):** Un valor **> 3 a 5 ng/mL** confirma la ocurrencia de ovulación en ese ciclo.

- **Evaluación de Reserva Ovárica:**

• **Hormona Antimülleriana (AMH) sérica:** Producida por las células de la granulosa de folículos preantrales y antrales pequeños. Se puede medir en cualquier día del ciclo. Valores normales: **1.0 a 3.5 ng/mL**. Valores < 0.5-1.0 ng/mL indican baja reserva ovárica.

• **FSH y Estradiol en fase folicular temprana (Día 3 del ciclo):** FSH > 10-12 UI/L predice pobre respuesta ovárica.

• **Recuento de Folículos Antrales (RFA) por ecografía TV:** Total < 5 a 7 folículos entre ambos ovarios indica baja reserva.

• **3) Estudio del Factor Tuboperitoneal (HISTEROSALPINGOGRAFÍA - HSG): (ver Imagen 20.7A)** 3.01.1.020 | 3.01.4.001

- Radiografía con inyección de medio de contraste radiopaco a través del cuello uterino en la primera mitad del ciclo.

- Evalúa la forma de la cavidad endometrial y la **permeabilidad de las trompas de Falopio**. **(ver Imagen 20.7B)**

- **Prueba de Cotte Positiva:** Paso y dispersión libre del contraste hacia la cavidad peritoneal a través de ambas trompas (confirma permeabilidad tubárica bilateral).

• **4) Estudio del Factor Uterino:** 3.01.1.020

- **Ecografía Transvaginal ginecológica** (descarta miomas submucosos, adenomiosis o pólipos) e **Histeroscopía diagnóstica** si hay defectos de llene en la HSG. 3.01.1.020 | 3.01.4.001

3. INDICACIONES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: BAJA VS ALTA COMPLEJIDAD

• **Técnicas de Baja Complejidad: INSEMINACIÓN INTRAUTERINA (IIU):** 3.01.1.020

- Consiste en la inducción suave de la ovulación y la introducción de una muestra de semen capacitado dentro de la cavidad uterina mediante una cánula en el momento de la ovulación.

- **Requisitos Indispensables para IIU:**

• 1) **Al menos UNA trompa de Falopio permeable comprobada (Cotte +).** 3.01.1.020 | 3.01.4.001

• 2) **Recuento de Espermatozoides Móviles Progresivos Recuperados (REM) post-capacitación ≥ 3 a 5 millones.** 3.01.1.020

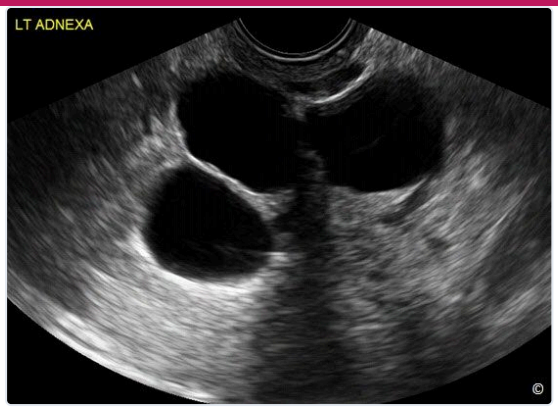
- Indicaciones: Factor masculino leve a moderado, anovulación / SOP refractario a fármacos orales, factor cervical o esterilidad idiopática.

• **Técnicas de Alta Complejidad: FERTILIZACIÓN IN VITRO (FIV) e ICSI:**

- Requiere hiperestimulación ovárica controlada, aspiración folicular guiada por ecografía transvaginal, fecundación en laboratorio y transferencia embrionaria intrauterina.

- **Indicaciones de Elección para FIV / ICSI:**

• 1) **Factor Tubárico Severo: Obstrucción tubárica bilateral (hidrosálpinx bilateral, salpingectomía bilateral previa). (ver Imagen 20.7C)**



Histerosalpingografía con obstrucción tubárica bilateral / hidrosálpin

• 2) **Factor Masculino Severo: REM < 1 a 3 millones, oligoastenozoospermia severa o azoospermia** (en estos casos se realiza **ICSI** inyectando un único espermatozoide directamente dentro de cada ovocito). 3.01.1.020 4.03.1.017

• 3) Endometriosis severa en estadios III o IV. 3.01.1.020

• 4) Edad materna avanzada (> 38-40 años) o baja reserva ovárica crítica.

• 5) Fracaso reiterado de técnicas de baja complejidad (3 a 4 intentos de IIU).

4. EVALUACIÓN HORMONAL (LH, TESTOSTERONA) E INFERTILIDAD MASCULINA

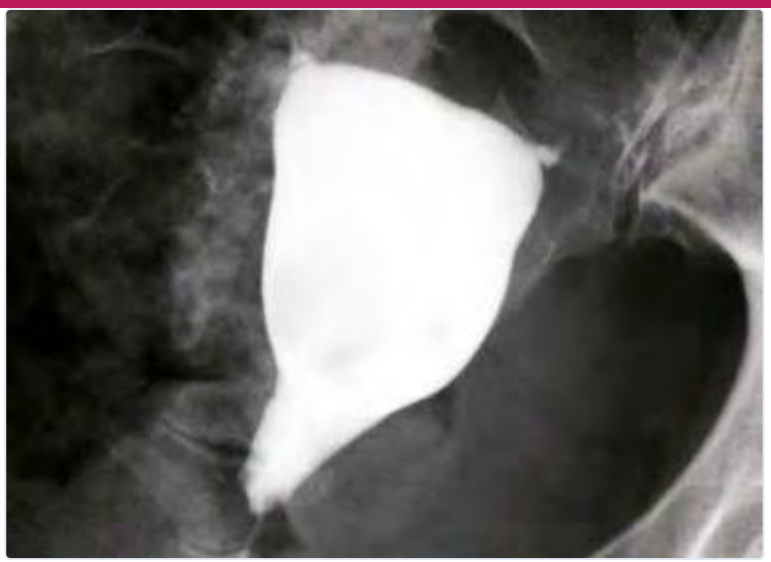
• **LH y testosterona (Interpreta y emplea):** en la mujer, el **pico de LH** en orina precede a la ovulación 24-36 horas (se usa para programar relaciones o inseminación); una relación LH/FSH > 2 es frecuente en el SOP pero no es criterio diagnóstico. La testosterona total en la mujer (normal ~15-70 ng/dL) permite objetivar hiperandrogenismo (> 150-200 ng/dL: descartar tumor). 1.03.4.009

- **En el hombre infertile:** testosterona baja con **LH/FSH altas** = hipogonadismo primario (testicular: Klinefelter, orquitis, criptorquidia); testosterona baja con **LH/FSH bajas** = hipogonadismo central (hipopituitarismo, prolactinoma, Kallmann). FSH elevada con azoospermia indica falla espermatogénica primaria; FSH normal con azoospermia y volumen testicular normal sugiere obstrucción.

• **Infertilidad masculina (Sospecha / Inicial / Derivar):** responsable del 35-50% de la infertilidad de pareja. Se estudia con **espermiograma** (dos muestras con 3-5 días de abstinencia), examen genital (volumen testicular, varicocele con Valsalva, vasos deferentes), y hormonas (FSH, LH, testosterona). 4.03.1.017

- **Causas: varicocele** (la causa corregible más frecuente, 35-40% de la infertilidad primaria; preferentemente izquierdo), criptorquidia, orquitis por parotiditis, tóxicos y calor (tabaco, alcohol, anabólicos, sauna), quimio/radioterapia, genéticas (Klinefelter 47,XXY, microdeleciones del cromosoma Y, ausencia congénita de deferentes por mutación CFTR) y obstrucción de la vía seminal. Azoospermia: obstructiva (FSH normal, testículos normales) vs secretora (FSH alta, testículos pequeños).

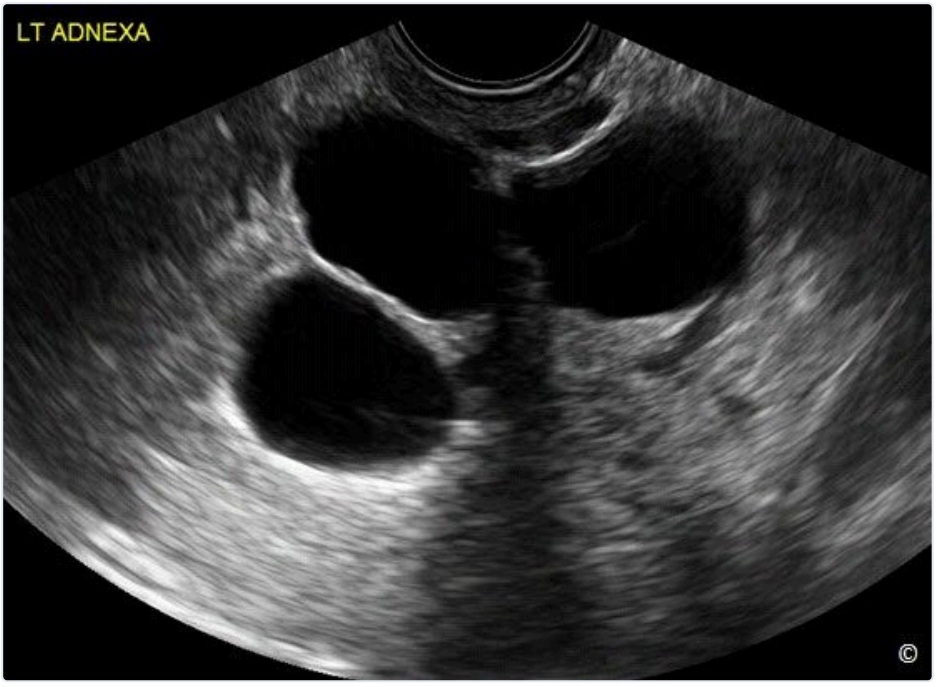
- **Conducta:** suspender tóxicos y fármacos gonadotóxicos, tratar infecciones, **varicocelectomía** si el varicocele es clínico y el espermiograma está alterado, y **derivar a urología/andrología**; en oligoastenozoospermia severa o azoospermia con espermatogénesis conservada, extracción testicular (TESE) + ICSI.



A. HISTEROSALPINGOGRAFÍA



B. TROMPAS PERMEABLES



C. HIDROSÁLPINX (ECOGRAFÍA)

Imagen 20.7

FIGURA 20.7 · ALGORITMO DE ESTUDIO BÁSICO DE LA PAREJA INFÉRTIL



TABLA 20.7 · CRITERIOS DE ELECCIÓN ENTRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (BAJA VS ALTA COMPLEJIDAD)

3.01.1.020, 3.01.4.001, 4.03.1.017, 1.03.4.009

PARÁMETRO CLÍNICO	BAJA COMPLEJIDAD (INSEMINACIÓN INTRAUTERINA)	ALTA COMPLEJIDAD (FIV / ICSI)
Estado de las Trompas de Falopio	OBLIGATORIO: Al menos una trompa permeable (Cotte +)	Permeabilidad IRRELEVANTE (indicada en obstrucción bilateral)
Calidad Seminal (REM Post-capacitación)	REM ≥ 3 a 5 millones de espermatozoides móviles	Apta para factor severo (REM < 1-3 mill, azoospermia)
Lugar de la Fecundación	In vivo (dentro de la trompa de la mujer)	In vitro (en el laboratorio de embriología)
Complejidad y Cirugía	Ambulatoria en consulta, sin anestesia ni punción	Requiere punción ovárica bajo sedación en pabellón
Costo y Tasa de Éxito por Ciclo	Bajo costo · Éxito 12 - 18% por ciclo	Alto costo · Éxito 35 - 50% por ciclo
Indicaciones Clásicas EUNACOM	SOP que no ovula con letrozol, factor masculino leve, ISCA	Obstrucción tubárica bilateral, factor masculino grave, > 38 años

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.7

Pareja compuesta por mujer de 31 años y varón de 33 años consultan por no haber logrado embarazo tras 18 meses de relaciones sexuales no protegidas regulares. La mujer tiene ciclos menstruales regulares de 28 días y el dosaje de progesterona plasmática en el día 21 fue de 12 ng/mL (ovulatorio). Se realiza Histerosalpingografía (HSG) que demuestra cavidad uterina normal, pero existe ausencia completa de paso de medio de contraste a través de ambas trompas de Falopio, con dilatación ampular bilateral compatible con hidrosálpinx bilateral y prueba de Cotte negativa bilateral. El espermiograma del varón resulta con 45 millones de espermatozoides/mL y 55% de motilidad progresiva normal.

Conducta oficial. El estudio de la pareja evidencia un Factor Tuboperitoneal Severo Absoluto como causa de la infertilidad, manifestado por obstrucción tubárica bilateral irreversible con hidrosálpinx bilateral confirmado por la ausencia de pasaje de contraste peritoneal (Prueba de Cotte negativa bilateral) en la histerosalpingografía, mientras que el varón tiene un factor masculino completamente normal y la mujer ovula regularmente. Dado que las trompas están totalmente ocluidas, el encuentro fisiológico entre el óvulo y el espermatozoide en la ampolla tubárica es imposible, lo que CONTRAINDICA absolutamente cualquier intento de Inseminación Intrauterina (IIU). La conducta terapéutica de elección y única vía eficaz para lograr un embarazo es la derivación inmediata a Técnicas de Reproducción Asistida de Alta Complejidad mediante Fertilización In Vitro (FIV), previa salpingectomía laparoscópica bilateral del hidrosálpinx (dado que el líquido del hidrosálpinx es tóxico para el endometrio y reduce a la mitad la tasa de implantación embrionaria).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Infertilidad: 12 meses de búsqueda infructuosa en < 35 años; 6 meses si la mujer tiene ≥ 35 años.
- Distribución etiológica: 35% masculina, 30% tubárica, 20% ovulatoria, 15% idiopática o mixta.
- Espermiograma: Requiere 3-5 días de abstinencia. Concentración normal ≥ 15 mill/mL, motilidad progresiva ≥ 30-32%.
- Si un espermiograma está alterado, debe repetirse obligatoriamente una segunda muestra en 1 a 3 meses.
- Histerosalpingografía (HSG): Prueba de Cotte positiva confirma permeabilidad tubárica.
- Reserva ovárica: La Hormona Antimülleriana (AMH) sérica es el marcador más fiable y estable del ciclo.
- Requisito mandatorio para Inseminación Intrauterina (IIU): Al menos una trompa permeable y REM > 3-5 millones.
- Indicación de elección para FIV/ICSI: Obstrucción tubárica bilateral, factor masculino grave o edad > 38-40 años.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.020

1. Una pareja acude a consulta por no lograr embarazo tras 2 años de búsqueda. En el estudio básico inicial se realiza una Histerosalpingografía a la mujer, informándose obstrucción tubárica bilateral con hidrosálpinx bilateral y prueba de Cotte negativa. El espermiograma del cónyuge y la reserva ovárica de la mujer son normales. ¿Cuál es el tratamiento de fertilidad más adecuado que debe indicarse?

A) Inseminación intrauterina con semen de donante
B) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno y relaciones sexuales programadas
C) Fertilización In Vitro (FIV)
D) Inseminación intrauterina con semen del cónyuge capacitado
E) Antibioticoterapia continua con Doxiciclina durante 6 meses

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.020

2. En el estudio de un varón de 30 años cuya pareja no logra concebir, se solicita un espermiograma de control. Para que los resultados del análisis seminal según los estándares internacionales de la OMS sean válidos y confiables, ¿cuántos días de abstinencia sexual previa debe cumplir el paciente antes de recolectar la muestra?

A) Menos de 24 horas de abstinencia
B) De 3 a 5 días de abstinencia estricta
C) Al menos 20 a 30 días de abstinencia
D) La abstinencia sexual previa es irrelevante para el espermiograma
E) Exactamente 14 días coincidiendo con el ciclo de la pareja

Más preguntas online de Infertilidad Conyugal →

20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.3.008 3.01.3.006

¿POR QUÉ?

La prescripción informada y segura de métodos anticonceptivos es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza la seguridad de los métodos en cuatro niveles: Categoría 1 (sin restricción), Categoría 2 (ventajas superan riesgos), Categoría 3 (riesgos superan ventajas) y Categoría 4 (RIESGO INACEPTABLE / CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA). El médico general debe reconocer de forma instantánea las condiciones Categoría 4 que prohíben el uso de estrógenos (migraña con aura, fumadora ≥ 35 años, antecedente de trombosis venosa profunda o hipertensión arterial severa), debiendo optar por métodos de solo progestágeno o de barrera/cobre. Asimismo, se debe dominar el uso de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) con Levonorgestrel 1.5 mg.

1. CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS (CATEGORÍAS 1 AL 4)

• **Categoría 1:** No hay ninguna restricción para el uso del método anticonceptivo. Se puede usar en cualquier circunstancia. 3.01.3.008

• **Categoría 2:** Las ventajas de usar el método superan con creces los riesgos teóricos o demostrados. Generalmente se puede usar.

• **Categoría 3:** Los riesgos teóricos o comprobados suelen superar las ventajas del método. Su uso no se recomienda a menos que no haya otros métodos disponibles o aceptables.

• **CATEGORÍA 4 (Pregunta Fija EUNACOM): RIESGO INACEPTABLE PARA LA SALUD / CONTRAINDICACIÓN MÉDICA ABSOLUTA**. El método NO DEBE utilizarse bajo ninguna circunstancia.

2. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS (CATEGORÍA 4) PARA ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS (ESTRÓGENOS + PROGESTÁGENO)

• Aplican por igual a la vía oral (ACOs combinados), transdérmica (parche) y vaginal (anillo): 3.01.3.008

- **1. Tabaquismo en mujeres de 35 años o más:** Fumar **≥ 15 cigarrillos al día con edad ≥ 35 años** (dispara el riesgo de infarto agudo de miocardio y ACV isquémico).

- **2. Migraña con AURA a cualquier edad:** El antecedente de migraña con aura neurológica focal (escotomas centelleantes, parestesias, afasia) eleva exponencialmente el riesgo de **Accidente Cerebrovascular Isquémico**.

- **3. Tromboembolismo Venoso Actual o Antecedente Personal de TVP / TEP.**

- **4. Trombofilias Conocidas:** Mutación del Factor V de Leiden, mutación de Protrombina G20210A, déficit de proteína C, S o antitrombina, o Síndrome Antifosfolípido.

- **5. Hipertensión Arterial Severa:** Presión arterial sistólica **≥ 160 mmHg y/o diastólica ≥ 100 mmHg** o hipertensión con daño vascular de órgano blanco.

- **6. Cáncer de Mama Actual o antecedente en los últimos 5 años** (tumor dependiente de hormonas).

- **7. Lactancia Materna en las primeras 6 semanas postparto** (los estrógenos reducen el volumen de leche materna y aumentan el riesgo trombótico puerperal).

- **8. Enfermedad Hepática Severa Activa:** Cirrosis hepática descompensada, hepatitis aguda o adenoma/hepatocarcinoma hepático.

TABLA 20.8.A · CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD OMS: MÉTODOS COMBINADOS VS SOLO PROGESTÁGENO 3.01.3.008, 3.01.3.006

CONDICIÓN MÉDICA DE LA PACIENTE	MÉTODOS COMBINADOS (ESTRÓGENO + PG)	MÉTODOS SOLO PROGESTÁGENO	DIU DE COBRE
Fumadora ≥ 35 años que fuma ≥ 15 cig/día	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Migraña CON AURA a cualquier edad	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 o 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Antecedente Personal de TVP o TEP	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 2 (Aceptable)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Hipertensión Arterial Severa (≥ 160/100)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 o 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Lactancia Materna (< 6 semanas postparto)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Cáncer de Mama Actual	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Infección Pélvica Activa (EIP / Cervicitis)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)

20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE SOLO PROGESTÁGENO Y LARC

• **Ventaja Fundamental de los Progestágenos Solos: NO incrementan el riesgo tromboembólico venoso** y no alteran la cantidad ni calidad de la leche materna. Son seguros y de elección en pacientes con contraindicación de estrógenos (fumadoras > 35a, migraña con aura, HTA controlada o lactancia materna). 3.01.3.008

• **Opciones de Solo Progestágeno:**

- **Minipíldora Oral:** Desogestrel 75 mcg/día (inhibe ovulación) o Levonorgestrel 30 mcg (espesa moco cervical). Se toma sin descansos.

- **Implante Subdérmico de Etonogestrel (Implanon / Nexplanon):** Varilla flexible insertada en cara interna del brazo. **Método reversible de mayor eficacia existente (Índice de Pearl 0.05)**. Duración de 3 a 5 años. **(ver Imagen 20.8A y B)**

- **Inyectable Trimestral de Acetato de Medroxiprogesterona (150 mg IM):** Puede producir amenorrea en 50-70% y retraso en la recuperación de la fertilidad de hasta 9-12 meses tras el retiro.

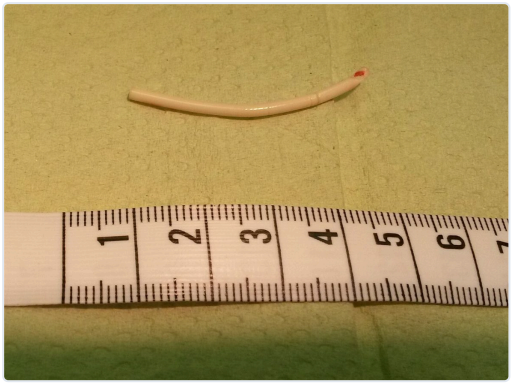
- **DIU liberador de Levonorgestrel (Mirena / Kyleena):** Duración de 5 a 8 años. Reduce el sangrado en más del 90%.

• **Dispositivo Intrauterino de Cobre (T de Cobre 380A): (ver Imagen 20.8C)**

- Método no hormonal de larga duración (10 a 12 años). Provoca reacción inflamatoria estéril espermicida.

- **Contraindicaciones Absolutas:** Infección pélvica aguda actual (EIP activa, cervicitis purulenta), sospecha de embarazo, distorsión severa de la cavidad endometrial o sangrado genital inexplicado no filiado.

- Efecto adverso frecuente: Aumento de la cuantía del sangrado menstrual y dismenorrea en los primeros ciclos.



A. IMPLANTE SUBDÉRMICO



B. RETIRO DEL IMPLANTE



C. DIU DE COBRE Y LNG

Imagen 20.8

FIGURA 20.8 · ALGORITMO DE SELECCIÓN DE ANTICONCEPCIÓN SEGÚN CRITERIOS MÉDICOS OMS

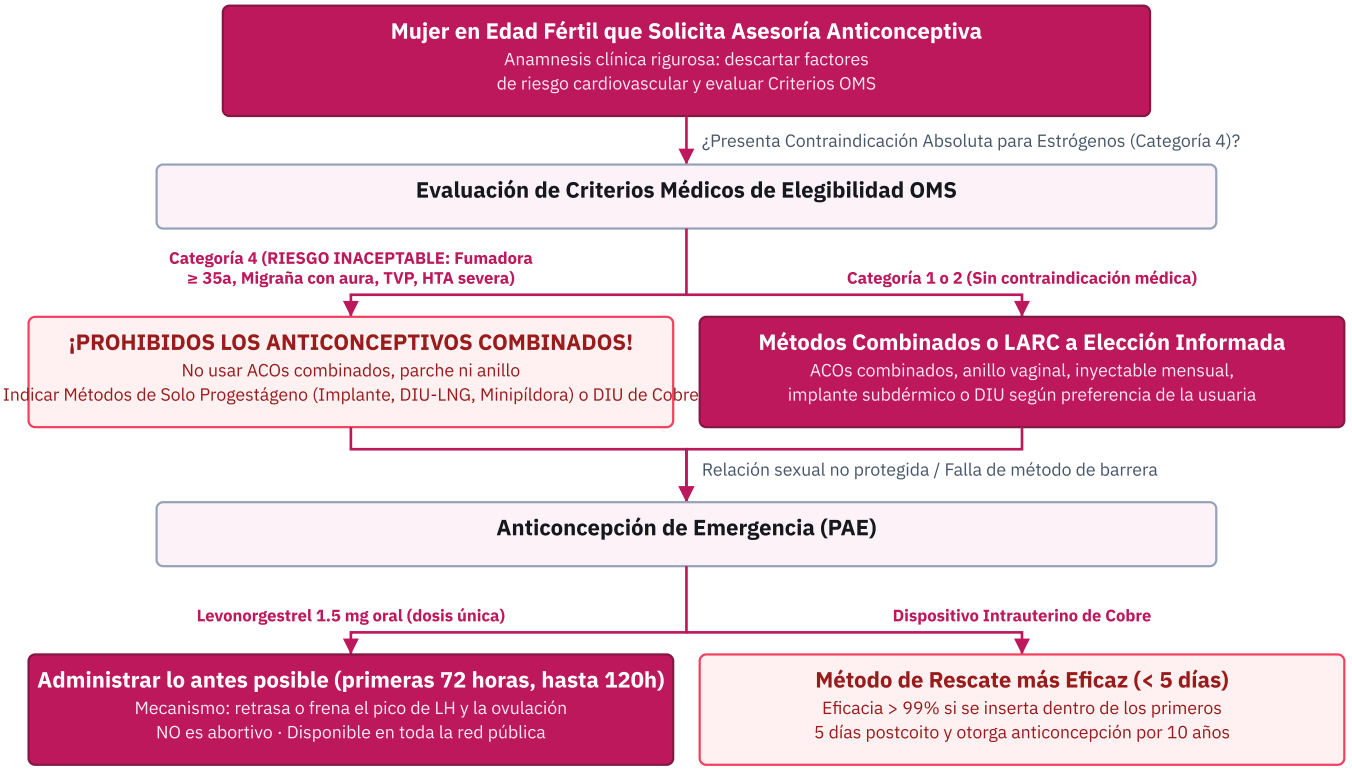


TABLA 20.8.B · CONDICIONES DE CATEGORÍA 4 OMS (CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA INACEPTABLE) CRITERIOS DE GRAVEDAD

MÉTODO ANTICONCEPTIVO	CONDICIONES MÉDICAS CON RIESGO INACEPTABLE (CATEGORÍA 4)	RIESGO CLÍNICO VITAL ASOCIADO
Anticonceptivos Combinados (ACOs, Parche, Anillo)	• Fumadora ≥ 35 años (≥ 15 cig/d) • Migraña con aura • TVP/TEP previo o activo • HTA severa (≥ 160/100) • Cáncer de mama actual • Cirrosis descompensada	Tromboembolismo venoso masivo, accidente cerebrovascular isquémico, infarto agudo de miocardio.
Métodos de Solo Progestágeno (Implante, Minipíldora, DIU-LNG)	• Cáncer de mama actual activo (durante los últimos 5 años)	Estímulo de progresión tumoral hormonal.
DIU de Cobre y DIU-LNG	• Infección Pélvica Inflamatoria (EIP) activa • Cervicitis purulenta • Tuberculosis pélvica • Sospecha o confirmación de embarazo	Diseminación séptica pélvica, pelviperitonitis y perforación miometrial.

20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS - PAE)

• Indicada tras una relación sexual no protegida, violación o falla comprobada del método habitual (rotura de preservativo, expulsión de DIU, olvido de ≥ 2-3 comprimidos hormonales). 3.01.3.008

• **Fármaco de Elección en Chile: LEVONORGESTREL:**

- **Posología Oficial: 1.5 mg por vía oral en dosis única** (o 2 comprimidos de 0.75 mg juntos).

- **Ventana Terapéutica:** Debe administrarse lo antes posible, idealmente dentro de las **primeras 72 horas (3 días)** postcoito, manteniendo una eficacia residual demostrada hasta las 120 horas (5 días).

- **Mecanismo de Acción Biológico:** Inhibe o retrasa el pico preovulatorio de LH, impidiendo o retrasando la ovulación. **NO interrumpe un embarazo ya implantado ni actúa como método abortivo**.

- Efecto adverso más común: Náuseas y vómitos. Si la paciente vomita dentro de las **primeras 2 horas** de la toma, debe repetir la dosis completa.

• **DIU de Cobre de Emergencia:** La inserción de un DIU de cobre dentro de los **primeros 5 días (120 horas) postcoito** es el método anticonceptivo de emergencia más eficaz existente (tasa de fracaso < 0.1%) y otorga anticoncepción continua por 10 años.

5. MÉTODOS NATURALES DE REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD

• **Métodos naturales (basados en la identificación de la ventana fértil, ~6 días por ciclo):** requieren motivación, ciclos regulares y abstinencia periódica; **no protegen contra ITS**. Eficacia con uso típico baja (Pearl ~12-24 por 100 mujeres-año; con uso perfecto 1-5). 3.01.3.006

- **Calendario o Ogino-Knaus:** se calcula la ventana fértil restando 18 días al ciclo más corto y 11 al más largo (en ciclo de 28 días: días 10-17). **Moco cervical (Billings):** fértil cuando es abundante, claro y filante ("clara de huevo"). **Temperatura basal:** alza de 0,3-0,5 °C tras la ovulación (confirma ovulación, no la predice). **Sintotérmico:** combina moco, temperatura y calendario.

- **MELA (método de lactancia y amenorrea):** eficaz (~98%) si se cumplen tres condiciones: lactancia exclusiva o casi exclusiva a libre demanda, amenorrea y bebé < 6 meses. El **coito interrumpido** es el método natural de menor eficacia. Se ofrecen como alternativa respetando la elección informada de la pareja (norma MINSAL de regulación de la fertilidad), con consejería sobre métodos más eficaces.

TABLA 20.8.C · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS EN ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PAE) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MÉTODO	FÁRMACO Y DOSIS	VENTANA DE TIEMPO EFICAZ	CONSIDERACIONES Y MANEJO DE VÓMITOS
Levonorgestrel (1.ª Línea en APS)	1.5 mg vía oral en dosis única (o 2 comp de 0.75 mg)	Primeras 72 horas (útil hasta 120h)	Si vomita en < 2 horas post-toma: REPETIR LA DOSIS. No es abortivo.
Acetato de Ulipristal	30 mg vía oral en dosis única	Hasta 120 horas (5 días postcoito)	Modulador del receptor de progesterona. Mayor eficacia que LNG en sobrepeso.
DIU de Cobre de Rescate	Inserción de T de Cobre intrauterina	Hasta 120 horas (5 días postcoito)	Método de rescate más eficaz (> 99%). Requiere disponibilidad y colocación por profesional capacitado.

20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR)

- Criterios OMS: Categoría 1 = Sin restricción; Categoría 4 = Contraindicación absoluta inaceptable.
- Migraña CON AURA a cualquier edad: CATEGORÍA 4 para métodos combinados (riesgo de ACV isquémico).
- Métodos de solo progestágeno (Implante, Minipíldora, DIU-LNG): NO aumentan el riesgo de trombosis.
- Implante subdérmico de Etonogestrel: Método reversible con menor tasa de falla de toda la medicina (Pearl 0.05).
- Mecanismo de la PAE: Retrasa o frena el pico de LH y la ovulación; NO interrumpe un embarazo implantado.
- Fumadora ≥ 35 años con ≥ 15 cig/d: CATEGORÍA 4 para métodos combinados con estrógenos.
- Antecedente de TVP/TEP o trombofilia: CATEGORÍA 4 para métodos combinados.
- Son seguros en fumadoras > 35 años, migraña con aura y durante la lactancia materna.
- Píldora de Emergencia (PAE): Levonorgestrel 1.5 mg oral en dosis única en las primeras 72 horas.
- Si la paciente vomita dentro de las 2 horas tras tomar la PAE, debe repetirse la dosis de inmediato.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 20.8

Mujer de 37 años, fumadora de 20 cigarrillos al día desde los 18 años, acude a la consulta ginecológica del CESFAM solicitando inicio de método anticonceptivo. Refiere que una amiga toma un anticonceptivo oral combinado de etinilestradiol con drospirenona que le deja la piel tersa y solicita la misma receta. La paciente no tiene otros antecedentes de importancia y su presión arterial es de 125/80 mmHg. Al revisar los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS, el médico evalúa la seguridad de la prescripción solicitada.

Conducta oficial razonada. La solicitud de la paciente de recibir anticonceptivos orales combinados debe ser FORMALMENTE DENEGADA. Según los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS y las normas del MINSAL, el antecedente de ser una mujer de 35 años o más que fuma 15 o más cigarrillos al día constituye una condición CATEGORÍA 4 (Contraindicación Absoluta / Riesgo Inaceptable para la salud) para cualquier método hormonal que contenga Estrógenos (anticonceptivos combinados orales, parches transdérmicos o anillos vaginales), debido a que la combinación de estrógenos y tabaco a partir de esa edad multiplica exponencialmente el riesgo de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico y tromboembolismo venoso mortal. La conducta médica correcta es explicarle claramente estos riesgos y ofrecerle alternativas de alta eficacia totalmente seguras (Categoría 1 de la OMS), tales como los Métodos de Solo Progestágeno (Implante subdérmico de Etonogestrel, DIU liberador de Levonorgestrel o minipíldora de desogestrel) o el DIU de Cobre.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.8 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

1. Una paciente de 36 años, sin antecedentes cardiovasculares pero fumadora activa de una cajetilla diaria (20 cigarrillos al día), solicita inicio de método anticonceptivo. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO (Categoría 4 de la OMS) en esta paciente?

A) Dispositivo intrauterino de cobre (T de Cobre)
B) Implante subdérmico liberador de etonogestrel
C) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol con levonorgestrel
D) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
E) Minipíldora oral de desogestrel

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

2. Una joven de 20 años consulta en el servicio de urgencia 18 horas después de una relación sexual no protegida por rotura del condón. Solicita la píldora de anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es el fármaco de elección, la dosis recomendada y el mecanismo de acción de la píldora de anticoncepción de emergencia disponible en el sistema público chileno?

A) Mifepristona 200 mg oral; desprendimiento del blastocisto implantado
B) Levonorgestrel 1.5 mg oral en dosis única; retraso o inhibición del pico ovulatorio de LH
C) Misoprostol 800 mcg vaginal; inducción de contracciones uterinas expulsivas
D) Metotrexato 50 mg intramuscular; lisis de las células trofoblásticas
E) Estrógenos conjugados a altas dosis; inducción de hemorragia masiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

3. Una paciente de 28 años con antecedente de migraña clásica con aura visual (escotomas centelleantes) frecuente acude a solicitar anticoncepción hormonal. Al evaluar las alternativas, ¿cuál de los siguientes métodos está formalmente contraindicado por clasificarse como Categoría 4 de la OMS?

A) Anillo vaginal liberador de etinilestradiol y etonogestrel
B) Implante subdérmico de etonogestrel
C) Dispositivo intrauterino de cobre
D) Minipíldora de desogestrel
E) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.006

4. Una paciente que tomó la píldora de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 1.5 mg presenta un episodio de vómito profuso 45 minutos después de haber deglutido el comprimido. ¿Cuál es la indicación médica correcta a seguir?

A) No realizar ninguna acción, pues la absorción intestinal completa ocurre en los primeros 15 minutos
B) Repetir de inmediato la dosis completa de 1.5 mg de Levonorgestrel, idealmente asociando un antiemético oral
C) Indicar que el método fracasó y que debe programarse una interrupción legal del embarazo
D) Administrar antibióticos profilácticos para evitar infecciones
E) Esperar 1 semana y realizar un test de embarazo en sangre

Más preguntas online de Anticoncepción y Planificación Familiar →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 20.5 A 20.8

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	Fisiopatología: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica...	**Tríada cardinal clásica: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda +...**	Los fármacos hormonales NO mejoran la fertilidad; no deben administrarse si desea...
Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	Incontinencia de esfuerzo: Pérdida sincrónica con tos, risa o ejercicio por...	**Tratamiento quirúrgico de elección en IUE: Cintas o cabestrillos mediouretrales libres...**	¡LA CIRUGÍA ESTÁ FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la incontinencia de urgencia pura!
Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	Infertilidad: 12 meses de búsqueda infructuosa en < 35 años; 6 meses si la mujer tiene...	**Distribución etiológica: 35% masculina, 30% tubárica, 20% ovulatoria, 15% idiopática o...**	El estudio de la pareja evidencia un Factor Tuboperitoneal Severo Absoluto como causa...
Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	Criterios OMS: Categoría 1 = Sin restricción; Categoría 4 = Contraindicación absoluta...	**Fumadora ≥ 35 años con ≥ 15 cig/d: CATEGORÍA 4 para métodos combinados con estrógenos.**	La solicitud de la paciente de recibir anticonceptivos orales combinados debe ser...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Fisiopatología: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica estrógeno-dependiente.

Tríada cardinal clásica: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad.

Localización anatómica más frecuente: Ovarios (Endometrioma o 'quiste de chocolate').

Ecografía transvaginal del endometrioma: Quiste homogéneo con ecos finos en 'vidrio esmerilado' sin papilas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Tríada cardinal clásica: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad.
- Localización anatómica más frecuente: Ovarios (Endometrioma o 'quiste de chocolate').
- Tratamiento quirúrgico de elección en IUE: Cintas o cabestrillos mediouretrales libres de tensión (TOT / TVT).
- Incontinencia de urgencia / Vejiga hiperactiva: Escape tras deseo imperioso súbito por hiperactividad del detrusor.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Fisiopatología: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica estrógeno-dependiente.	Tema 20.5 →
Incontinencia de esfuerzo: Pérdida sincrónica con tos, risa o ejercicio por hipermovilidad uretral.	Tema 20.6 →
Infertilidad: 12 meses de búsqueda infructuosa en < 35 años; 6 meses si la mujer tiene ≥ 35 años.	Tema 20.7 →
Criterios OMS: Categoría 1 = Sin restricción; Categoría 4 = Contraindicación absoluta inaceptable.	Tema 20.8 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
20.9	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	48
20.10	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	54
20.11	Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos	58
20.12	Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos	64

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.019, 3.01.1.017, 3.01.5.008, 3.01.5.007, 2.01.1.106, 2.01.1.130	Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis	Específico	Completo	Completo
3.01.2.002, 3.01.5.004	Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Específico	Completo	Completo
3.01.1.025, 3.01.2.018	Enfermedad Pélvica Inflamatoria	Específico	Completo	Completo
3.01.1.027, 3.01.3.005, 1.03.1.011, 1.07.3.010	Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > 20%).
- Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días. NO requiere tratar a la pareja.
- Candidiasis: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).
- Tratamiento de Candidiasis: Fluconazol 150 mg oral dosis única o Clotrimazol óvulos (único en embarazo).
- Tricomoniasis: ITS con flujo espumoso amarillo-verdoso, cuello en fresa y protozoo flagelado móvil.
- Tratamiento de Tricomoniasis: Metronidazol 2g oral dosis única A LA PACIENTE Y A SU PAREJA OBLIGATORIA.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis	EUNACOM Julio 2025 · #121 · EUNACOM Julio 2025 · #34 · EUNACOM Julio 2024 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #116
Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	EUNACOM Julio 2025 · #148 · EUNACOM Diciembre 2025 · #141 · EUNACOM Diciembre 2025 · #119 · EUNACOM Enero 2023 · #52
Enfermedad Pélvica Inflamatoria	EUNACOM Diciembre 2025 · #95 · EUNACOM Julio 2019 · #174 · EUNACOM Diciembre 2018 · #80 · EUNACOM Julio 2018 · #58
Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal	EUNACOM Julio 2025 · #43 · EUNACOM Diciembre 2025 · #178 · EUNACOM Julio 2025 · #42 · EUNACOM Diciembre 2024 · #61

20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.019 | 3.01.1.017 | 3.01.5.008 | 3.01.5.007 | 2.01.1.106 | 2.01.1.130

¿POR QUÉ?

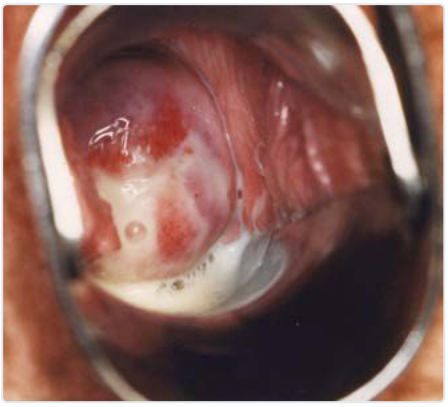
Las infecciones del tracto genital inferior (vulvovaginitis y cervicitis) representan el motivo de consulta ginecológica más prevalente en la atención médica ambulatoria. El médico general debe saber diferenciar con absoluta certeza las tres entidades clásicas de vulvovaginitis mediante la clínica, el pH vaginal, el test de aminas (KOH al 10%) y el frotis al microscopio: 1) Vaginosis Bacteriana (disbiosis con pérdida de lactobacilos y proliferación de Gardnerella/anaerobios; diagnosticada por Criterios de Amsel); 2) Candidiasis Vulvovaginal (infección fúngica con prurito severo y leucorrea en leche cortada con pH ácido normal < 4.5); y 3) Tricomoniasis (infección de transmisión sexual por protozoo flagelado, con flujo espumoso verdoso, cuello en fresa y donde es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO tratar a la pareja sexual simultáneamente).

1. VAGINOSIS BACTERIANA Y CRITERIOS DE AMSEL

• **Fisiopatología:** No es una infección inflamatoria clásica, sino una **disbiosis de la microbiota vaginal**. Ocurre una drástica reducción o desaparición de los *Lactobacillus* productores de peróxido de hidrógeno y ácido láctico, con sobrecrecimiento masivo de bacterias anaerobias estrictas y facultativas: **Gardnerella vaginalis**, *Atopobium vaginae*, *Mobiluncus*, *Prevotella* y *Mycoplasma hominis*. 3.01.1.019 | 2.01.1.130

• **CRITERIOS DE AMSEL (Estándar Clínico, se requieren al menos 3 de los 4):**

- **1. Flujo vaginal homogéneo, fino, blanco-grisáceo** que baña uniformemente las paredes vaginales.



Vaginosis bacteriana

- **2. pH vaginal alcalino > 4.5** (generalmente 5.0 a 5.5). 3.01.1.019 | 3.01.5.008 | 2.01.1.130

- **3. Test de Aminas (Whiff Test) POSITIVO:** Al añadir una gota de hidróxido de potasio (KOH al 10%) a la secreción vaginal, se volatilizan aminas aromáticas (cadaverina, putrescina) desprendiendo un fuerte y característico **olor a pescado descompuesto**. 3.01.1.019 | 2.01.1.130

- **4. Presencia de 'Células Clave' o 'Células Guía' (Clue Cells) en el examen microscópico en fresco:** Células epiteliales descamadas cubiertas por una gran cantidad de cocobacilos adheridos que **borran totalmente sus bordes citoplasmáticos celulares (en más del 20% de las células)**. **(ver Imagen 20.9B)**

• **Tratamiento de Elección: METRONIDAZOL oral: 500 mg cada 12 horas durante 7 días** (o gel vaginal al 0.75% por 5 días). Alternativa: Clindamicina 300 mg c/12h oral por 7 días. *Nota fundamental:* **NO se requiere tratamiento de la pareja sexual masculina de rutina** (no reduce recurrencias). Se debe advertir evitar el consumo de alcohol por efecto disulfiram.

2. CANDIDIASIS VULVOVAGINAL

• **Etiología:** Infección oportunista causada en el 85-90% por **Candida albicans** (y 10% por *Candida glabrata* o *krusei*). 3.01.1.019 | 2.01.1.106 | 2.01.1.130

• **Factores Desencadenantes Típicos:** Uso previo de antibióticos de amplio espectro (destruyen lactobacilos protectores), embarazo (altos niveles de estrógenos y glucógeno), diabetes mellitus mal compensada, inmunosupresión y corticoides.

• **Cuadro Clínico Clásico:**

- **Prurito vulvar intenso, continuo y desesperante** (el síntoma cardinal).

- Disuria externa y ardor vulvar.

- **Leucorrea blanca, espesa, grumosa, adherente, descrita clásicamente como 'en leche cortada' o 'en requesón'**, habitualmente sin olor. **(ver Imagen 20.9C)**

- Al examen: vulva y vagina intensamente eritematosas, edematosas, con escoriaciones por rascado y placas blanquecinas adheridas a la mucosa.

• **Diagnóstico:**

- **pH vaginal NORMAL y ácido: < 4.5** (el único cuadro de los tres con pH ácido normal). 3.01.1.019 | 3.01.5.008 | 2.01.1.106 | 2.01.1.130

- **Test de Aminas NEGATIVO.** 3.01.1.019 | 2.01.1.106 | 2.01.1.130

- Examen directo al microscopio con KOH al 10%: visualización de **pseudohifas y esporas (levaduras)**.

• **Tratamiento de Elección:**

- **Tópico: Clotrimazol óvulos vaginales de 100 mg cada noche por 6 días** (o 500 mg dosis única).

- **Oral: Fluconazol 150 mg vía oral en dosis única** (contraindicado en el embarazo; en gestantes solo se usan azoles tópicos como clotrimazol por 7 días).

TABLA 20.9.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MICROBIOLÓGICO Y CLÍNICO DE LAS VULVOVAGINITIS

3.01.1.019, 3.01.1.017, 3.01.5.008, 3.01.5.007, 2.01.1.106, 2.01.1.130

CARACTERÍSTICA	VAGINOSIS BACTERIANA	CANDIDIASIS VULVOVAGINAL	TRICOMONIASIS VAGINAL
Etiología	Disbiosis (Gardnerella + anaerobios)	Candida albicans (hongo levaduriforme)	Trichomonas vaginalis (protozoo flagelado)
Aspecto del Flujo	Homogéneo, blanco-grisáceo, fluido	Blanco, espeso, grumoso ('leche cortada')	Abundante, amarillo-verdoso, espumoso
Síntoma Dominante	Mal olor penetrante ('olor a pescado')	Prurito vulvar intenso y ardor	Flujo abundante, prurito y dispareunia
Eritema / Inflamación	Mínimo o ausente (no inflamatoria)	Eritema vulvovaginal severo + fisuras	Eritema vaginal + 'cuello en fresa'
pH Vaginal	ELEVADO (> 4.5, habitualmente 5.0)	NORMAL / ÁCIDO (< 4.5)	MUY ELEVADO (> 5.0 a 6.0)
Test de Aminas (KOH)	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	Habitualmente POSITIVO (+)
Microscopía en Fresco	Clue cells (> 20%), ausencia lactobacilos	Esporas y pseudohifas filamentosas	Parásito flagelado móvil ovalado
Tratamiento Pareja	NO indicado de rutina	NO indicado (no es ITS)	OBLIGATORIO SIMULTÁNEO (Es ITS)
Tratamiento de Elección	Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7d	Clotrimazol óvulos o Fluconazol 150 mg	Metronidazol 2g oral dosis única (ambos)

20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRICOMONIASIS VAGINAL Y CERVICITIS INFECCIOSA

• **Tricomoniasis Vaginal:** 3.01.1.019 3.01.1.017 2.01.1.130

- Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por el protozoo flagelado **Trichomonas vaginalis**.

- **Clínica:** Leucorrea abundante, **amarillo-verdosa, espumosa, aireada y de mal olor**, asociada a prurito, disuria y dispareunia.

- Examen físico: Marcado eritema vaginal y **colpitis en fresa / cuello en fresa** (petequias y punteado hemorrágico sobre el exocérvix en el 20-30% de los casos).

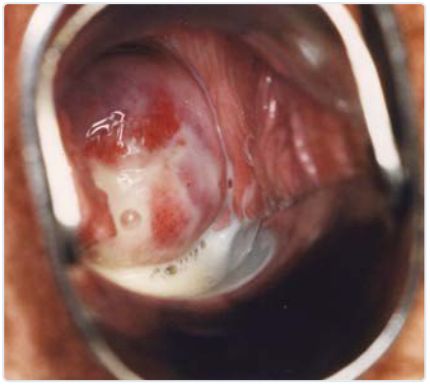
- Diagnóstico: pH > 5.0; microscopía en fresco inmediata que muestra **protozoos piriformes flagelados móviles con movimientos oscilatorios rápidos** y abundantes polimorfonucleares. 3.01.1.019 3.01.1.017 3.01.5.008 2.01.1.130

- **Tratamiento OBLIGATORIO (Pregunta Crítica EUNACOM): METRONIDAZOL a dosis única de 2 gramos por vía oral** (o 500 mg c/12h por 7 días). **ES MANDATORIO EL TRATAMIENTO SIMULTÁNEO DE TODAS LAS PAREJAS SEXUALES**, con abstinencia sexual hasta completar la terapia. 3.01.1.019 3.01.1.017 2.01.1.130

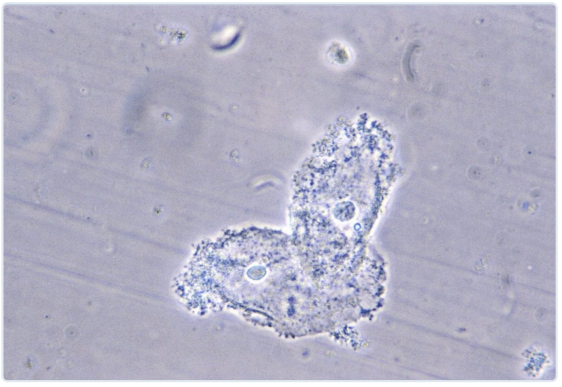
• **Cervicitis Mucopurulenta (Chlamydia y Gonococo):** 3.01.1.019 3.01.1.017

- Secreción purulenta o mucopurulenta que fluye por el orificio cervical externo (canal endocervical), friabilidad del cuello al roce con el hisopo y ectropion sangrante.

- Tratamiento empírico inmediato de cobertura dual: **CEFTRIAXONA 500 mg intramuscular en dosis única** (para *Neisseria gonorrhoeae*) + **DOXICICLINA 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días** (para *Chlamydia trachomatis*) (o Azitromicina 1g oral dosis única en embarazadas). Tratamiento obligatorio a la pareja sexual y notificación ENO.



A. VAGINOSIS BACTERIANA



B. CÉLULAS CLAVE



C. LEUCORREA CANDIDIÁSICA

Imagen 20.9

FIGURA 20.9 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LAS VULVOVAGINITIS

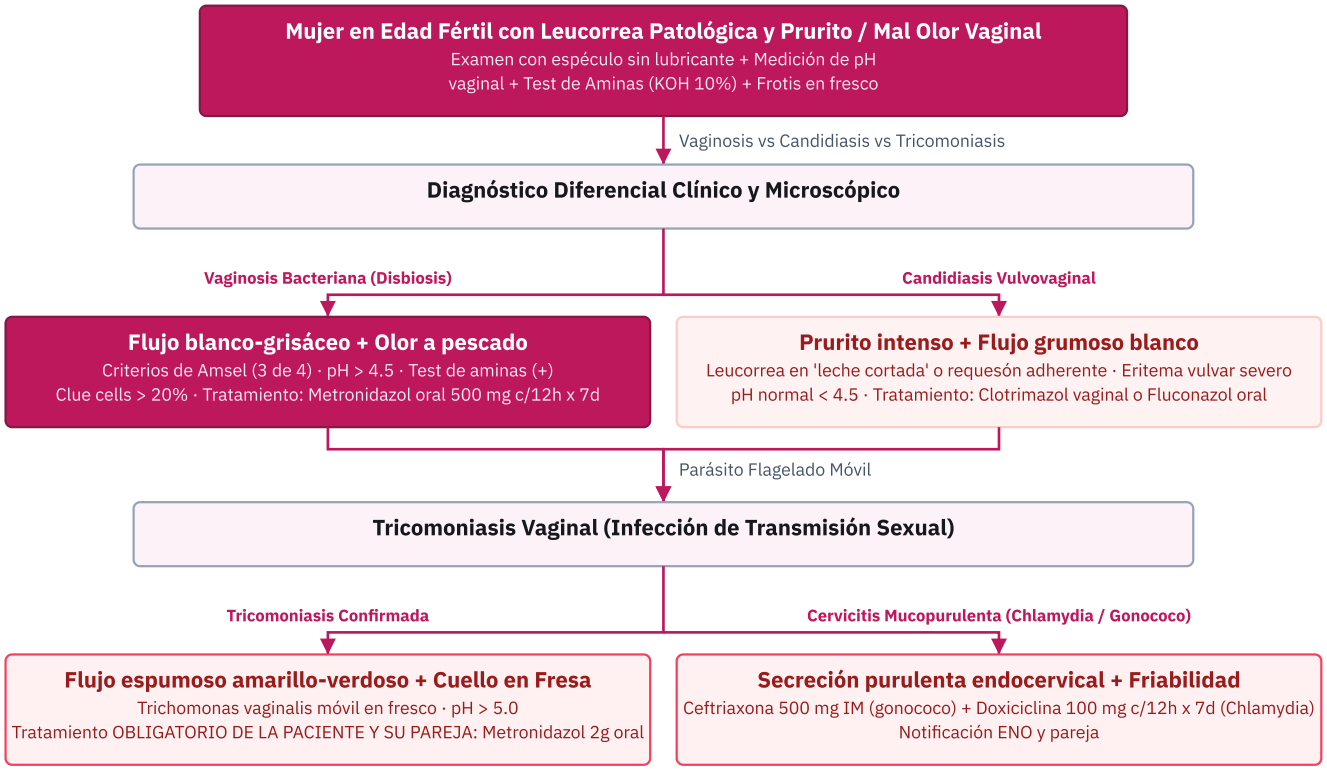


TABLA 20.9.B · COMPLICACIONES ASOCIADAS A INFECCIONES GENITALES NO TRATADAS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

INFECCIÓN GENITAL	POBLACIÓN AFECTADA	COMPLICACIONES MAYORES DEMOSTRADAS
Vaginosis Bacteriana en Embarazadas	Gestantes en 2° y 3° trimestre	Aumento significativo de Rotura Prematura de Membranas (RPM), parto prematuro y corioamnionitis.
Tricomoniasis Vaginal	Mujeres sexualmente activas	Facilita la transmisión y adquisición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras ITS.
Cervicitis por Chlamydia o Gonococo	Mujeres jóvenes en edad fértil	Infección ascendente -> Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP), hidrosálpinx, embarazo ectópico e infertilidad tubárica.
Candidiasis Recurrente	≥ 4 episodios confirmados al año	Descartar Diabetes Mellitus tipo 2 no diagnosticada o infección por VIH oculta.

20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EXAMEN CON ESPÉCULO Y TACTO BIMANUAL; MEDICIÓN DEL PH VAGINAL; OTRAS ITS

• **Especuloscopia (procedimiento: Realizar):** en litotomía, 3.01.5.007 tras inspeccionar la vulva. Se elige un espéculo (Cusco) del tamaño adecuado, **sin lubricante** (solo agua tibia) si se tomarán PAP o cultivos; se introduce cerrado, oblicuo y con presión hacia el piso pélvico, se rota a posición horizontal y se abre hasta ver el cuello.

- Se describe el **cuello** (ectropión, friabilidad, lesiones exofíticas, pólipo, leucorrea, pus mucopurulento por cervicitis, pérdida del epitelio por atrofia) y las **paredes vaginales** (flujo grumoso, espumoso, homogéneo, lesiones herpéticas o condilomas). Se toman las muestras (PAP, pH, fresco, cultivo, PCR de clamidia y gonococo) al ir retirando el espéculo. Luego se completa con el **tacto bimanual** (dolor a la movilización cervical sugiere EIP).

• **pH vaginal (procedimiento: Realizar):** se aplica una cinta 3.01.5.008 de pH en la **pared vaginal lateral** (no en el fondo de saco, para evitar moco cervical, sangre y semen que lo alcalinizan). Normal **3,8-4,5**. **pH > 4,5**: vaginosis bacteriana, tricomoniasis o atrofia; **pH ≤ 4,5**: candidiasis o flujo fisiológico. Complementa el test de aminas (KOH 10%) y el examen en fresco. **(ver Imagen 20.9A)**

• **Otras infecciones de transmisión sexual (Específico / Completo):** 3.01.1.017 manejo sindrómico MINSAL, tratamiento de la pareja, consejería, condón y **oferta de test de VIH, sífilis y hepatitis B**.

- **Sífilis:** chancro indoloro (primaria), exantema palmo-plantar y condilomas planos (secundaria). Diagnóstico con VDRL/RPR más prueba treponémica. Tratamiento: **penicilina benzatina 2,4 millones UI IM** en dosis única (primaria, secundaria, latente precoz) o una vez por semana por 3 semanas (latente tardía o duración desconocida). Notificación obligatoria; control de la pareja.

- **Herpes genital (VHS-2):** vesículas y úlceras dolorosas con adenopatías; diagnóstico clínico o PCR. Tratamiento: **aciclovir 400 mg c/8 h por 7-10 días** (o valaciclovir); supresión crónica si recurrencias frecuentes. **VPH:** condilomas (tipos 6 y 11): podofilotoxina, imiquimod, ácido tricloroacético o crioterapia; la vacuna cuadrivalente previene los tipos 6, 11, 16 y 18. Úlceras con adenopatía dolorosa y fluctuante: linfogranuloma venéreo (doxiciclina) o chancroide (azitromicina).

TABLA 20.9.C · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS OFICIALES DE TRATAMIENTO EN ITS Y VAGINITIS (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CUADRO CLÍNICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN	POSOLOGÍA OFICIAL	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Vaginosis Bacteriana	Metronidazol oral	500 mg cada 12 horas por 7 días	Evitar alcohol durante y hasta 48h post-tratamiento (Efecto Antabuse).
Candidiasis No Complicada	Fluconazol oral (o Clotrimazol vaginal)	150 mg oral dosis única (o óvulos 100 mg/noche x 6 días)	En embarazadas: ¡SOLO TRATAMIENTO TÓPICO (Clotrimazol)! No usar fluconazol oral.
Tricomoniasis Vaginal	Metronidazol oral	2 g por vía oral en dosis única (o 500 mg c/12h x 7d)	TRATAR A LA PAREJA OBLIGATORIAMENTE con el mismo esquema y abstinencia.
Cervicitis Mucopurulenta	Ceftriaxona IM + Doxiciclina oral	Ceftriaxona 500 mg IM única + Doxiciclina 100 mg c/12h x 7d	Cubrir siempre Gonococo + Chlamydia. Notificación obligatoria ENO.

20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR)

- Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > 20%).
- Candidiasis: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).
- Tricomoniasis: ITS con flujo espumoso amarillo-verdoso, cuello en fresa y protozoo flagelado móvil.
- Cervicitis mucopurulenta: Secreción cervical purulenta. Tratamiento dual: Ceftriaxona 500 mg IM + Doxiciclina 7 días.
- Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días. NO requiere tratar a la pareja.
- Tratamiento de Candidiasis: Fluconazol 150 mg oral dosis única o Clotrimazol óvulos (único en embarazo).
- Tratamiento de Tricomoniasis: Metronidazol 2g oral dosis única A LA PACIENTE Y A SU PAREJA OBLIGATORIA.
- Efecto antabuse / disulfiram: Prohibido ingerir alcohol durante el tratamiento con Metronidazol.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.9

Paciente de 23 años, sexualmente activa con nueva pareja desde hace un mes, consulta en el CESFAM por presentar flujo vaginal abundante de color amarillo-verdoso, con burbujas de aire ('espumoso') y de mal olor, asociado a prurito y ardor al orinar. A la especuloscopía se confirma abundante leucorrea espumosa en fondo de saco vaginal y a nivel del exocérvix se evidencian múltiples petequias eritematosas dispersas que confieren un aspecto característico de 'cuello en fresa'. El pH vaginal medido con tirita reactiva es de 5.8 y al frotis directo en fresco con suero fisiológico se aprecian numerosos leucocitos y múltiples microorganismos ovales dotados de flagelos que se desplazan activamente con movimientos rápidos y ondulantes.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico caracterizado por leucorrea abundante espumosa amarillo-verdosa, presencia semiológica patognomónica de 'cuello en fresa' (colpitis macular o en frambuesa), pH marcadamente alcalino (> 5.0) y la visualización directa microscópica de protozoos flagelados móviles con movimientos oscilatorios rápidos es diagnóstico indudable de Tricomoniasis Vaginal producida por Trichomonas vaginalis. Por tratarse de una Infección de Transmisión Sexual (ITS) con elevada tasa de reinfección, la conducta médica obligatoria estipulada por el MINSAL consiste en: 1) Prescribir Metronidazol a dosis de 2 gramos por vía oral en monodosis (o 500 mg cada 12 horas por 7 días); 2) Indicar el MISMO tratamiento antimicrobiano obligatorio a su pareja sexual simultáneamente; 3) Recomendar abstinencia sexual hasta completar la terapia; y 4) Solicitar tamizaje serológico para otras ITS (VIH, VDRL/RPR y VHB).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

1. Una paciente de 25 años acude por flujo vaginal abundante con olor fétido a pescado, que se acentúa después de las relaciones sexuales y de la menstruación. No refiere prurito ni dolor. Al examen con espéculo se observa una secreción homogénea, fluida, de color blanco-grisáceo que recubre la vagina. El pH vaginal es de 5.2. Al agregar una gota de KOH al 10% a la muestra de flujo se desprende un intenso olor a aminas (Whiff test positivo). Al examen microscópico en fresco se aprecian células epiteliales con bordes citoplasmáticos borrosos cubiertos de bacterias ('clue cells'). ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección?

A) Fluconazol 150 mg oral en dosis única a la paciente y a su pareja
B) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días a la paciente
C) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única
D) Nistatina en crema tópica vulvar por 14 días
E) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días a ambos cónyuges

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.008

2. Una mujer de 29 años en tratamiento con amoxicilina por una sinusitis acude a consulta por prurito vulvar desesperante y sensación de ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen físico se evidencia marcado eritema y edema vulvar con fisuras por rascado, y al colocar el espéculo se aprecia una leucorrea blanca espesa en grumos, similar a 'leche cortada', intensamente adherida a las paredes vaginales. El pH vaginal es de 4.0 y el test de aminas con KOH al 10% resulta negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis
B) Candidiasis vulvovaginal
C) Tricomoniasis vaginal sintomática
D) Cervicitis mucopurulenta por Chlamydia trachomatis
E) Vaginitis atrófica senil

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

3. ¿En cuál de las siguientes infecciones ginecológicas del tracto genital inferior es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO prescribir tratamiento farmacológico simultáneo a todas las parejas sexuales de la paciente para evitar la reinfección y cortar la cadena de transmisión epidemiológica?

A) Vaginosis bacteriana recurrente
B) Candidiasis vulvovaginal esporádica
C) Tricomoniasis vaginal
D) Vaginitis inflamatoria descamativa
E) Infección urinaria baja por Escherichia coli

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

4. Una paciente de 21 años consulta por leucorrea purulenta y sangrado postcoital ocasional. A la especuloscopía se observa salida de secreción mucopurulenta espesa por el orificio cervical externo y cuello uterino marcadamente friable que sangra con facilidad al pasar la tórula. La paciente se encuentra afebril y sin dolor a la palpación uterina ni anexial. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico recomendado por las guías del MINSAL mientras se esperan los resultados microbiológicos?

A) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 días oral exclusivamente
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas oral por 10 días
D) Fluconazol 150 mg oral en dosis única
E) Clotrimazol en crema vaginal por 3 noches

Más preguntas online de Infecciones del Tracto Genital Inferior →

20.10. Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.002 3.01.5.004

¿POR QUÉ?

Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino se ubican en el tercio posterior de los labios mayores (a las 4 y 8 horas del introito vaginal) y secretan moco lubricante. Su patología es sumamente frecuente: el Quiste de Bartolino (retención estéril por oclusión del conducto excretor, habitualmente indoloro) y el Absceso de la Glándula de Bartolino (sobreinfección polimicrobiana aguda que provoca dolor exquisito, tumefacción fluctuante e impotencia funcional para sentarse o caminar). En el EUNACOM se evalúa de forma recurrente que el tratamiento curativo del absceso es el drenaje con MARSUPIALIZACIÓN (o catéter de Word) para crear un nuevo orificio permanente, y NO la simple punción. Por su parte, el Liquen Escleroso Vulvar es una dermatosis atrófica autoinmune que causa prurito intratable y se trata con corticoides ultrapotentes (Clobetasol).

1. GLÁNDULA DE BARTOLINO: QUISTE VS ABSCESO AGUDO

• **Anatomía:** Las glándulas de Bartolino están situadas a ambos lados del introito vaginal, en la unión del tercio medio con el tercio posterior de los labios mayores (posiciones horarias de las **4 y 8 del reloj**). Sus conductos excretores de 2 cm drenan en el vestíbulo vulvar por fuera del himen. 3.01.2.002

• **Quiste de la Glándula de Bartolino:** (ver Imagen 20.10A)

- Ocurre por la oclusión mecánica aséptica del conducto excretor (por traumatismo, cirugía previa o moco denso), acumulándose secreción mucosa estéril.

- **Clínica:** Masa redondeada, lisa, móvil, **COMPLETAMENTE INDOLORA y sin signos de eritema ni inflamación**. Si es pequeño es un hallazgo casual; si es grande puede causar molestia mecánica al caminar o durante el coito.



Quiste de la glándula de Bartolino indoloro, sin eritema

- **Manejo:** Si es asintomático: **observación**. Si es sintomático o recurrente: **Marsupialización**.

• **Absceso de la Glándula de Bartolino (Bartonolitis Aguda):** (ver Imagen 20.10B)

- Sobreinfección bacteriana aguda del quiste o de la glándula por flora polimicrobiana mixta (aerobios y anaerobios como *E. coli*, *Bacteroides*, *Staphylococcus* y ocasionalmente gonococo o clamidia).

- **Clínica:** Dolor vulvar paroxístico intensísimo, pulsátil, que **impide sentarse o deambular con normalidad**. Al examen: **masa tumefacta, muy eritematosa, caliente y exquisitamente sensible, con FLUCTUACIÓN CENTRAL** evidente en el introito posterior.

- **Tratamiento de Elección (Pregunta Fija EUNACOM):** 3.01.2.002 3.01.5.004

• **DRENAJE QUIRÚRGICO CON MARSUPIALIZACIÓN:** Consiste en incidir el absceso sobre la mucosa vestibular, lavar la cavidad y **eversar y suturar los bordes de la pared de la glándula a la mucosa vestibular** con puntos reabsorbibles, creando un nuevo ostium permanente de drenaje para evitar que se cierre y recidive.

• **Alternativa Moderna:** Colocación de un **Catéter de Word** (sonda con balón que se insufla con 2-3 mL de suero y se deja 4 semanas para epitelización del tracto fistuloso).

• *Antibioticoterapia complementaria:* Indicada si existe celulitis circundante extensa, fiebre o en pacientes inmunodeprimidas (Cefadroxilo o Amoxicilina/Clavulánico oral). ¡La simple punción con aguja está contraindicada por tasa de recidiva > 80%!

2. LIQUEN ESCLEROSO VULVAR Y DERMATOSIS VULVARES

• **Liquen Escleroso Vulvar:** (ver Imagen 20.10C)

- Dermatosis inflamatoria crónica autoinmune que afecta predominantemente a mujeres postmenopáusicas.

- **Clínica Cardinal: PRURITO VULVAR CRÓNICO INTRACTABLE** de meses o años de evolución, disuria y dispareunia severa.

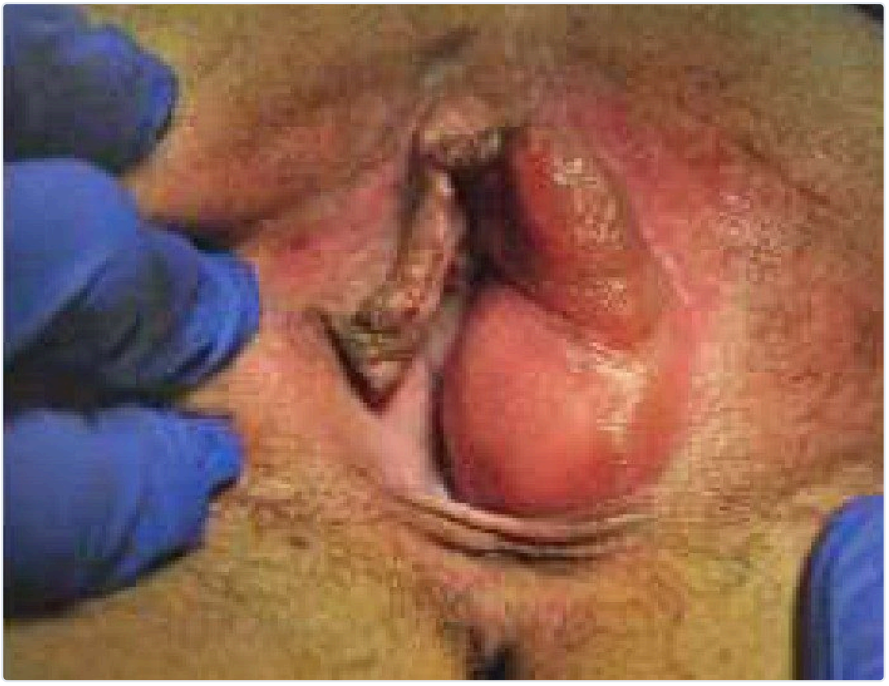
- **Morfología Clásica:** Placas atróficas blanquecinas nacaradas ('en papel de cigarrillo' o parcheado blanco) que rodean la vulva y el ano en un patrón característico **'en figura de ocho' o 'en cerradura'**. Con el tiempo produce borramiento anatómico de los labios menores, enterramiento del clítoris y estenosis progresiva del introito.

- **Riesgo Oncológico Crítico (Pregunta EUNACOM):** Las pacientes con Liquen Escleroso tienen un **riesgo de un 3 a 5% de desarrollar Carcinoma Epidermoide de Vulva** a lo largo de su vida. Ante cualquier área engrosada, queratósica, ulcerada o sobreelevada se debe realizar una **Biopsia con sacabocados (Punch)**.

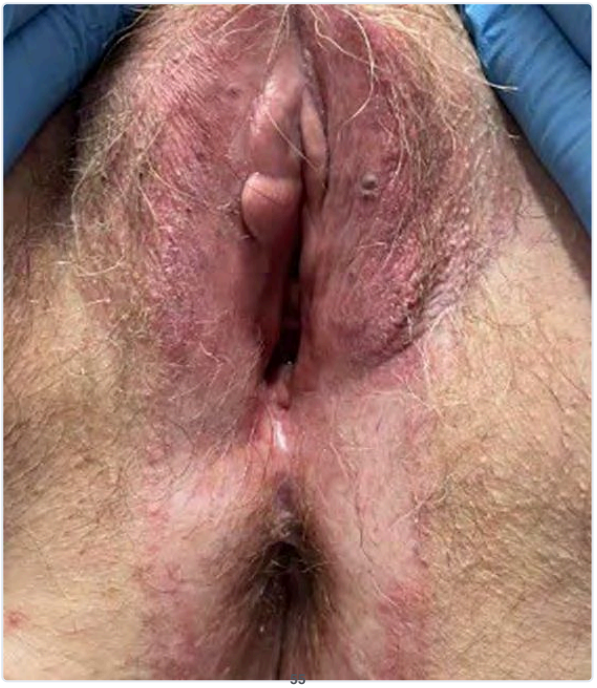
- **Tratamiento de Elección: CORTICOIDES TÓPICOS ULTRAPOTENTES: PROPIONATO DE CLOBETASOL AL 0.05% en ungüento**, aplicado cada noche durante 4 semanas, luego espaciado a noches alternas por 4 semanas y mantenimiento 1-2 veces por semana. Revierte los cambios cutáneos y erradica el prurito.



A. QUISTE DE BARTOLINO



B. ABSCESO DE BARTOLINO



C. LIQUEN ESCLEROSO

Imagen 20.10

FIGURA 20.10 · ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA PATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA DE BARTOLINO Y DERMATOSIS VULVARES



TABLA 20.10 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS VULVARES `3.01.2.002, 3.01.5.004`

ENTIDAD	FISIOPATOLOGÍA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Quiste de Bartolino	Oclusión mecánica aséptica del conducto	Masa redondeada indolora a las 4 u 8 horas del reloj	Observación (si asintomático) o Marsupialización
Absceso de Bartolino	Sobreinfección bacteriana aguda purulenta	Tumefacción fluctuante, eritematosa y exquisitamente dolorosa	Drenaje quirúrgico con MARSUPIALIZACIÓN (o Catéter de Word)
Liquen Escleroso	Dermatosis inflamatoria autoinmune atrófica	Prurito crónico severo + placas blancas nacaradas en 'cerradura'	Corticoides ultrapotentes tópicos: Clobetasol 0.05%
Cáncer de Vulva	Carcinoma epidermoide (asociado a VPH o liquen)	Úlcera vulvar crónica que no cicatriza o masa nodular sangrante	Biopsia punch obligatoria -> Vulvectomía radical + ganglio centinela

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.10

Mujer de 28 años consulta en el servicio de urgencia ginecológica por dolor vulvar unilateral agudo y de inicio brusco en los últimos 2 días, que ha alcanzado una intensidad insoportable que le impide caminar y sentarse. Al examen físico en posición ginecológica se aprecia en el labio mayor derecho, en posición horaria de las 7 a 8 horas, una masa redondeada de 4.5 cm de diámetro, marcadamente eritematosa, caliente, con aumento de volumen fluctuante en su cúspide y extraordinariamente dolorosa a la menor palpación superficial. No se observan úlceras exocervicales y el resto de la vulva es normal.

Conducta oficial. La presencia de una masa unilateral fluctuante, eritematosa y exquisitamente dolorosa ubicada en el tercio posterior del labio mayor (posición horaria de las 7-8 horas) que causa impotencia funcional para la deambulación es diagnóstica de un Absceso de la Glándula de Bartolino agudo. El tratamiento médico-quirúrgico definitivo de primera línea recomendado por las guías del MINSAL es el drenaje quirúrgico con MARSUPIALIZACIÓN (o la inserción de un Catéter de Word bajo anestesia local), técnica que permite evacuar el contenido purulento y abocar los bordes de la cápsula glandular a la piel para crear una nueva fístula permanente de drenaje que previene la recidiva casi segura que ocurre tras una simple incisión y drenaje o punción aspirativa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Localización de glándulas de Bartolino: Tercio posterior de labios mayores (posiciones de las 4 y 8 horas).
- Quiste de Bartolino: Retención de moco aséptica e indolora. Observar si es asintomático.
- Absceso de Bartolino: Infección bacteriana con dolor agudo intenso, masa fluctuante y eritema.
- Tratamiento curativo de elección en Absceso de Bartolino: Drenaje quirúrgico con MARSUPIALIZACIÓN (o Catéter de Word).
- ¡La simple punción con aguja o incisión aislada tiene más del 80% de recidiva y está desaconsejada!
- Liquen escleroso vulvar: Prurito crónico intratable + placas nacaradas en 'figura de ocho' o 'cerradura'.
- Tratamiento de elección en Liquen Escleroso: Propionato de Clobetasol al 0.05% en ungüento tópico.
- Riesgo oncológico del liquen escleroso: 3 a 5% de riesgo de Carcinoma Epidermoide de Vulva (requiere biopsia si lesión sospechosa).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.004

1. Una paciente de 31 años consulta por dolor vulvar progresivo e invalidante que le impide sentarse. Al examen ginecológico se aprecia una masa de 5 cm de diámetro en el labio mayor izquierdo, en posición de las 4 horas del reloj, caliente, fluctuante, muy eritematosa y de extrema sensibilidad al tacto. Se diagnostica un absceso de la glándula de Bartolino. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver el cuadro y prevenir la recidiva?

A) Punción evacuadora con aguja fina bajo anestesia local

B) Incisión, drenaje y marsupialización de la glándula (o colocación de catéter de Word)

C) Vulvectomía simple izquierda

D) Prescripción exclusiva de antibióticos orales sin drenar el absceso

E) Cauterización química con nitrato de plata de la mucosa vestibular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.002

2. Una mujer de 64 años consulta por prurito vulvar intenso y constante de más de 8 meses de evolución que le interrumpe el sueño. Al examen físico se aprecia atrofia severa de los labios menores con enterramiento parcial del clítoris y placas blanquecinas nacaradas adelgazadas de aspecto en papel apergaminado distribuidas en la vulva y región perianal en 'figura de ocho', sin úlceras activas. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco tópico de primera línea de elección?

A) Candidiasis vulvovaginal crónica; Clotrimazol en crema al 1%

B) Liquen Escleroso Vulvar; Propionato de Clobetasol al 0.05% en ungüento tópico

C) Condilomas acuminados gigantes; Imiquimod al 5% en crema

D) Herpes genital recurrente; Aciclovir tópico en crema

E) Psoriasis invertida; Ácido salicílico al 10%

Más preguntas online de Patología Vulvar y Glándula de Bartolino →

20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.025 3.01.2.018

¿POR QUÉ?

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP o Proceso Inflamatorio Pélvico - PIP) comprende el espectro de infecciones del tracto genital superior femenino (endometritis, salpingitis, peritonitis pélvica y absceso tubo-ovárico). Ocurre por ascenso de microorganismos desde la vagina y cuello uterino hacia el endometrio y las trompas. Su etiología es clásicamente polimicrobiana, iniciada por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, sobreagregándose bacilos Gram negativos entéricos y anaerobios del tracto genital. Es una causa mayor de dolor pélvico crónico, embarazo ectópico futuro (el riesgo se multiplica por 6 a 10) e infertilidad tubárica irreversible (hasta un 20% tras el primer episodio y más del 50% tras tres episodios). En el EUNACOM se evalúan los Criterios de Hager, la clasificación de Monif y la estricta diferenciación entre tratamiento ambulatorio y hospitalizado.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

• **Fisiopatología:** Infección canalicular ascendente que progresa desde el canal endocervical hacia el endometrio (endometritis), trompas de Falopio (salpingitis aguda), ovarios (ooforitis / absceso tubo-ovárico) y peritoneo pélvico. **(ver Imagen 20.11A y C)** 3.01.1.025

• **Etiología Polimicrobiana Mixta:**

- **Iniciadores Primarios (ITS): Neisseria gonorrhoeae** (20-30%) y **Chlamydia trachomatis** (30-40%). Producen daño ciliar y necrosis del epitelio tubárico endotubárico.

- **Microorganismos Secundarios Oportunistas:** Anaerobios estrictos (*Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*), enterobacterias Gram negativas (*E. coli*) y *Streptococcus agalactiae*.

- **Actinomyces israelii:** En usuarias de DIU de larga duración (forma abscesos pélvicos en 'gránulos de azufre').

• **Factores de Riesgo Mayores:** Múltiples parejas sexuales, no uso de métodos de barrera (preservativo), edad joven (< 25 años), antecedente de EIP previa e **inserción reciente de DIU en las últimas 3 a 6 semanas** (el DIU aumenta el riesgo de EIP solo durante el primer mes post-colocación por arrastre bacteriano; posteriormente no aumenta el riesgo de EIP).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HAGER Y CLASIFICACIÓN DE MONIF

• **CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HAGER (CDC / MINSAL):** 3.01.1.025

- **Criterios Mayores (MANDATORIOS, DEBEN ESTAR LOS TRES PRESENTES):**

• **1) Dolor a la palpación del abdomen inferior / hipogastrio** (con o sin rebote).

• **2) Dolor a la movilización del cuello uterino** (Signo de Frenkel positivo).

• **3) Dolor a la palpación anexial bimanual** (unilateral o bilateral).

- **Criterios Menores (Refuerzan el diagnóstico; al menos UNO presente):**

• Temperatura axilar > 38.3°C.

• Leucorrea vaginal o secreción endocervical purulenta anormal.

• Proteína C Reactiva (PCR) o Velocidad de Sedimentación (VSG) elevadas.

• Leucocitosis > 10.500 /mm³ con desviación izquierda.

• Evidencia microbiológica de infección endocervical por *N. gonorrhoeae* o *C. trachomatis*.

• **CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE MONIF:**

- **Estadio I (EIP Leve):** Salpingitis aguda **sin peritonitis** ni masas pelvianas.

- **Estadio II (EIP Moderada):** Salpingitis aguda **con peritonitis pélvica** localizada (reacción peritoneal pélvica). 3.01.1.025 3.01.2.018

- **Estadio III (EIP Severa):** Salpingitis aguda con formación de **Absceso Tubo-Ovárico (ATO)** palpable o visualizado por ecografía. 3.01.1.025

- **Estadio IV (EIP Crítica / Quirúrgica): Absceso Tubo-Ovárico ROTO** con peritonitis generalizada y shock séptico. **(ver Imagen 20.11B)** 3.01.1.025 3.01.2.018

TABLA 20.11.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HAGER Y MANEJO DE LA EIP SEGÚN ESTADIO DE MONIF 3.01.1.025, 3.01.2.018

ESTADIO MONIF	DEFINICIÓN CLÍNICA Y HALLAZGOS	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INDICADO
Estadio I	Salpingitis aguda sin pelviperitonitis ni masas	Ambulatorio (con control en 72h)	Ceftriaxona 500 mg IM + Doxiciclina 100 mg c/12h x 14d + Metronidazol x 14d
Estadio II	Salpingitis aguda con pelviperitonitis localizada	Ambulatorio estricto o Hospitalizado	Ceftriaxona IM/EV + Doxiciclina oral + Metronidazol oral x 14 días
Estadio III	Absceso Tubo-Ovárico (ATO) íntegro palpable / eco	HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA	Ceftriaxona 2g EV + Doxiciclina + Metronidazol (o Clindamicina + Gentamicina EV)
Estadio IV	Absceso Tubo-Ovárico ROTO con shock séptico	HOSPITALIZACIÓN UCI / Pabellón	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA DE URGENCIA + Antibióticos EV triples de rescate

20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ESQUEMAS TERAPÉUTICOS

• **Criterios Mandatorios de HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA (Pregunta Fija EUNACOM):** 3.01.1.025

- **1) Sospecha o confirmación ecográfica de Absceso Tubo-Ovárico (ATO) (Monif III).**

- **2) Paciente Embarazada** (la EIP en el embarazo conlleva altísima morbimortalidad materna y fetal).

- **3) Emergencia quirúrgica que no puede descartarse** (imposibilidad de descartar Apendicitis Aguda).

- **4) Cuadro clínico severo** (fiebre alta persistente, vómitos incoercibles, signos de peritonitis difusa o sepsis).

- **5) Falta de respuesta clínica o empeoramiento tras 48 a 72 horas** de tratamiento ambulatorio.

- **6) Intolerancia a la vía oral o falta de adherencia** previsible al tratamiento.

• **Esquema de Tratamiento AMBULATORIO (Monif I y II seleccionados):**

- **CEFTRIAXONA 500 mg intramuscular en dosis única** (cubre gonococo).

- **MÁS DOXICICLINA 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 14 DÍAS COMPLETOS** (cubre Chlamydia).

- **MÁS METRONIDAZOL 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 14 DÍAS COMPLETOS** (cubre anaerobios pélvicos).

- *Control obligatorio en 48 a 72 horas* para evaluar respuesta clínica.

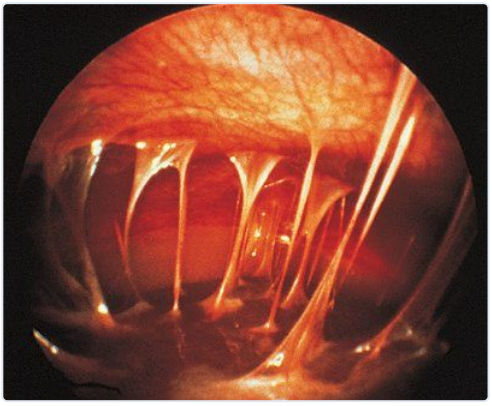
• **Esquema de Tratamiento HOSPITALIZADO ENDOVENOSO (Monif II, III y IV):**

- **Régimen A: Ceftriaxona 1 a 2 g EV al día + Doxiciclina 100 mg oral/EV c/12h + Metronidazol 500 mg EV c/12h**.

- **Régimen B: Clindamicina 900 mg EV c/8h + Gentamicina 5 mg/kg/día EV en dosis única** (esquema clásico para anaerobios y bacilos Gram negativos ante ATO).

- Tras 24 a 48 horas afebril y en franca mejoría, se puede pasar a vía oral completando 14 días con Doxiciclina.

• **Manejo del Absceso Tubo-Ovárico (ATO):** Se inicia tratamiento médico con antibióticos EV de amplio espectro durante 48 a 72 horas (el 70% responde favorablemente). Si no hay mejoría en 48-72h, el absceso mide > 8-10 cm o existe sospecha de **ROTURA DE ATO (Monif IV):** 3.01.2.018 **LAPAROTOMÍA / LAPAROSCOPÍA QUIRÚRGICA DE URGENCIA** para lavado pélvico, drenaje y salpingooforectomía de rescate. 3.01.1.025



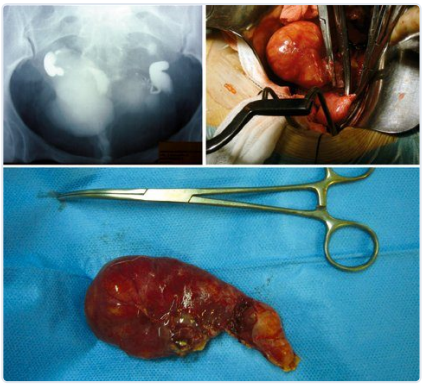
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis: adherencias perihepáticas en cuerdas de violín (laparoscopía)



A. ABSCESO TUBOOVÁRICO (ECO)



B. VISIÓN QUIRÚRGICA



C. ABSCESO EN ECOGRAFÍA

Imagen 20.11

FIGURA 20.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)

Mujer Joven Sexualmente Activa con Dolor Pélvico Agudo en Hipogastrio
Evaluar Criterios Diagnósticos Clínicos de Hager (CDC / MINSAL)

Presencia de los 3 Criterios Mayores Obligatorios

Criterios Clínicos de Hager

Criterios Mayores OBLIGATORIOS (Los 3 presentes)

1) Dolor a la palpación abdominal inferior
2) Dolor a la movilización cervical (Signo de Frenkel +)
+ 3) Dolor a la palpación de los anexos en tacto bimanual

Criterios Menores Auxiliares (≥ 1 apoya el diagnóstico)

Fiebre > 38.3°C · Leucorrea patológica
Leucocitosis > 10.500 · PCR o VSG elevada
Tinción de Gram o cultivo positivo para Gonococo o Chlamydia

¿Cumple Criterios de Hospitalización?

Criterios de Hospitalización Inmediata (Manejo EV)

SÍ: Absceso tubo-ovárico (ATO), embarazo, peritonitis, intolerancia oral o falta de respuesta en 72h

HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA (Vía EV)
Ceftriaxona 1-2g EV/d + Doxiciclina 100 mg c/12h oral/EV +
Metronidazol 500 mg c/12h EV (o Clindamicina + Gentamicina)

NO: EIP leve a moderada (Monif I o II) estable sin masas ni signos peritoneales

Tratamiento Ambulatorio Escalonado
Ceftriaxona 500 mg IM (dosis única) + Doxiciclina 100 mg c/12h oral x 14d + Metronidazol 500 mg c/1
Control 48-72h

TABLA 20.11.B · CRITERIOS MANDATORIOS DE HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA EN EIP (CDC / MINSAL) CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN	RIESGO FISIOPATOLÓGICO MAYOR	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Presencia de Absceso Tubo-Ovárico (ATO)	Riesgo inminente de rotura con peritonitis purulenta y shock séptico	Hospitalización en ARO/Cirugía para antibioterapia parenteral triple EV y monitorización estrecha.
Embarazo Coexistente	Pérdida gestacional, bacteriemia masiva materna y corioamnionitis séptica	Hospitalización en UTI/UCI obstétrica con antibióticos EV de amplio espectro seguros.
Imposibilidad de Descartar Apendicitis Aguda	Perforación apendicular y peritonitis fecal difusa	Hospitalización e interconsulta quirúrgica para laparoscopía exploradora diagnóstica.
Falla Terapéutica Ambulatoria a las 72h	Resistencia antimicrobiana, progresión a colección o falta de adherencia	Ingreso hospitalario inmediato para cambio a antibióticos endovenosos y ecografía pélvica.
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatitis)	Dolor en hipocondrio derecho por adherencias en 'cuerdas de violín' entre cápsula hepática y peritoneo	Mantener antibioticoterapia completa para Chlamydia/Gonococo (cura la inflamación capsular).

20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PELVIPERITONITIS: ABDOMEN AGUDO GINECOLÓGICO

• **Pelviperitonitis (urgencia: Sospecha / Inicial / Completo):** 3.01.2.018 inflamación peritoneal pelviana, habitualmente por **EIP (extensión de la salpingitis) o rotura/fuga de un absceso tubo-ovárico** (Monif IV); también puede ser posaborto o posoperatoria. Cuadro de **dolor hipogástrico intenso, fiebre alta, náuseas, íleo, defensa y signo de Blumberg**, dolor extremo a la movilización del cuello y fondo de saco de Douglas abombado.

- **Diagnóstico:** hemograma (leucocitosis con desviación a izquierda), PCR, β-hCG (descartar ectópico), ecografía TV/TAC (colección, líquido libre, absceso). El diagnóstico diferencial incluye apendicitis, diverticulitis y rotura de quiste ovárico o ectópico.

- **Manejo inicial:** hospitalización, ayuno, hidratación EV, antibióticos EV de amplio espectro (ceftriaxona 1-2 g + metronidazol 500 mg + doxiciclina, o clindamicina + gentamicina) y **laparoscopía/laparotomía de urgencia** con lavado y drenaje si hay sospecha de rotura de ATO, shock séptico o falla del tratamiento médico a las 48-72 horas. Secuelas posibles: infertilidad, embarazo ectópico y dolor pelviano crónico.

TABLA 20.11.C · REGÍMENES ANTIMICROBIANOS OFICIALES EN ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MODALIDAD	FÁRMACOS Y VÍA	DURACIÓN TOTAL	MICROORGANISMOS CUBIERTOS
Ambulatoria (Oral/IM)	Ceftriaxona 500 mg IM única + Doxiciclina 100 mg c/12h VO + Metronidazol 500 mg c/12h VO	14 días completos	Gonococo (Ceftriaxona) + Chlamydia (Doxiciclina) + Anaerobios (Metronidazol).
Hospitalizada Régimen A	Ceftriaxona 1-2 g EV c/24h + Doxiciclina 100 mg c/12h VO/EV + Metronidazol 500 mg c/12h EV	14 días (pasar a oral tras 48h afebril)	Cobertura polimicrobiana completa parenteral.
Hospitalizada Régimen B	Clindamicina 900 mg EV c/8h + Gentamicina 5 mg/kg/día EV dosis única diaria	14 días (esquema clásico para ATO)	Excelente contra anaerobios (Clindamicina) y enterobacterias Gram (-) (Gentamicina).
Tratamiento a la Pareja	Ceftriaxona 500 mg IM + Doxiciclina 100 mg c/12h x 7 días	7 días	Tratamiento OBLIGATORIO a contactos sexuales de los últimos 60 días.

20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EIP / PIP))

- Etiología de EIP: Polimicrobiana mixta iniciada por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae + anaerobios.
- Secuelas mayores a largo plazo: Dolor pélvico crónico, infertilidad tubárica y embarazo ectópico.
- Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis: Perihepatitis con adherencias en 'cuerdas de violín' entre hígado y diafragma.
- Tratamiento ambulatorio: Ceftriaxona 500 mg IM (dosis única) + Doxiciclina 100 mg c/12h x 14d + Metronidazol x 14d.
- Tratamiento obligatorio a contactos sexuales de los últimos 60 días para evitar reinfecciones.
- Criterios mayores de Hager (los 3 obligatorios): Dolor hipogástrico + Dolor a movilización cervical + Dolor anexial.
- Inserción de DIU: Solo aumenta el riesgo de EIP durante las primeras 3 a 6 semanas post-inserción.
- Criterios de hospitalización: Absceso tubo-ovárico (Monif III), embarazo, peritonitis, duda con apendicitis o falla oral.
- Tratamiento de Absceso Tubo-Ovárico roto (Monif IV): LAPAROTOMÍA / CIRUGÍA DE URGENCIA INMEDIATA.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.11

Mujer de 21 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales, consulta en el servicio de urgencia por dolor abdominal bajo en hipogastrio de 4 días de evolución que se ha intensificado progresivamente, asociando sensación febril y flujo vaginal mucopurulento. Al examen físico: T° 38.4°C, PA 115/70 mmHg, FC 92 lpm. Abdomen doloroso a la palpación profunda en ambas fosas ilíacas, sin irritación peritoneal franca. Al examen ginecológico se observa secreción purulenta saliendo por el orificio cervical externo. Al tacto bimanual se constata dolor exquisito a la lateralización del cuello uterino (signo de Frenkel positivo) y gran sensibilidad a la palpación de ambos anexos, sin palparse masas anexiales ni colecciones. La ecografía transvaginal muestra trompas discretamente engrosadas con líquido libre escaso en el Douglas, sin abscesos tubo-ováricos. El test rápido de embarazo es negativo.

Conducta oficial razonada. La paciente cumple con todos los Criterios Mayores de Hager (dolor hipogástrico, dolor a la movilización cervical [Frenkel +] y dolor a la palpación anexial bilateral) asociados a criterios menores (fiebre > 38.3°C y leucorrea purulenta cervical), configurando el diagnóstico certero de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP) Estadio I de Monif (salpingitis aguda no complicada sin peritonitis difusa ni absceso tubo-ovárico). Al encontrarse hemodinámicamente estable, tolerando la vía oral, sin signos peritoneales ni masas ecográficas y habiendo descartado embarazo, la paciente es tributaria de manejo AMBULATORIO. El esquema estándar oficial del MINSAL consiste en: Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única (para cubrir Neisseria gonorrhoeae), asociada a Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral durante 14 días (para cubrir Chlamydia trachomatis) y Metronidazol 500 mg cada 12 horas vía oral durante 14 días (para cobertura de anaerobios), con control clínico obligatorio a las 48-72 horas y tratamiento empírico simultáneo a sus parejas sexuales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

1. Una joven de 20 años acude por dolor en hipogastrio de 3 días de evolución y secreción vaginal amarillenta. Al examen ginecológico se constata dolor intenso al movilizar el cuello uterino hacia ambos lados (signo de Frenkel positivo) y a la palpación profunda de ambos anexos. La temperatura axilar es de 38.5°C. El test de embarazo en orina es negativo. No se palpan masas pélvicas y no hay signos de irritación peritoneal difusa. La paciente tolera adecuadamente los líquidos orales. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano ambulatorio completo más adecuado según las guías clínicas del MINSAL?

A) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 7 días como monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 14 días MÁS Metronidazol 500 mg cada 12 horas oral por 14 días
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
D) Metronidazol 2 g oral en dosis única exclusivamente
E) Gentamicina intramuscular 160 mg dosis única y reposo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas una paciente con diagnóstico clínico de Enfermedad Pélvica Inflamatoria DEBE ser OBLIGATORIAMENTE HOSPITALIZADA para recibir tratamiento antibiótico parenteral por vía endovenosa?

A) Paciente de 24 años con EIP leve (Monif I) y buena tolerancia oral
B) Presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) evidenciado en la ecografía transvaginal
C) Paciente con antecedentes de un episodio de EIP hace dos años ya resuelto
D) Paciente con cultivo positivo para Ureaplasma urealyticum en cuello uterino
E) Paciente con pareja sexual que se niega a recibir tratamiento preventivo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

3. Una paciente de 25 años en tratamiento ambulatorio por una EIP consulta en la urgencia por persistencia del dolor pélvico al que se agrega dolor agudo en hipocondrio derecho que empeora con la inspiración profunda, semejante a una pleuresía. La ecografía hepática y biliar descarta colelitiasis y muestra líquido fino perihepático. En la laparoscopía se observan adherencias finas 'en cuerdas de violín' entre la cápsula de Glisson hepática y la pared abdominal anterior. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación?

A) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatitis por Chlamydia o Gonococo)
B) Hepatitis autoinmune tipo 2
C) Síndrome de Budd-Chiari agudo
D) Absceso hepático amebiano roto
E) Tromboflebitis séptica de la vena porta (Pileflebitis)

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.018

4. Una paciente hospitalizada hace 48 horas por un Absceso Tubo-Ovárico de 8 cm en tratamiento con Clindamicina más Gentamicina endovenosa presenta súbitamente dolor abdominal difuso hiperagudo de intensidad 10/10, palidez profusa, taquicardia de 130 lpm, presión arterial de 80/40 mmHg y abdomen difusamente en tabla con signos de Blumberg y Guéneau de Mussy generalizados. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta médica inmediata que salva la vida de la paciente?

A) Apendicitis perforada; colonoscopía de urgencia
B) Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Monif IV) con shock séptico; traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora de urgencia
C) Embolia pulmonar; inicio inmediato de anticoagulación con heparina
D) Evolución esperable del ATO; aumentar la dosis de gentamicina y esperar 24 horas
E) Hemorragia digestiva alta; endoscopía digestiva alta

Más preguntas online de Enfermedad Pélvica Inflamatoria →

20.12. Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.027 | 3.01.3.005 | 1.03.1.011 | 1.07.3.010

¿POR QUÉ?

La Menopausia se define como el cese permanente de la menstruación diagnosticado retrospectivamente tras doce (12) meses consecutivos de amenorrea no explicada por otra causa médica, marcando el fin de la etapa reproductiva ovárica (edad promedio en Chile: 48 a 50 años). El Climaterio abarca el período de transición perimenopáusico y postmenopáusico caracterizado por el hipoestrogenismo progresivo (elevación de FSH > 30-40 UI/L por pérdida de retroalimentación de inhibina y estradiol). La Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) es el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores (bochornos) y el síndrome genitourinario de la menopausia. Para el EUNACOM es crucial dominar la 'ventana de oportunidad' de inicio seguro, la regla de protección endometrial con progestágenos si tiene útero, y las contraindicaciones absolutas de la TRH.

1. FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y MANIFESTACIONES DEL HIPOESTROGENISMO

• **Diagnóstico:** El diagnóstico de menopausia es **EMINENTEMENTE CLÍNICO**: cese de las menstruaciones durante **12 meses consecutivos** en una mujer mayor de 45 años sin otra causa evidente. *¡En mujeres en edad habitual NO se requieren exámenes de laboratorio hormonales de rutina para confirmar la menopausia!* (Solo se solicita **FSH y Estradiol** en mujeres menores de 40-45 años para diagnosticar Insuficiencia Ovárica Prematura: **FSH > 30-40 UI/L con Estradiol < 20 pg/mL**). 3.01.1.027 | 1.03.1.011

• **Manifestaciones Clínicas según Fases del Climaterio:**

- **Corto Plazo: Síntomas vasomotores (Bochornos / Sofocos y sudoración nocturna profusa en 75% de las mujeres)**, insomnio, irritabilidad y labilidad emocional.

- **Mediano Plazo (Síndrome Genitourinario de la Menopausia):** Atrofia vulvovaginal por pérdida del epitelio escamoso estratificado dependiente de estrógenos (sequedad vaginal, prurito, dispareunia severa), polaquiuria, disuria e infecciones urinarias bajas recurrentes por elevación del pH vaginal (> 5.0) al desaparecer los lactobacilos. 3.01.1.027 | 1.03.1.011 | 1.07.3.010

- **Largo Plazo: Osteoporosis** (acelerada pérdida ósea trabecular) con alto riesgo de fracturas por fragilidad (cadera, vértebras, Colles) y **aumento del riesgo cardiovascular** (cambio adverso en el perfil lipídico con aumento de LDL y caída de HDL). 3.01.1.027 | 1.03.1.011

2. TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL (TRH): VENTANA DE OPORTUNIDAD

• **Indicaciones Formales de TRH Sistémica:** Síntomas vasomotores moderados a severos (bochornos que alteran la calidad de vida), prevención de osteoporosis en mujeres de alto riesgo con síntomas asociados e hipoestrogenismo antes de los 50 años (Insuficiencia Ovárica Prematura). 3.01.1.027 | 3.01.3.005 | 1.03.1.011

• **El Concepto de la 'Ventana de Oportunidad' (Concepto Central EUNACOM):**

- La TRH tiene una relación beneficio/riesgo claramente favorable cuando se inicia en mujeres **menores de 60 años de edad o dentro de los primeros 10 años desde la menopausia**.

- Iniciar TRH en esta ventana otorga beneficio cardiovascular y óseo con mínimo riesgo.

- Por el contrario, iniciar TRH en mujeres **mayores de 60 años o con más de 10 años postmenopáusicas** está desaconsejado, ya que aumenta el riesgo de eventos coronarios, ACV y demencia.

• **Regla de Prescripción según Presencia de Útero (Pregunta Garantizada):**

- **Mujer CON ÚTERO INTACTO: OBLIGATORIO: ESTRÓGENOS + PROGESTÁGENO**. Los estrógenos solos inducen hiperplasia y cáncer de endometrio. El progestágeno (ej. Progesterona micronizada oral 100-200 mg/d o Didrogesterona) se agrega exclusivamente para **proteger el endometrio**.

- **Mujer HISTERECTOMIZADA (Sin Útero): ESTRÓGENOS SOLOS (Monoterapia)**. No requiere progestágeno; de hecho, evitar el progestágeno elimina el leve aumento de riesgo de cáncer de mama asociado a la terapia combinada.

3. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS DE LA TRH Y ALTERNATIVAS NO HORMONALES

• **CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS FORMALES DE LA TRH SISTÉMICA:** 3.01.1.027 | 3.01.3.005 | 1.03.1.011

- **1. Antecedente personal o sospecha de Cáncer de Mama.**

- **2. Antecedente de neoplasia maligna estrógeno-dependiente (Cáncer de Endometrio).**

- **3. Tromboembolismo Venoso Activo o Antecedente Personal de TVP / TEP.**

- **4. Enfermedad Coronaria o Cardiovascular Activa (Infarto previo, ACV o AIT).**

- **5. Sangrado Uterino Anormal no diagnosticado / no filiado.**

- **6. Enfermedad Hepática Aguda Severa o Insuficiencia Hepática descompensada.**

• **Alternativas para Pacientes con Contraindicación de TRH:**

- Para síntomas vasomotores (bochornos): **Inhibidores de recaptura de serotonina/noradrenalina (ISRS/IRSN)** como **Paroxetina** (dosis baja 7.5 mg/d), **Venlafaxina** (37.5 a 75 mg/d) o **Gabapentina**. *¡Precaución!: La Paroxetina está contraindicada en pacientes tratadas con Tamoxifeno (inhibe el citocromo CYP2D6 bloqueando la activación del tamoxifeno; en ellas se usa Venlafaxina).*

- Para Atrofia Vulvovaginal exclusiva: **Estrógenos Tópicos Locales a bajas dosis (Estriol en crema o promestrieno vaginal)**. Tienen mínima absorción sistémica y son seguros incluso en muchas pacientes con cáncer previo tras pase del oncólogo. 3.01.1.027 | 3.01.3.005 | 1.03.1.011 | 1.07.3.010

4. SEXUALIDAD EN LA PERSONA MAYOR

• **Sexualidad en personas mayores:** la actividad y el interés sexual se mantienen en gran parte de los adultos mayores; el envejecimiento condiciona cambios, no el fin de la sexualidad. En la mujer: **atrofia vulvovaginal, sequedad, dispareunia**, menor lubricación y respuesta más lenta. En el hombre: menor erección y mayor período refractario, con **disfunción eréctil** más frecuente (diabetes, HTA, enfermedad vascular, fármacos, prostatectomía). 1.07.3.010

- **Abordaje:** incluir una pregunta sobre sexualidad en la anamnesis sin prejuicios, revisar **fármacos** (antihipertensivos, antidepresivos ISRS, antipsicóticos, benzodiacepinas), depresión, dolor y comorbilidades, y la ausencia de pareja o de privacidad (viudez, institucionalización). Para la dispareunia: lubricantes, hidratantes y **estrógenos vaginales locales** (estriol); inhibidores de la PDE-5 en la disfunción eréctil, contraindicados con nitratos.

- Educar sobre **prevención de ITS** (VIH y sífilis aumentan en mayores): uso de condón y tamizaje.

FIGURA 20.12 · ALGORITMO DE INDICACIÓN DE TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL (TRH)

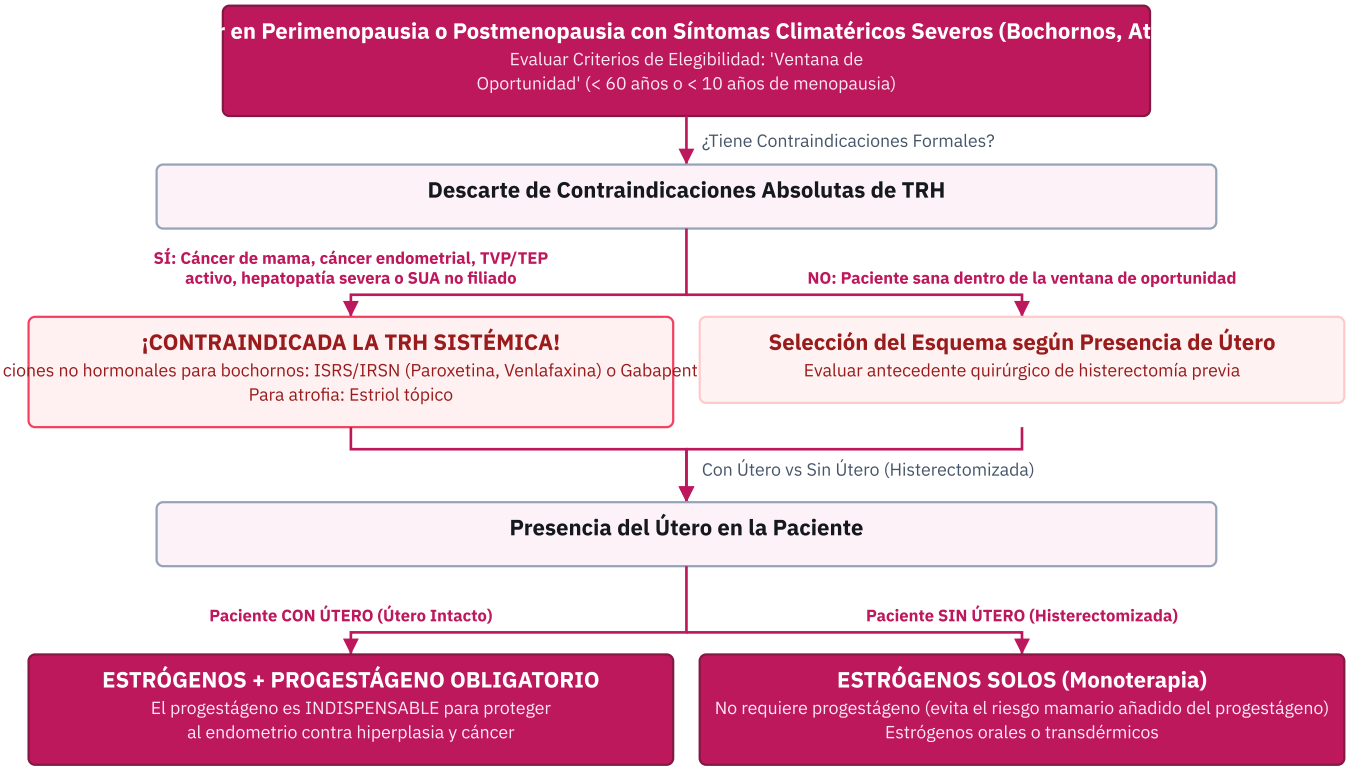


TABLA 20.12 · ESQUEMAS DE TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL SEGÚN ANATOMÍA UTERINA

3.01.1.027, 3.01.3.005, 1.03.1.011, 1.07.3.010

SITUACIÓN ANATÓMICA	COMPOSICIÓN DE LA TRH	VÍA PREFERENTE	RAZÓN FISIOPATOLÓGICA
Mujer con Útero Intacto	Estrógenos + Progestágeno (Continuo o Cíclico)	Oral o Transdérmica (parche/gel)	El progestágeno es OBLIGATORIO para prevenir hiperplasia y cáncer de endometrio.
Mujer Histerectomizada	Estrógenos SOLOS (Monoterapia estrogénica)	Oral o Transdérmica	No hay endometrio que proteger; evita el riesgo mamario añadido del progestágeno.
Atrofia Vaginal Exclusiva	Estrógenos Tópicos Locales (Estriol / Promestrieno)	Crema u óvulos vaginales	Alivio directo urogenital sin efectos secundarios sistémicos ni necesidad de progestágeno.
Riesgo Trombótico Leve / HTA	Estrógenos Transdérmicos (Gel o Parche)	Vía Transdérmica estricta	Evita el primer paso hepático, no estimula factores de coagulación ni triglicéridos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

20.12

Paciente de 52 años, menopáusica desde hace 2 años, sin antecedentes médicos relevantes, acude a control ginecológico por bochornos intensos y súbitos unas 10 a 12 veces al día que se acompañan de sudoración nocturna profusa e insomnio, deteriorando severamente su rendimiento laboral y calidad de vida. No tiene antecedentes de trombosis, su mamografía bilateral realizada hace 2 meses es normal (BI-RADS 1) y no tiene factores de riesgo cardiovascular. La paciente fue sometida a una histerectomía total con conservación de ambos anexos hace 5 años por una miomatosis sintomática. Solicita tratamiento para aliviar sus sofocos.

Conducta oficial. La paciente se encuentra en la 'ventana de oportunidad' ideal para el inicio de Terapia de Reemplazo Hormonal (52 años, menos de 10 años desde la menopausia, sin contraindicaciones cardiovasculares ni mamarias) para tratar sus síntomas vasomotores moderados a severos. Dado que la paciente tiene el antecedente quirúrgico de HISTERECTOMÍA TOTAL (no tiene útero), el esquema terapéutico de elección es la MONOTERAPIA CON ESTRÓGENOS SOLOS (vía oral o transdérmica, como estradiol 1-2 mg/día o gel transdérmico). En mujeres histerectomizadas está formalmente desaconsejado y proscrito añadir un progestágeno a la terapia, debido a que no existe endometrio que proteger de hiperplasia, y la evidencia científica ha demostrado de forma concluyente que es el componente progestágeno el principal responsable del incremento en el riesgo de cáncer de mama.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diagnóstico de menopausia: Clínico (12 meses continuos de amenorrea en > 45 años). No requiere exámenes de rutina.
- Ventana de oportunidad de TRH: Iniciar en < 60 años o < 10 años postmenopausia para máximo beneficio y mínimo riesgo.
- Mujer CON útero: OBLIGATORIO asociar Progestágeno al Estrógeno para proteger contra Cáncer de Endometrio.
- Mujer SIN útero (histerectomizada): Estrógenos SOLOS en monoterapia (¡NO agregar progestágeno!).
- Atrofia urogenital aislada: Estrógenos tópicos locales (Estriol vaginal) de mínima absorción sistémica.
- Contraindicaciones absolutas de TRH: Cáncer de mama, cáncer de endometrio, TVP/TEP, cardiopatía isquémica, SUA no filiado.
- Alternativa no hormonal a los bochornos en pacientes con cáncer de mama: Venlafaxina o Paroxetina (evitar paroxetina con tamoxifeno).
- Vía transdérmica de estrógenos: De elección en mujeres con hipertensión, hipertrigliceridemia o sobrepeso por evitar paso hepático.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.027

1. Una paciente de 51 años con antecedentes de histerectomía total por miomatosis hace 3 años consulta por bochornos intensos e insomnio que afectan severamente su calidad de vida tras cesar sus síntomas ováricos hace 1 año. No tiene antecedentes oncológicos personales ni familiares, y su mamografía reciente es normal (BI-RADS 2). ¿Cuál es el esquema de Terapia de Reemplazo Hormonal de elección para esta paciente?

A) Estrógenos solos en monoterapia (vía oral o transdérmica)
B) Estrógenos combinados con progesterona micronizada continua
C) Progestágenos solos a altas dosis
D) Moduladores selectivos de receptores androgénicos exclusivamente
E) Está formalmente contraindicada cualquier hormona por el antecedente de histerectomía

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.027

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas constituye una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para la prescripción de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica en una mujer con síntomas climatéricos?

A) Antecedente personal tratado de Cáncer de Mama ductal infiltrante
B) Osteoporosis densitométrica con T-score de -2.8
C) Atrofia vulvovaginal sintomática con dispareunia
D) Edad menor a 45 años con menopausia quirúrgica
E) Sofocos moderados en una mujer de 50 años sana

Más preguntas online de Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 20.9 A 20.12

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +...	**Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días. NO requiere tratar a...**	Efecto antabuse / disulfiram: Prohibido ingerir alcohol durante el tratamiento con...
Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	Localización de glándulas de Bartolino: Tercio posterior de labios mayores (posiciones...	**Quiste de Bartolino: Retención de moco aséptica e indolora. Observar si es asintomático.**	—
Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos	Etiología de EIP: Polimicrobiana mixta iniciada por Chlamydia trachomatis y Neisseria...	**Criterios mayores de Hager (los 3 obligatorios): Dolor hipogástrico + Dolor a...**	Tratamiento obligatorio a contactos sexuales de los últimos 60 días para evitar...
Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos	Diagnóstico de menopausia: Clínico (12 meses continuos de amenorrea en > 45 años). No...	**Ventana de oportunidad de TRH: Iniciar en < 60 años o < 10 años postmenopausia para...**	Contraindicaciones absolutas de TRH: Cáncer de mama, cáncer de endometrio, TVP/TEP...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > 20%).

Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días. NO requiere tratar a la pareja.

Candidiasis: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).

Tratamiento de Candidiasis: Fluconazol 150 mg oral dosis única o Clotrimazol óvulos (único en embarazo).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días. NO requiere tratar a la pareja.
- Candidiasis: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).
- Quiste de Bartolino: Retención de moco aséptica e indolora. Observar si es asintomático.
- Absceso de Bartolino: Infección bacteriana con dolor agudo intenso, masa fluctuante y eritema.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > 20%).	Tema 20.9 →
Localización de glándulas de Bartolino: Tercio posterior de labios mayores (posiciones de las 4 y 8 horas).	Tema 20.10 →
Etiología de EIP: Polimicrobiana mixta iniciada por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae + anaerobios.	Tema 20.11 →
Diagnóstico de menopausia: Clínico (12 meses continuos de amenorrea en > 45 años). No requiere exámenes de rutina.	Tema 20.12 →

MANUAL EUNACOM DE GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía 70

20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna 76

20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores 81

20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico 86

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.013, 3.01.1.016, 3.01.3.013, 3.01.4.007, 3.01.5.013, 3.01.5.014	Cáncer Cervicouterino	Específico	Completo	Completo
3.01.1.030, 3.01.1.029, 3.01.4.002, 3.01.3.013, 3.01.4.006, 4.01.1.035, 4.01.1.036, 4.01.3.012, 4.01.4.009	Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico	Específico	Completo	Completo
3.01.1.024, 3.01.1.028, 3.01.4.005, 1.08.3.002	Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Específico	Inicial	Completo
3.01.2.019, 3.01.2.016	Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- GES N° 3 Cáncer Cervicouterino: Tamizaje universal con PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años.
- Etiología: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en 60% y VPH 18 en 15%).
- Oncoproteínas oncogénicas: E6 degrada al gen supresor p53; E7 inactiva a la proteína pRb.
- PAP con LIEAG (H-SIL) o NIE II-III: DERIVACIÓN INMEDIATA A COLPOSCOPÍA Y BIOPSIA en UPC (Garantía GES < 30 días).
- Tratamiento de NIE II / NIE III: Conización cervical (LEEP o Cono Frío) con márgenes libres.
- Síntoma clínico más temprano del cáncer invasor: Sangrado postcoital (sinusorragia) indoloro.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Cáncer Cervicouterino	EUNACOM Julio 2025 · #60 · EUNACOM Diciembre 2025 · #172 · EUNACOM Julio 2025 · #59 · EUNACOM Julio 2024 · #91
Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico	EUNACOM Diciembre 2025 · #44 · EUNACOM Diciembre 2025 · #166 · EUNACOM Diciembre 2025 · #147 · EUNACOM Diciembre 2025 · #172
Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	EUNACOM Julio 2025 · #84 · EUNACOM Diciembre 2024 · #166 · EUNACOM Julio 2024 · #177 · EUNACOM Enero 2023 · #61
Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	EUNACOM Julio 2024 · #58 · EUNACOM Diciembre 2024 · #162 · EUNACOM Enero 2023 · #63 · EUNACOM Diciembre 2022 · #113

20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.013 | 3.01.1.016 | 3.01.3.013 | 3.01.4.007 | 3.01.5.013 | 3.01.5.014

¿POR QUÉ?

El Cáncer Cervicouterino (CCU) es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente y una causa mayor de muerte prevenible en mujeres chilenas en edad fértil y perimenopáusica. Está cubierto integralmente por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 3). El 99.7% de los casos se debe a la infección persistente por genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH), principalmente los tipos 16 y 18. El tamizaje universal en Chile se realiza con el Papanicolaou (PAP) cada 3 años entre los 25 y 64 años (y progresivamente con Test de VPH). El médico general debe dominar el algoritmo ante un PAP alterado (derivación obligatoria a Colposcopía y biopsia en la Unidad de Patología Cervical - UPC) y el corte crucial de tratamiento: la cirugía radical se reserva para estadios precoces confinados al cuello, mientras que ante invasión de parametrios (Estadio ≥ IIB) la cirugía está estrictamente contraindicada y el tratamiento curativo es la Quimiorradioterapia con Cisplatino.

1. EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA DEL VPH Y TAMIZAJE GES

• **Etiología y Oncogénesis del VPH:** El VPH es una infección de transmisión sexual extraordinariamente común. Los serotipos de **Alto Riesgo Oncogénico** son el **16 (responsable del 50-60% de los carcinomas epidermoides)** y el **18 (responsable del 15-20% y del adenocarcinoma endocervical)**, seguidos por el 31, 33, 45 y 52. Las oncoproteínas virales **E6 (que degrada al gen supresor p53)** y **E7 (que inactiva a la proteína del retinoblastoma pRb)** bloquean la apoptosis y desatan la inestabilidad genómica y transformación maligna. 3.01.1.013 3.01.1.016

• **Vacunación Preventiva (PNI Chile):** Vacuna nonavalente (Gardasil 9) administrada gratuitamente en escolares de 4° básico (1.ª dosis) y 5° básico (2.ª dosis) a niñas y niños. 3.01.1.016

• **Programa Nacional de Tamizaje GES (Guía Clínica MINSAL):** 3.01.3.013 3.01.4.007

- **Población Objetivo:** Mujeres de **25 a 64 años de edad**.

- **Periodicidad: Papanicolaou (PAP) cada 3 años** tras dos exámenes anuales consecutivos negativos.

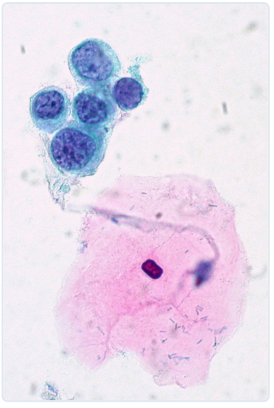
- **Test de ADN-VPH:** Incorporado en programas piloto y actualización MINSAL como método primario a partir de los 30 años (cada 5 años si es negativo; si VPH 16 o 18 positivo -> derivación directa a colposcopía).

2. CLASIFICACIÓN DE BETHESDA Y ALGORITMO ANTE PAP ALTERADO

• **Clasificación Citológica del Sistema Bethesda:** 3.01.1.016 3.01.4.007

- **Células Escamosas Atípicas: ASC-US** (de significado indeterminado) y **ASC-H** (no se puede descartar lesión de alto grado). **(ver Imagen 20.13A y B)**

- **Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado (LIEBG / L-SIL):** Corresponde a infección citopática por VPH / Neoplasia Intraepitelial Cervical grado 1 (**NIE I**). Más del 80% regresiona espontáneamente en 2 años.



Citología cervical

- **Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL):** Corresponde a **NIE II y NIE III / Carcinoma in situ (CIS)**. Alto riesgo de progresión a cáncer invasor.

- **Carcinoma Escamoso Invasor / Células Glandulares Atípicas (AGC / ACG-N / Adenocarcinoma).**

• **Conducta Mandatoria de Derivación GES (Garantía de Acceso en < 30 días):**

- Todo PAP informado como **LIEAG, NIE II, NIE III, sospecha de invasión, ASC-H o AGC** DEBE ser derivado de forma **INMEDIATA a la Unidad de Patología Cervical (UPC) para COLPOSCOPÍA y BIOPSIA DIRIGIDA**.

- En caso de **ASC-US o LIEBG en mayores de 30 años**: se deriva a colposcopía o se repite PAP en 6 meses (según norma local); si persiste alterado -> colposcopía.

• **Colposcopía y Procedimientos Terapéuticos Preinvasores:** 3.01.1.016

- Evaluación con ácido acético al 3-5% (áreas acetoblancas densas, mosaicos, puntillado) y Test de Schiller con Lugol (captación yodo-negativa patológica).

- **Tratamiento de NIE II / NIE III: CONIZACIÓN CERVICAL** mediante resección con asa electroquirúrgica (**LEEP**) o Cono Frío quirúrgico con bisturí. Diagnóstica y curativa al evaluar márgenes libres.

TABLA 20.13.A · ETAPIFICACIÓN FIGO Y TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

3.01.1.013, 3.01.1.016, 3.01.3.013, 3.01.4.007, 3.01.5.013, 3.01.5.014

ESTADIO FIGO	EXTENSIÓN ANATÓMICA DEL TUMOR	TRATAMIENTO PRIMARIO DE ELECCIÓN	PRONÓSTICO (SG 5 AÑOS)
Estadio IA1	Microscópico: Invasión estromal < 3 mm sin invasión vascular	Conización cervical (si desea fertilidad) o Histerectomía total	> 98%
Estadio IB1 / IB2	Tumor invasor confinado a cérvix (< 4 cm de diámetro)	Histerectomía Radical + Linfadenectomía (Wertheim-Meigs)	85 - 90%
Estadio IIA1	Invasión vaginal superior < 4 cm sin parametrios	Cirugía Radical de Wertheim-Meigs o Quimiorradioterapia	75 - 80%
Estadio IIB	INVASIÓN DE PARAMETRIOS (sin llegar a pared pélvica)	QUIMIORRADIOTERAPIA (Cisplatino + Radioterapia + Braquiterapia)	60 - 65%
Estadio IIIB	Extensión a pared pélvica y/o Hidronefrosis renal	Quimioterapia con Cisplatino + Radioterapia pélvica	35 - 45%
Estadio IVA / IVB	Invasión de vejiga/recto o Metástasis a distancia	Tratamiento sistémico paliativo (Platino + Paclitaxel + Bevacizumab)	< 15%

20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CÁNCER INVASOR: ETAPIFICACIÓN FIGO Y TRATAMIENTO RADICAL VS QUIMIORRADIOTERAPIA

• **Clínica del CCU Invasor:** El síntoma inicial más clásico es el **sangrado genital postcoital (sinusorragia)** o metrorragia intermenstrual, seguido de leucorrea serohemática fétida 'en agua de lavar carne'. Al espéculo: masa vegetante friable o úlcera en cuello. 3.01.1.013



Cáncer cervicouterino invasor

• **Etapificación FIGO del Cáncer Cervicouterino (CORTE CLÍNICO DETERMINANTE EUNACOM):**

- **Estadio I:** Carcinoma estrictamente confinado al cérvix (IA1 microscópico < 3 mm; IA2 3-5 mm; IB1 < 2 cm; IB2 2-4 cm; IB3 ≥ 4 cm).

- **Estadio II:** El tumor invade más allá del útero pero NO llega a la pared pélvica ni al tercio inferior de la vagina:

• **IIA:** Invade los dos tercios superiores de la vagina SIN comprometer parametrios.

• **IIB (PUNTO DE INFLEXIÓN TERAPÉUTICA): INVASIÓN DE PARAMETRIOS** (pero sin llegar a la pared ósea pélvica).

- **Estadio III:** Invade tercio inferior de vagina (IIIA) o llega a la pared pélvica / hidronefrosis (IIIB) o metástasis ganglionares pélvicas/paraórticas (IIIC).

- **Estadio IV:** Invade mucosa de vejiga o recto (IVA) o metástasis a distancia (IVB).

• **Regla Terapéutica de Oro Absoluta (Pregunta Fija EUNACOM):**

- **Estadios Precoces SIN INVASIÓN DE PARAMETRIOS (IA, IB1, IB2, IIA1): TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RADICAL** mediante **Histerectomía Radical con Linfadenectomía Pélvica bilateral (Operación de Wertheim-Meigs)** o traquelectomía radical con conservación uterina si desea fertilidad en estadios muy iniciales.

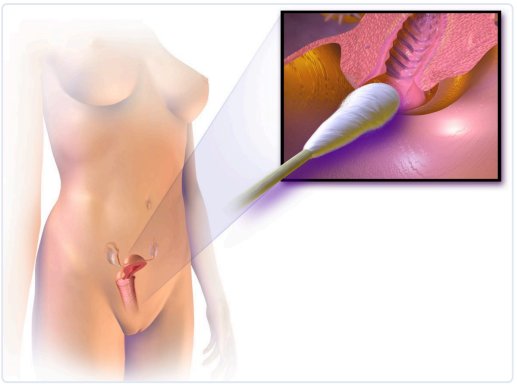
- **Estadios Avanzados CON INVASIÓN DE PARAMETRIOS (≥ ESTADIO IIB): ¡LA CIRUGÍA ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDA Y CONTRAINDICADA!** El tratamiento curativo de elección es la **QUIMIOTERAPIA CONCOMITANTE BASADA EN CISPLATINO MÁS RADIOTERAPIA EXTERNA Y BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA**.



A. LESIÓN DE BAJO GRADO



B. LESIÓN DE ALTO GRADO



C. TOMA DE PAPANICOLAU

Imagen 20.13

FIGURA 20.13 · ALGORITMO DE TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER CERVICOUTERINO (GES)

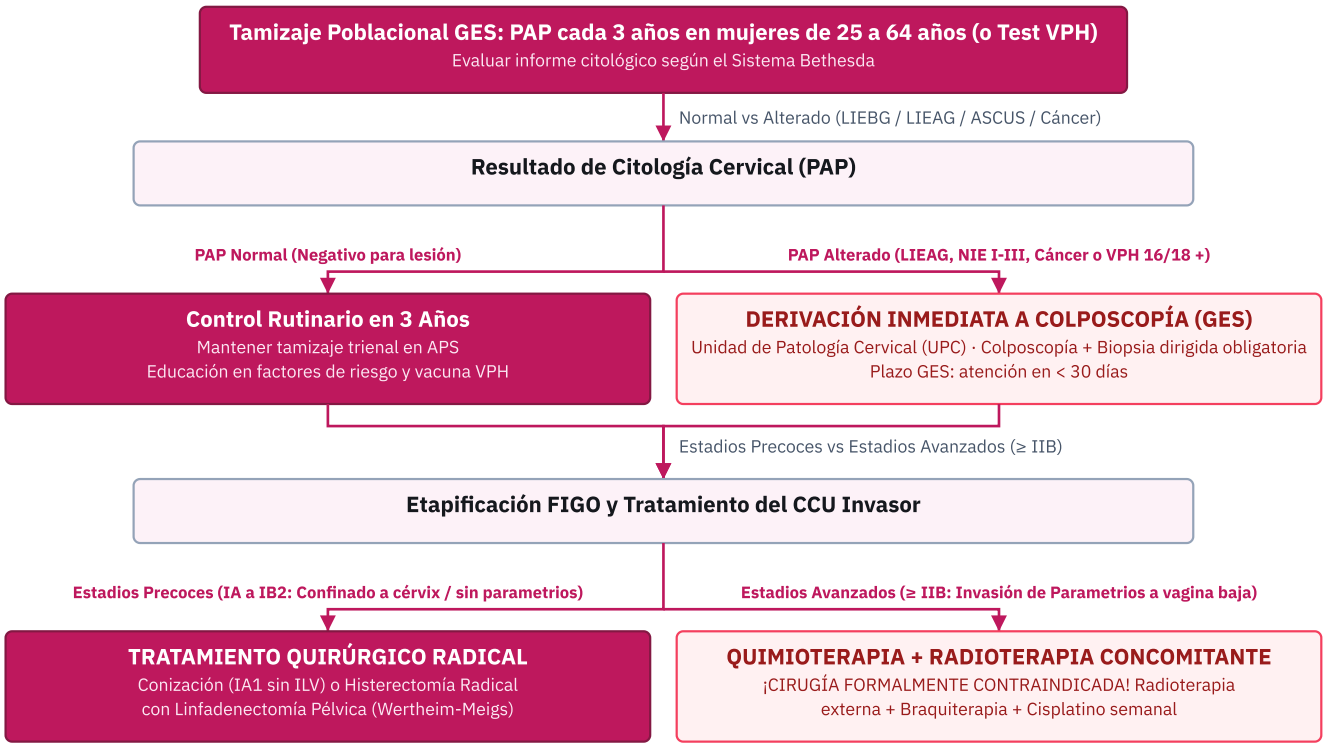


TABLA 20.13.B · GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES N° 3): PLAZOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN EN CCU — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ETAPA DE LA GARANTÍA GES	PLAZO MÁXIMO LEGAL GARANTIZADO POR LEY	ACCIÓN MÉDICA MANDATORIA
Confirmación Diagnóstica	Dentro de 30 días desde la sospecha (PAP alterado)	Atención en UPC por ginecólogo especialista + Colposcopía y Biopsia.
Etapificación Completa	Dentro de 20 días desde la confirmación diagnóstica	RMN pélvica, cistoscopía, rectoscopía y evaluación preoperatoria.
Inicio de Tratamiento Preinvasor	Dentro de 30 días desde la indicación	Conización LEEP o Cono Frío con márgenes quirúrgicos libres.
Inicio de Tratamiento Cáncer Invasor	Dentro de 20 a 30 días desde la indicación	Cirugía radical (Wertheim-Meigs) o inicio de Quimiorradioterapia con Cisplatino.

20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROCEDIMIENTOS: TOMA DE PAPANICOLAU Y TAPONAJE VAGINAL

• **Toma de Papanicolau (procedimiento: Realizar):** idealmente fuera de la menstruación y sin relaciones sexuales, duchas, óvulos o cremas vaginales en las 48 horas previas. Se usa espéculo **sin lubricante**, se visualiza el cuello y se toman **dos muestras**: exocérvix con la **espátula de Ayre** (rotándola 360° sobre la unión escamocolumnar) y endocérvix con **cepillo (citobrush)**. **(ver Imagen 20.13C)** 3.01.5.014

- El frotis se extiende en la lámina con un solo movimiento, delgado y uniforme, y se **fija de inmediato** (spray o alcohol 95%) para evitar la desecación; se rotula con identificación de la paciente y se envía con la solicitud (edad, FUR, antecedentes, método anticonceptivo). Si el cuello sangra, hay inflamación intensa o se sospecha cáncer, no se posterga: se deriva. La muestra es satisfactoria si incluye células endocervicales/zona de transformación. En citología en base líquida o test de ADN-VPH se usa el cepillo con recipiente de transporte.

• **Taponaje vaginal (procedimiento: Realizar):** medida temporal de **hemostasia en hemorragia vaginal o cervical masiva** (cáncer cervicouterino, trauma obstétrico o sexual, posbiopsia), mientras se repone volumen y se traslada a un centro con resolución. 3.01.5.013

- **Técnica:** vía venosa y analgesia; con espéculo se limpia y se identifica el punto sangrante; se introduce **gasa larga o compresas** (mejor impregnadas en ácido tranexámico, povidona o vaselina) empaquetando desde el fondo vaginal hacia el introito; se coloca **sonda Foley** para evitar retención urinaria (el tapón comprime la uretra). El tapón se retira a las **24-48 horas**, con profilaxis antibiótica según protocolo. Contar las gasas. No reemplaza la derivación urgente a oncología ginecológica.

• **Tamizaje ginecológico (PAP y mamografía):** en este tomo se divide el tema: el **tamizaje con Papanicolau/ADN-VPH** se enseña aquí (25-64 años, cada 3 años) y el de **mamografía** en el Tomo de cáncer de mama (tema 20.14: 50-69 años, cada 2 años). 3.01.3.013

TABLA 20.13.C · MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN LESIONES CERVICALES PREINVASORAS E INVASORAS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA	PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN	OBJETIVO ONCOLÓGICO	CRITERIOS DE ÉXITO
NIE II / NIE III (LIEAG)	Conización con asa LEEP o Cono Frío	Extirpación de la zona de transformación y canal	Márgenes quirúrgicos endocervicales y ectocervicales libres de displasia.
CCU Estadio IB1 (< 2 cm)	Histerectomía Radical (Wertheim-Meigs)	Extirpación de útero, parametrios, tercio sup vaginal y ganglios	Ausencia de metástasis ganglionares y parametrios libres.
CCU Estadio IIB en adelante	Quimiorradioterapia concomitante	Cisplatino semanal (40 mg/m²) como radiosensibilizador + Braquiterapia	Respuesta tumoral completa y esterilización parametrial.
Recidiva Pélvica Central	Exenteración Pélvica	Resección en bloque de útero, vagina, vejiga y recto	Procedimiento de rescate en recurrencias centrales post-radioterapia.

20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CÁNCER CERVICOUTERINO (CCU) GES, LESIONES PREINVASORAS (BETHESDA) Y COLPOSCOPÍA)

- GES N° 3 Cáncer Cervicouterino: Tamizaje universal con PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años.
- Oncoproteínas oncogénicas: E6 degrada al gen supresor p53; E7 inactiva a la proteína pRb.
- Tratamiento de NIE II / NIE III: Conización cervical (LEEP o Cono Frío) con márgenes libres.
- Estadios precoces sin invasión de parametrios (IA, IB1, IB2): Cirugía radical de Wertheim-Meigs.
- Etiología: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en 60% y VPH 18 en 15%).
- PAP con LIEAG (H-SIL) o NIE II-III: DERIVACIÓN INMEDIATA A COLPOSCOPÍA Y BIOPSIA en UPC (Garantía GES < 30 días).
- Síntoma clínico más temprano del cáncer invasor: Sangrado postcoital (sinusorragia) indoloro.
- Estadios avanzados con invasión de parametrios (≥ IIB): ¡PROHIBIDA LA CIRUGÍA! -> Quimiorradioterapia con Cisplatino.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.13

Mujer de 44 años, multípara de 3, acude a control al CESFAM para entrega del resultado de su Papanicolaou (PAP) trienal del programa GES. El informe citológico emitido por el laboratorio de anatomía patológica señala: 'Muestra adecuada para evaluación. Hallazgo: Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL)'. La paciente se encuentra totalmente asintomática, afebril y sin sangrados anormales. A la especuloscopía se observa un cuello uterino macroscópicamente sano sin úlceras exofíticas visibles. Pregunta muy angustiada cuál es la conducta que debe seguirse.

Conducta oficial razonada. Ante el hallazgo citológico de una Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL) en el PAP, la conducta clínica mandatoria e inmediata estipulada por la Guía Clínica de Cáncer Cervicouterino GES (Problema de Salud N° 3) consiste en realizar la NOTIFICACIÓN GES y la DERIVACIÓN INMEDIATA de la paciente a la Unidad de Patología Cervical (UPC) del hospital de referencia para la realización de una COLPOSCOPÍA Y BIOPSIA DIRIGIDA, con un plazo máximo legal garantizado de atención menor a 30 días. Bajo ninguna circunstancia se debe repetir el PAP, indicar óvulos vaginales ni dar el alta, debido a que el LIEAG tiene una probabilidad superior al 20-30% de albergar una neoplasia intraepitelial avanzada (NIE II o NIE III) o un cáncer microinvasor oculto en el canal endocervical.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.016

1. Una paciente de 38 años recibe el resultado de su Papanicolaou de tamizaje rutinario que informa: 'Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL)'. A la especuloscopía el cuello uterino luce sin lesiones exofíticas evidentes y la paciente está asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta según la normativa GES del MINSAL?

A) Repetir el PAP en 6 meses para confirmar la persistencia de la lesión
B) Notificar GES y derivar inmediatamente a la Unidad de Patología Cervical (UPC) para Colposcopía y biopsia dirigida
C) Prescribir óvulos vaginales de metronidazol con nistatina por 10 días y dar de alta
D) Programar histerectomía total simple por vía laparoscópica de inmediato
E) Administrar vacuna contra VPH como tratamiento curativo de la lesión

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.013

2. Una paciente de 49 años consulta por sangrado genital postcoital y fetidez vaginal de 3 meses. Al examen ginecológico con espéculo se observa un tumor ulcerado y vegetante de 4 cm en el cuello uterino. Al tacto rectovaginal se palpa que la induración tumoral se extiende y compromete de forma evidente el tercio medial del parametrio izquierdo, sin alcanzar la pared ósea pélvica. La biopsia confirma Carcinoma Epidermoide Invasor de cuello uterino (Estadio IIB de la FIGO). ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado?

A) Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral (Operación de Wertheim-Meigs)
B) Conización cervical con márgenes amplios
C) Quimiorradioterapia concomitante (Radioterapia externa + Braquiterapia + Cisplatino semanal)
D) Histerectomía total simple extrafascial
E) Tratamiento exclusivamente sintomático y cuidados paliativos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.013

3. ¿Cuál es la edad y la periodicidad del tamizaje poblacional universal garantizado por el régimen GES para la detección precoz del Cáncer Cervicouterino en Chile mediante el examen de Papanicolaou (PAP)?

A) Anual en todas las mujeres a partir del inicio de la actividad sexual hasta los 80 años
B) Cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años de edad
C) Cada 5 años en mujeres de 50 a 69 años de edad exclusivamente
D) Semestral en mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales orales
E) Única vez en la vida a los 35 años de edad

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.013

4. ¿Cuáles son los dos genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo más prevalentes a nivel mundial y en Chile, responsables de más del 70% de los carcinomas invasores de cuello uterino?

A) VPH tipos 6 y 11
B) VPH tipos 16 y 18
C) VPH tipos 1 y 2
D) VPH tipos 42 y 43
E) VPH tipos 5 y 8

Más preguntas online de Cáncer Cervicouterino →

20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.030 | 3.01.1.029 | 3.01.4.002 | 3.01.3.013 | 3.01.4.006 | 4.01.1.035 | 4.01.1.036 | 4.01.3.012 | 4.01.4.009

¿POR QUÉ?

El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres en Chile y en el mundo occidental. Está priorizado en el sistema de salud chileno bajo la Garantía Explícita en Salud (GES N° 4) para personas de 15 años y más. El único método que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama en ensayos clínicos es la Mamografía de Tamizaje, garantizada bienalmente entre los 50 y 69 años. El informe mamográfico utiliza el sistema internacional BI-RADS, donde las categorías 4 y 5 exigen obligatoriamente la realización de una Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy). El tratamiento moderno es multidisciplinario e individualizado según los subtipos moleculares (Luminal A, Luminal B, HER2 enriquecido y Triple Negativo).

1. FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE MAMOGRÁFICO GES

• **Factores de Riesgo Mayores:** (ver Imagen 20.14A y C) 3.01.1.030 | 4.01.1.035

- Mutaciones genéticas hereditarias de alta penetrancia: **BRCA1 y BRCA2** (riesgo acumulado de cáncer de mama del 60-80% y cáncer de ovario del 20-40%).

- Antecedente familiar de 1° grado con cáncer de mama (especialmente bilateral o diagnosticado antes de los 40 años).

- Antecedente de radioterapia torácica en la juventud (ej. linfoma de Hodgkin).

- Antecedente de biopsia previa con **Hiperplasia Ductal Atípica o Carcinoma Lobulillar in situ**.

• **Factores de Riesgo Hormonales Modestos:** Menarquia precoz (< 12 años), menopausia tardía (> 55 años), nuliparidad o primer parto sobre los 30 años, terapia hormonal combinada prolongada (> 5 años), obesidad postmenopáusica y alcoholismo.

• **Tamizaje Poblacional Universal GES en Chile:** 3.01.1.030 | 3.01.4.002 | 3.01.3.013 | 4.01.1.035 | 4.01.3.012 | 4.01.4.009

- **Examen de Elección: Mamografía Bilateral en dos proyecciones (craneocaudal y mediolateral oblicua)**.

- **Población Garantizada:** Mujeres de **50 a 69 años de edad, cada 2 años (bienal)**. En mujeres de alto riesgo genético familiar se inicia a los 30-35 años (o 10 años antes del familiar más joven diagnosticado).

2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN MAMOGRÁFICA BI-RADS

• El sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) estandariza el reporte y la conducta clínica: 3.01.1.030 | 3.01.4.002 | 4.01.1.035 | 4.01.3.012

- **BI-RADS 0 (Incompleto):** Requiere estudios de imagen adicionales (proyecciones magnificadas, 3.01.1.030 | 3.01.4.002 focalizadas o **ecografía mamaria complementaria**). 3.01.4.006 | 4.01.4.009 | 4.01.1.035 | 4.01.3.012 | 4.01.4.009

- **BI-RADS 1 (Negativo / Normal):** Mamas simétricas, sin nódulos ni calcificaciones sospechosas. Riesgo de cáncer: 0%. Control habitual en 2 años. 3.01.1.030 | 3.01.4.002 | 4.01.1.035 | 4.01.3.012 | 4.01.4.009

- **BI-RADS 2 (Hallazgo Benigno):** Quistes simples, fibroadenomas calcificados en 'palomita de maíz', ganglios intramamarios, implantes. Riesgo de cáncer: 0%. Control habitual en 2 años.

- **BI-RADS 3 (Probablemente Benigno):** Nódulos circunscritos no calcificados, asimetrías focales. Riesgo de malignidad: **< 2%**. **Conducta: Seguimiento estricto con mamografía unilateral a los 6 meses**.

- **BI-RADS 4 (Sospecha de Malignidad):** Riesgo de malignidad del **2 al 95%** (subdividido en 4A bajo, 4B moderado, 4C alto). Hallazgos: microcalcificaciones pleomórficas agrupadas en molde o nódulos espiculados. **Conducta: BIOPSIA OBLIGATORIA**. **(ver Imagen 20.14B)**

- **BI-RADS 5 (Altamente Sospechoso de Malignidad):** Riesgo de malignidad **> 95%**. Nódulo espiculado hiperdenso con retracción cutánea y microcalcificaciones lineales ramificadas. **Conducta: BIOPSIA OBLIGATORIA**.

- **BI-RADS 6:** Malignidad ya confirmada histológicamente mediante biopsia previa.

• **Método de Biopsia de Elección: BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (Core Biopsy o Tru-Cut)** guiada por ecografía o estereotaxia. Permite diferenciar con total certeza carcinoma in situ de invasor y obtener tejido para inmunohistoquímica (RE, RP, HER2, Ki-67). *¡La Punción con Aguja Fina - PAAF no sirve para esto porque solo obtiene células sueltas citológicas!* 3.01.1.030 | 4.01.1.035 | 4.01.3.012

TABLA 20.14.A · SISTEMA DE CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA BI-RADS Y CONDUCTA CLÍNICA OBLIGATORIA 3.01.1.030, 3.01.1.029, 3.01.4.002, 3.01.3.013, 3.01.4.006, 4.01.1.035, 4.01.1.036, 4.01.3.012, 4.01.4.009

CATEGORÍA BI-RADS	SIGNIFICADO RADIOLÓGICO	RIESGO ESTIMADO DE MALIGNIDAD	CONDUCTA MÉDICA OBLIGATORIA
BI-RADS 0	Estudio Incompleto	No determinado	Solicitar proyecciones adicionales o Ecografía mamaria complementaria
BI-RADS 1	Negativa / Completamente Normal	0%	Mamografía de tamizaje rutinaria cada 2 años
BI-RADS 2	Hallazgos Benignos (quistes, fibroadenoma calcificado)	0%	Mamografía de tamizaje rutinaria cada 2 años
BI-RADS 3	Probablemente Benigno (nódulo sólido circunscrito)	< 2%	SEGUIMIENTO ESTRICTO: Control mamográfico a los 6 meses
BI-RADS 4	Sospechosa de Malignidad (4A, 4B, 4C)	2 a 95%	BIOPSIA OBLIGATORIA (Core Biopsy percutánea guiada)
BI-RADS 5	Altamente Sospechosa (nódulo espiculado + microcalcificaciones)	> 95%	BIOPSIA OBLIGATORIA (Core Biopsy) y derivación oncológica expedita
BI-RADS 6	Malignidad Comprobada por Biopsia previa	100%	Planificación terapéutica multidisciplinaria (cirugía/neoadyuvancia)

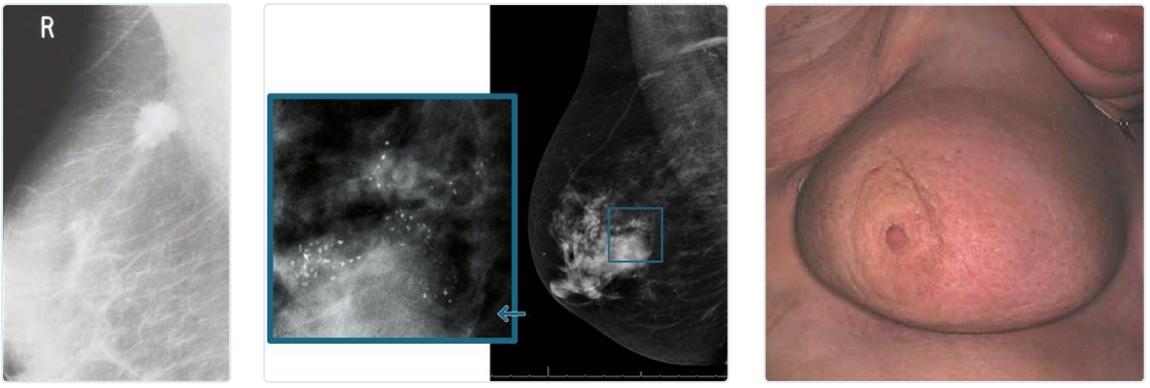
20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA MÁS FRECUENTE

• **1) Fibroadenoma Mamario:** Tumor benigno sólido más frecuente en **mujeres jóvenes (15 a 35 años)**. Nódulo ovoideo, firme, elástico, bordes netos regulares, móvil e indoloro. Ecografía: masa hipoecogénica circunscrita, más ancha que alta, con eje mayor paralelo a la piel. Manejo: observación si es < 2-3 cm y estable; extirpación si crece o causa dudas. 3.01.1.029 3.01.4.006 4.01.1.036

• **2) Condición Fibroquística de la Mama (Displasia Mamaria):** Patología benigna más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. Se caracteriza por **mastodinia / mastalgia cíclica premenstrual bilateral** y nodularidad difusa en 'bolsa de perdigones'. Manejo: sintomático, sostenes de soporte, AINEs tópicos/orales. 3.01.1.029 4.01.1.036

• **3) Papiloma Intraductal:** Proliferación benigna de los conductos galactóforos principales. Es la **causa más frecuente de telorrea serohemática o hemática unicanalicular (uniporo) espontánea** en una mujer no lactante. Manejo: ecografía ductal y exéresis quirúrgica del conducto afectado (microdoquectomía) para descartar carcinoma papilar.



A. MASA ESPICULADA B. MICROCALCIFICACIONES C. PIEL DE NARANJA

Imagen 20.14

FIGURA 20.14 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL CÁNCER DE MAMA SEGÚN BI-RADS

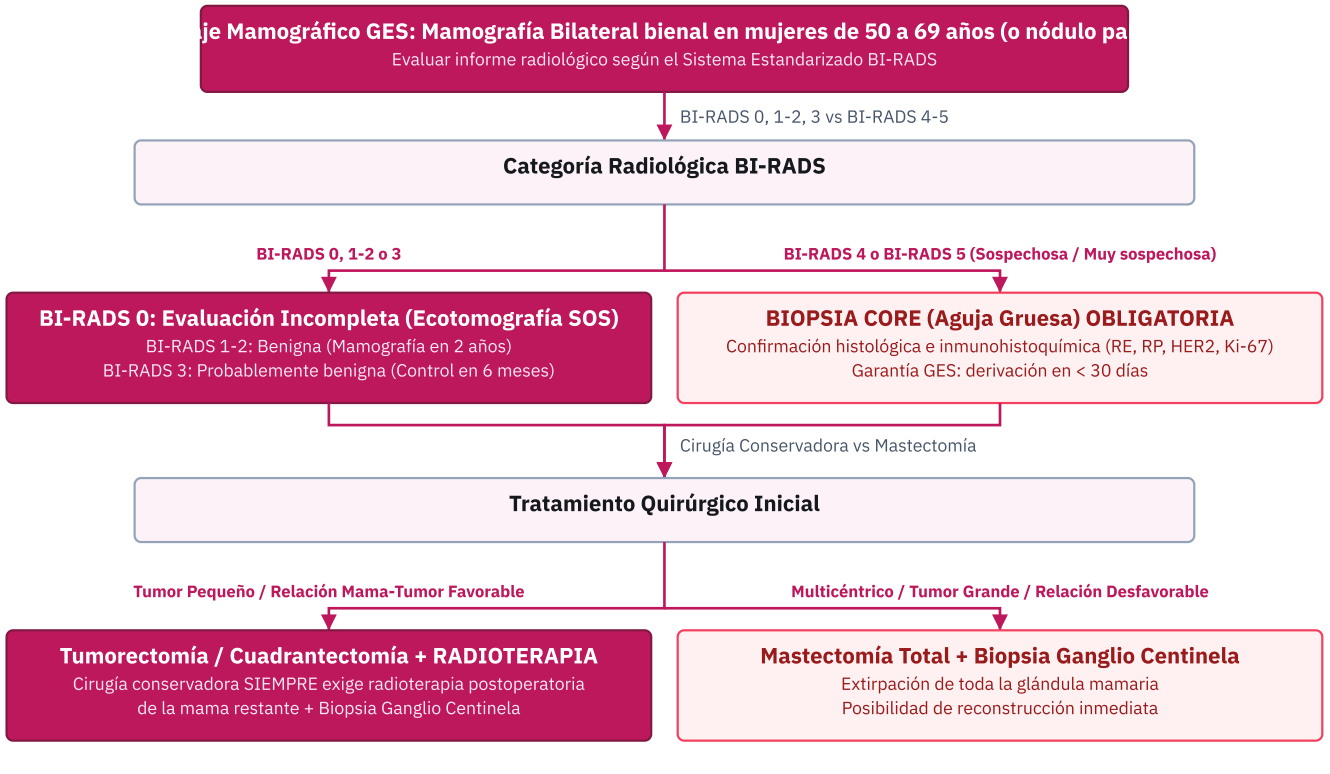


TABLA 20.14.B · SUBTIPOS MOLECULARES DEL CÁNCER DE MAMA Y ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS CRITERIOS DE GRAVEDAD

SUBTIPO MOLECULAR	PERFIL DE INMUNOHISTOQUÍMICA	PRONÓSTICO RELATIVO	TRATAMIENTO SISTÉMICO DIRIGIDO EUNACOM
Luminal A	RE (+), RP (+), HER2 (-), Ki-67 bajo (< 20%)	El más favorable	Hormonoterapia (Tamoxifeno o Inhibidores de Aromatasa) x 5-10 años.
Luminal B (HER2 -)	RE (+), RP (-/bajo), HER2 (-), Ki-67 alto (≥ 20%)	Intermedio	Quimioterapia previa + Hormonoterapia.
Luminal B (HER2 +)	RE (+), RP (+/-), HER2 (+), Ki-67 variable	Intermedio-Agresivo	Quimioterapia + Trastuzumab + Hormonoterapia.
HER2 Enriquecido	RE (-), RP (-), HER2 (+) sobreexpresado	Desfavorable / Agresivo	Quimioterapia + TERAPIA DIRIGIDA CON TRASTUZUMAB (Anti-HER2).
Triple Negativo	RE (-), RP (-), HER2 (-) todos negativos	El más agresivo / Pobre	QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA INTENSIVA (antraciclinas + taxanos).

20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA Y SUBTIPOS MOLECULARES

• **Subtipos Moleculares Inmunohistoquímicos:** 3.01.1.030 4.01.1.035

- **Luminal A (60%):** Receptores de Estrógeno (RE) (+) y Progesterona (RP) (+), HER2 (-), Ki-67 bajo (< 20%). Excelente pronóstico. Tratamiento: **Hormonoterapia** (Tamoxifeno en premenopáusicas o Inhibidores de Aromatasa como Anastrozol/Letrozol en postmenopáusicas por 5 a 10 años). Rara vez requiere quimioterapia.

- **Luminal B (15-20%):** RE (+), RP bajo/ausente, Ki-67 alto (≥ 20%) o HER2 (+). Tratamiento: Quimioterapia + Hormonoterapia.

- **HER2 Enriquecido (10-15%):** RE (-), RP (-), sobreexpresión de HER2 (3+). Agresivo. Tratamiento: Quimioterapia + **Anticuerpos anti-HER2 dirigidos (TRASTUZUMAB / Pertuzumab)**.

- **Triple Negativo (10-15%):** RE (-), RP (-), HER2 (-). Típico de mujeres jóvenes y mutación BRCA1. Muy agresivo, mal pronóstico. No responde a hormonoterapia ni trastuzumab; requiere **Quimioterapia citotóxica** intensiva (antraciclinas + taxanos).

• **Tratamiento Quirúrgico y Axilar:**

- **Cirugía Conservadora (Tumorectomía / Cuadrantectomía):** Extirpa el tumor con márgenes libres. **EXIGE SIEMPRE RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA OBLIGATORIA SOBRE LA MAMA RESTANTE** (sin radioterapia, la tasa de recidiva es inaceptable). Ofrece idéntica sobrevida que la mastectomía.

- **Mastectomía Total:** Indicada ante tumores multicéntricos, microcalcificaciones difusas extensas, mala relación mama-tumor o contraindicación de radioterapia.

- **Manejo de la Axila: Biopsia del Ganglio Centinela** (con tecnecio-99 o azul de metileno). Si es negativo, **se evita la linfadenectomía axilar completa**, previniendo el linfedema del brazo.

5. ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA: INDICACIONES Y CRITERIOS

• **Ecografía mamaria (Emplea informe):** no se usa como tamizaje en la población general; sus **indicaciones** son: (1) estudio inicial de un nódulo palpable o dolor focal en mujeres < 30-35 años (mama densa); (2) caracterizar una lesión vista en la mamografía (**quiste vs sólido**, BI-RADS 0); (3) mamas densas como complemento; (4) **guía de punción o biopsia con aguja gruesa**; (5) mastitis/absceso y evaluación de la axila (adenopatías). 3.01.4.006 3.01.3.013

- **Criterios benignos:** forma oval o redonda, **eje mayor paralelo a la piel (más ancha que alta)**, márgenes netos, ecogenicidad homogénea; **quiste simple:** anecoico con refuerzo acústico posterior (se punciona solo si es sintomático). **Criterios sospechosos de malignidad:** forma irregular, márgenes espiculados o angulados, **más alta que ancha**, hipoecoica con sombra acústica posterior, microcalcificaciones y adenopatía axilar de aspecto patológico. 3.01.4.006



Quiste simple de mama: anecoico, pared fina y refuerzo posterior

- El informe ecográfico también usa categorías **BI-RADS** (2 benigno, 3 probablemente benigno con control a 6 meses, 4-5 biopsia). El médico general debe interpretarlo para decidir seguimiento, biopsia con aguja gruesa o derivación a mastología.

TABLA 20.14.C · MODALIDADES TERAPÉUTICAS QUIRÚRGICAS Y ADYUVANTES EN CÁNCER DE MAMA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN	INDICACIONES CLÍNICAS	PREMISAS OBLIGATORIAS EUNACOM	MORBILIDAD / SECUELAS PREVENIDAS
Cirugía Conservadora (Tumorectomía)	Tumores unifocales con bordes libres y mama adecuada	¡OBLIGATORIA RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA a toda la mama restante!	Preservación estética e identidad corporal con idéntica sobrevida que mastectomía.
Biopsia Ganglio Centinela	Axila clínicamente negativa (cN0) al examen y eco	Inyección peritumoral de radioisótopo/tinte y extirpación del primer ganglio	Evita el vaciamiento axilar completo y reduce el linfedema de extremidad superior en > 90%.
Tamoxifeno (Hormonoterapia)	Tumores con receptores hormonales (+) en premenopáusicas	Modulador selectivo de receptores estrogénicos (SERM) por 5-10 años	Aumenta riesgo de hiperplasia/cáncer endometrial y TVP (requiere control ginecológico).
Inhibidores de Aromatasa (Anastrozol)	Tumores con receptores hormonales (+) en postmenopáusicas	Bloquean la síntesis periférica de estrógenos en tejido graso	Provocan artralgias y aceleran osteoporosis (requiere densitometría ósea y calcio/vit D).

20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CÁNCER DE MAMA GES, TAMIZAJE MAMOGRÁFICO (BI-RADS) Y PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA)

- Cáncer de mama: Primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile (GES N° 4 desde los 15 años).
- BI-RADS 3: Probablemente benigno (< 2% riesgo); requiere seguimiento mamográfico en 6 meses.
- La PAAF citológica NO sirve para diagnóstico inicial porque no distingue carcinoma in situ de invasor.
- Biopsia de Ganglio Centinela: De elección en axila clínicamente negativa para evitar vaciamiento y linfedema.
- Hormonoterapia: Tamoxifeno en premenopáusicas; Inhibidores de Aromatasa (Anastrozol/Letrozol) en postmenopáusicas.
- Tamizaje GES: Mamografía bilateral bienal (cada 2 años) en mujeres de 50 a 69 años.
- BI-RADS 4 y 5: Sospechosos de malignidad; exigen BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (Core Biopsy) obligatoria.
- Cirugía conservadora (tumorectomía): EXIGE SIEMPRE RADIOTERAPIA COMPLEMENTARIA de la mama restante.
- Subtipo Triple Negativo: RE (-), RP (-), HER2 (-); agresivo, no responde a hormonoterapia ni trastuzumab.
- Causa más común de telorrea serohemática unicanalicular: Papiloma Intraductal benigno.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.14

Mujer de 54 años, sin antecedentes mórbidos ni familiares de cáncer, asintomática, acude a su control ginecológico en el CESFAM con el resultado de su mamografía bilateral de tamizaje del programa GES. El informe radiológico señala: 'En el cuadrante superoexterno de la mama derecha se identifica un grupo de microcalcificaciones pleomórficas de distribución lineal ramificada asociadas a una distorsión de la arquitectura tisular con márgenes espiculados. Conclusión: Hallazgo altamente sospechoso de malignidad (BI-RADS 5)'. La paciente se encuentra sumamente asustada y solicita saber qué examen debe realizarse de inmediato para saber si tiene cáncer.

Conducta oficial razonada. El hallazgo de una imagen mamográfica clasificada como BI-RADS 5 (altamente sospechosa de malignidad, con un riesgo de cáncer > 95%) exige de forma perentoria e inmediata la realización de una BIOPSIA HISTOLÓGICA CON AGUJA GRUESA (Core Biopsy o Tru-cut), idealmente guiada por ecografía o mamografía estereotáxica. Bajo el amparo de las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 4 Cáncer de Mama), la paciente debe ser notificada y derivada de inmediato al centro de referencia oncológica para la toma de la biopsia core (garantía de confirmación diagnóstica en < 30 días). Este procedimiento permite certificar la presencia de cáncer invasor o carcinoma in situ y determinar los receptores hormonales (RE, RP), HER2 y Ki-67 indispensables para planificar la terapia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.14 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

1. Una paciente de 52 años asintomática se realiza una mamografía de tamizaje rutinario que informa: 'En el cuadrante superoexterno de la mama izquierda se observa un nódulo espiculado de 15 mm con microcalcificaciones heterogéneas agrupadas en su interior, clasificado como BI-RADS 4C'. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de primera línea indicada a continuación?

A) Control mamográfico estricto a los 6 meses para evaluar estabilidad
B) Realización de Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy) guiada por imágenes
C) Mastectomía radical de urgencia sin confirmación anatomopatológica previa
D) Punción con aguja fina (PAAF) para estudio citológico exclusivo
E) Administración empírica de tamoxifeno oral durante 3 meses

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

2. Una mujer de 58 años es sometida a una tumorectomía conservadora de mama con márgenes quirúrgicos libres por un carcinoma ductal infiltrante de 18 mm. ¿Cuál de las siguientes terapias adyuvantes locales es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIA tras una cirugía conservadora de mama para reducir la tasa de recidiva local al mismo nivel que una mastectomía total?

A) Radioterapia externa sobre la glándula mamaria restante
B) Quimioterapia con metotrexato intratecal
C) Vaciamiento ganglionar axilar radical bilateral
D) Inyecciones locales de interferón alfa intralesional
E) Ninguna, la cirugía conservadora con bordes libres no requiere tratamientos adicionales

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.029

3. Una paciente de 46 años, no lactante, consulta por la salida espontánea de secreción serohemática (líquido rosado con estrías de sangre) por un único poro del pezón de la mama derecha desde hace 3 semanas. A la palpación física no se identifican nódulos dominantes ni adenopatías axilares. ¿Cuál es la causa etiológica benigna más frecuente de este tipo de telorrea?

A) Fibroadenoma mamario simple
B) Papiloma intraductal solitario
C) Prolactinoma hipofisario
D) Mastitis granulomatosa idiopática
E) Ectasia ductal senil

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

4. Una paciente de 42 años diagnosticada de cáncer de mama invasor presenta el siguiente informe de inmunohistoquímica tumoral: Receptores de Estrógeno (RE) negativos (0%), Receptores de Progesterona (RP) negativos (0%) y HER2 negativo (Score 0). ¿A qué subtipo molecular corresponde este tumor y cuál es la implicancia terapéutica respecto a la hormonoterapia y anticuerpos monoclonales anti-HER2?

A) Subtipo Luminal A; responderá excelentemente a Tamoxifeno como única terapia
B) Subtipo Triple Negativo; NO responderá a hormonoterapia ni a Trastuzumab, requiriendo quimioterapia citotóxica
C) Subtipo HER2 enriquecido; indicación prioritaria de Trastuzumab con Pertuzumab
D) Subtipo Luminal B; requiere monoterapia con inhibidores de aromatasa
E) Carcinoma basocelular de la mama; solo requiere seguimiento sin fármacos

Más preguntas online de Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico →

20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.024 | 3.01.1.028 | 3.01.4.005 | 1.08.3.002

¿POR QUÉ?

El Cáncer de Endometrio y el Cáncer de Ovario son las dos principales neoplasias ginecológicas del tracto genital interno en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas. El Cáncer de Endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en países desarrollados y la regla de oro mandatoria en el EUNACOM es que TODO sangrado en la postmenopausia es cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario (siendo el grosor ecográfico ≥ 4 a 5 mm el punto de corte para indicar biopsia inmediata). Por su parte, el Cáncer de Ovario es el más letal de todos debido a que se diagnostica tardíamente en estadios avanzados (III o IV) por síntomas digestivos vagos e inespecíficos. El reconocimiento de los signos ecográficos IOTA de malignidad de una masa anexial y el uso del marcador CA-125 son conocimientos de primer orden.

1. CÁNCER DE ENDOMETRIO: FACTORES DE RIESGO Y CLÍNICA

• **Fisiopatología y Clasificación Dual de Bokhman:** 3.01.1.024 **(ver Imagen 20.15C)**

- **Tipo I (Endometrioide, 80-85%):** Estrógeno-dependiente. Se origina a partir de hiperplasia endometrial con atipias en un contexto de **hiperestrogenismo crónico sin oposición de progesterona**. Buen pronóstico, grado histológico bajo a moderado.

- **Tipo II (Seroso papilar / Células claras, 15%):** Estrógeno-independiente. Ocurre en mujeres ancianas con endometrio atrófico, mutación en el gen p53. Muy agresivo, mal pronóstico. **(ver Imagen 20.15A)**

• **Factores de Riesgo Clásicos (Pregunta Fija EUNACOM):**

- **Obesidad (el factor de riesgo más potente):** La aromatización periférica de andrógenos a estrona en el tejido adiposo genera hiperestrogenismo continuo.

- Nuliparidad, menopausia tardía, menarquia precoz.

- **Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)** por anovulación crónica.

- **Uso de Tamoxifeno:** Ejerce efecto agonista estrogénico sobre el endometrio.

- **Síndrome de Lynch (HNPCC):** Mutación en genes de reparación de ADN (MLH1, MSH2); confiere un 40-60% de riesgo de cáncer de endometrio y colon. **(ver Imagen 20.15B)**

• **Manifestación Clínica Cardinal: METRORRAGIA EN LA POSTMENOPAUSIA (90% de los casos)**. Todo sangrado vaginal ocurrido tras 12 meses de amenorrea en la menopausia obliga a descartar cáncer endometrial.

• **Diagnóstico:**

- **Ecografía Transvaginal:** Grosor endometrial normal en postmenopausia: **< 4 a 5 mm**. Si mide **≥ 4 a 5 mm (o ≥ 8 mm si usa TRH)** o es heterogéneo: **BIOPSIA ENDOMETRIAL AMBULATORIA (Pipelle) OBLIGATORIA**. 3.01.1.024 | 3.01.4.005

- Si la muestra de Pipelle es insuficiente o hay sospecha de pólipo: **Histeroscopía diagnóstica con biopsia dirigida**. 3.01.1.024

• **Tratamiento:** Quirúrgico y etapificador mediante **Histerectomía Total con Salpingooforectomía Bilateral y Linfadenectomía** (o mapeo de ganglio centinela) +/- radioterapia/quimioterapia adyuvante según estadio.

2. MASA ANEXIAL Y CÁNCER DE OVARIO: DIAGNÓSTICO Y MARCADORES

• **Epidemiología y Mortalidad:** El cáncer de ovario es el 'asesino silencioso' de la ginecología. Más del 70% se diagnostica en **Estadios Avanzados (III y IV)** con carcinomatosis peritoneal y ascitis. El tipo histológico más común es el **Carcinoma Epitelial Seroso de Alto Grado (70-80%)**, que se origina en la fimbria tubárica. 3.01.1.028

• **Síntomas Clínicos Iniciales (Engañosos y Vagos):** Distensión abdominal persistente, saciedad precoz, dispepsia, dolor pélvico sordo, aumento del perímetro abdominal y polaquiuria (frecuentemente mal diagnosticados como colon irritable).

• **Evaluación Ecográfica de la Masa Anexial (Reglas IOTA de Malignidad):** 3.01.1.028 | 3.01.4.005

- **Signos de ALTA SOSPECHA DE MALIGNIDAD (IOTA M-rules):**

• 1) Tumor sólido irregular multiloculado voluminoso.

• 2) **Presencia de Proyecciones Papilares sólidas intracísticas (> 3 mm)**.

• 3) **Septos o tabiques internos gruesos (> 3 mm)**.

• 4) **Ascitis** o líquido libre en el fondo de saco.

• 5) **Flujo vascular Doppler central intralesional de baja resistencia**.

• **Marcadores Tumorales Séricos:** 3.01.1.028

- **CA-125:** Elevado en el 80% de los carcinomas epiteliales serosos de alto grado. Es poco específico en premenopáusicas (se eleva en endometriosis, miomas, EIP, embarazo, peritonitis), pero **ALTAMENTE PREDICTIVO DE MALIGNIDAD en una mujer POSTMENOPÁUSICA con masa anexial compleja**.

- Otros marcadores en mujeres jóvenes (tumores germinales): **Alfa-fetoproteína (AFP)** (seno endodérmico), **β-hCG** (coriocarcinoma) y **LDH** (disgerminoma).

• **Tratamiento:** El pilar es la **Cirugía de Citorreducción Primaria Máxima (Debulking)** (laparotomía xifopúbica con histerectomía, salpingooforectomía bilateral, omentectomía total, linfadenectomía y peritonectomías para lograr citorreducción R0 sin tumor residual macroscópico) seguida de **Quimioterapia basada en Carboplatino + Paclitaxel**.

TABLA 20.15.A · CRITERIOS ECOGRÁFICOS IOTA PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS OVÁRICAS 3.01.1.024, 3.01.1.028, 3.01.4.005, 1.08.3.002

PARÁMETRO ECOGRÁFICO	CRITERIOS DE BENIGNIDAD (B-RULES)	CRITERIOS DE MALIGNIDAD (M-RULES)
Estructura de la Masa	Quiste unilocular puro (anecoico)	Tumor sólido irregular o multiloculado heterogéneo
Componente Sólido / Papilas	Ausencia de áreas sólidas o papilas < 3 mm	Presencia de proyecciones papilares ≥ 3 mm sólidas
Tabiques Internos	Sin tabiques o septos finos (< 3 mm)	Tabiques gruesos múltiples (> 3 mm)
Líquido Peritoneal	Sin líquido libre en cavidad	ASCITIS evidente perihepática y en Douglas
Vascularización Doppler	Sin flujo Doppler color (Score 1)	Flujo vascular Doppler central intenso (Score 4)
Sombra Acústica	Presencia de sombra acústica posterior (benigno)	Ausencia de sombra acústica con atenuación

20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ETAPIFICACIÓN, RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA: CONCEPTOS GENERALES

1.08.3.002

• **Etapificación:** clasifica la extensión de un cáncer para elegir tratamiento y estimar pronóstico. Se usa el **sistema TNM** (tumor, ganglios, metástasis) y, en ginecología, la **etapificación FIGO** (quirúrgica en endometrio y ovario; clínica con imagen en cuello uterino). Se complementa con grado histológico, biomarcadores (CA-125 en ovario, receptores hormonales) y estado funcional (ECOG).

- **Cirugía:** curativa en enfermedad localizada (histerectomía + salpingooforectomía y linfadenectomía/ganglio centinela en endometrio; citorreducción óptima en ovario). **Radioterapia:** externa y **braquiterapia** (cuello, endometrio), radical o adyuvante, con efectos agudos (cistitis, proctitis, diarrea) y tardíos (estenosis vaginal, fístulas, menopausia precoz). **Quimioterapia:** carboplatino + paclitaxel en ovario y endometrio avanzado; cisplatino concomitante con radioterapia en cuello uterino localmente avanzado. Efectos: neutropenia febril, náuseas, neuropatía y nefrotoxicidad (cisplatino).

- **Intención del tratamiento:** adyuvante (tras cirugía), neoadyuvante (antes de cirugía), curativo o paliativo. El médico general sospecha, deriva a comité oncológico y se encarga de seguimiento sintomático, apoyo psicosocial y cuidados paliativos.



A. ENDOMETRIO ENGROSADO



B. HISTEROSCOPÍA: CÁNCER



C. MASA PÉLVICA (TC)

Imagen 20.15

FIGURA 20.15 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA METRORRAGIA POSTMENOPÁUSICA Y MASA ANEXIAL

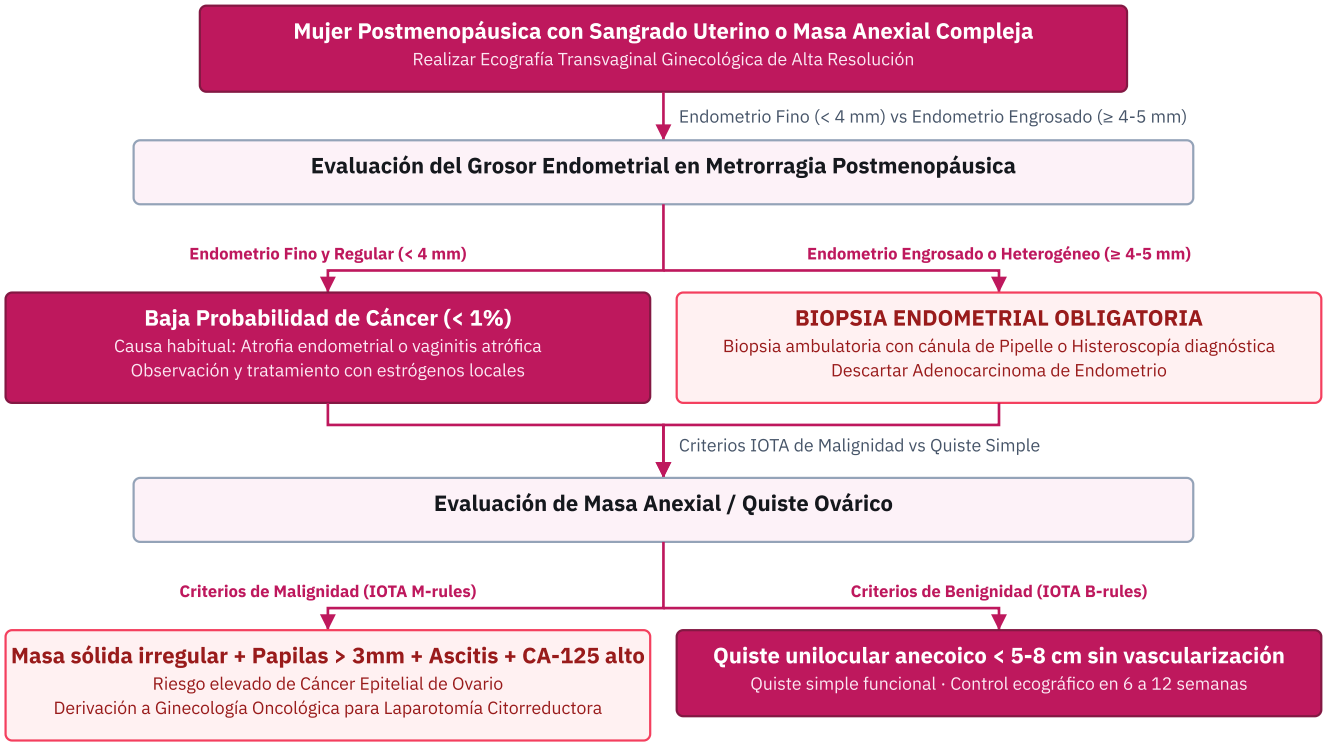


TABLA 20.15.B · PROTOCOLO DE ESTUDIO Y DERIVACIÓN EN SOSPECHA DE CÁNCER GINECOLÓGICO CRITERIOS DE GRAVEDAD

SOSPECHA CLÍNICA	HALLAZGO CLAVE DE ALARMA	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Cáncer de Endometrio	Metrorragia postmenopáusica + Endometrio ecográfico ≥ 4-5 mm	Biopsia endometrial ambulatoria (Pipelle) -> Si positiva: TAC TAP y derivación a Ginecología Oncológica.
Cáncer Epitelial de Ovario	Masa ovárica compleja ecográfica + CA-125 elevado (> 35 U/mL en postmenopausia) + Ascitis	Derivación URGENTE a centro oncológico terciario para laparotomía exploradora citorreductora (¡No puncionar por riesgo de diseminación!).
Tumor Germinal de Ovario	Masa ovárica sólida de rápido crecimiento en adolescente o mujer < 25 años	Solicitar AFP, β-hCG y LDH séricos + TAC pélvico y derivación oncológica.
Síndrome de Lynch (HNPCC)	Antecedente de múltiples familiares con cáncer de colon y endometrio a edad joven	Consejo genético, tamizaje anual con eco TV y biopsia endometrial desde los 30-35 años, e histerectomía profiláctica a los 40 años.

20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 20.15.C · ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN CÁNCER DE ENDOMETRIO Y OVARIO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

NEOPLASIA	CIRUGÍA PRIMARIA ESTÁNDAR	TERAPIA ADYUVANTE DE ELECCIÓN	MARCADOR DE SEGUIMIENTO
Cáncer de Endometrio Estadio I	Histerectomía Total + Doble Anexectomía + Mapeo de Ganglio Centinela	Observación (IA) o Braquiterapia de cúpula vaginal (IB de alto riesgo)	Control clínico y especuloscopía seriada.
Cáncer de Endometrio Avanzado	Cirugía citorreductora completa + Linfadenectomía pelviana/aórtica	Quimioterapia (Carboplatino + Paclitaxel) + Radioterapia externa	Control clínico y TAC según síntomas.
Cáncer Epitelial de Ovario	Citorreducción primaria máxima R0 (Histerectomía, anexectomía, omentectomía)	Poliquimioterapia parenteral: Carboplatino + Paclitaxel x 6 ciclos (+/- Bevacizumab / Inhibidores de PARP)	Marcador sérico CA-125 seriado.
Tumores Germinales Ováricos	Cirugía conservadora preservando útero y ovario sano contralateral	Quimioterapia con esquema BEP (Bleomicina, Etopósido, Cisplatino) curativa	Marcadores AFP, β-hCG y LDH.

20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CÁNCER DE ENDOMETRIO Y MASA ANEXIAL / CÁNCER DE OVARIO)

- Regla de oro: Toda metrorragia en la postmenopausia es Cáncer de Endometrio hasta demostrar lo contrario.
- Endometrio ≥ 4-5 mm con sangrado en postmenopáusica: BIOPSIA ENDOMETRIAL (Pipelle) OBLIGATORIA.
- Cáncer de Ovario: Neoplasia ginecológica más letal, se diagnostica tardíamente con síntomas digestivos vagos.
- Marcador tumoral CA-125: Altamente predictivo de malignidad en mujeres postmenopáusicas con masa anexial.
- Tratamiento estándar del cáncer de ovario: Citorreducción quirúrgica máxima R0 + Carboplatino y Paclitaxel.
- Grosor endometrial normal en postmenopausia: Menor a 4 a 5 mm (si usa TRH hasta 8 mm).
- Factor de riesgo mayor de Cáncer de Endometrio: Obesidad (aromatización periférica a estrógenos).
- Criterios ecográficos IOTA de malignidad ovárica: Proyecciones papilares sólidas > 3 mm, septos gruesos, ascitis.
- ¡PROHIBIDO PUNCIONAR una masa ovárica sospechosa por riesgo de rotura y siembra peritoneal masiva!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

20.15

Paciente de 61 años, menopáusica desde hace 10 años sin antecedentes mórbidos ni terapia de reemplazo hormonal, consulta por presentar sangrado genital rojo oscuro escaso e intermitente de 3 semanas de evolución. Al examen físico: paciente en buenas condiciones generales, abdomen blando e indoloro sin masas palpables. La especuloscopía confirma que el sangrado proviene del orificio cervical externo, sin lesiones exocervicales ni atrofia severa sangrante. Se realiza ecografía transvaginal que informa útero de 70 mm con miometrio homogéneo y un endometrio engrosado de 11 mm, marcadamente heterogéneo con áreas microquísticas. Ambos ovarios se observan atróficos y normales sin masas anexiales ni líquido libre.

Conducta oficial razonada. La presencia de un sangrado genital en una mujer postmenopáusica (Metrorragia de la Postmenopausia) asociado al hallazgo ecográfico de un grosor endometrial de 11 mm (muy superior al punto de corte máximo de normalidad de 4 a 5 mm en la menopausia) constituye una indicación formal, urgente y obligatoria de BIOPSIA ENDOMETRIAL (preferentemente mediante aspiración ambulatoria con cánula de Pipelle, o histeroscopía con biopsia dirigida si el Pipelle es insuficiente o negativo persistiendo el sangrado). El objetivo impostergable es confirmar o descartar un Carcinoma de Endometrio (responsable del 10 al 15% de estos cuadros). No se debe adoptar conducta expectante ni prescribir hemostáticos u hormonas sin confirmación histopatológica previa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.024

1. Una paciente de 63 años consulta por sangrado vaginal rojo oscuro escaso de 2 semanas de evolución tras 12 años de amenorrea menopáusica. La ecografía transvaginal muestra un grosor endometrial de 12 mm, heterogéneo e irregular. ¿Cuál es el paso diagnóstico que debe realizarse de inmediato?

A) Prescribir óvulos de estriol vaginal durante 1 mes y reevaluar con ecografía
B) Realización de una Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle o histeroscopía)
C) Solicitar tomografía por emisión de positrones (PET-CT) de cuerpo entero
D) Indicar reposo en cama y control ecográfico en 6 meses
E) Realizar laparoscopía exploradora diagnóstica para ooforectomía bilateral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.028

2. Una mujer de 65 años consulta por distensión abdominal progresiva, dispepsia y saciedad precoz de 3 meses de evolución. Al examen físico se palpa abdomen distendido con matidez desplazable compatible con ascitis y una masa pelviana profunda firme. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial derecha de 9 cm, multiloculada, con septos gruesos de 5 mm, abundantes proyecciones papilares sólidas internas con vascularización Doppler central de baja resistencia, y abundante líquido libre ascítico en fondo de saco de Douglas. El marcador sérico CA-125 resulta en 450 U/mL (VN < 35 U/mL). ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable y la conducta adecuada?

A) Quiste folicular funcional simple; indicar anticonceptivos orales por 3 meses
B) Cáncer epitelial de ovario avanzado; derivar de inmediato a Ginecología Oncológica para laparotomía etapificadora y citorreducción primaria
C) Punción transvaginal evacuadora del quiste ovárico para aliviar la presión
D) Endometrioma ovárico; prescribir dienogest oral continuo
E) Absceso apendicular crónico; apendicectomía electiva ambulatoria

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.028

3. ¿Por qué razón oncológica fundamental está FORMALMENTE CONTRAINDICADO realizar una punción-aspiración con aguja de una masa anexial ovárica con criterios ecográficos sospechosos de malignidad?

A) Porque induce una hemorragia digestiva masiva secundaria
B) Porque la rotura de la cápsula quística provoca la siembra y diseminación de células malignas en la cavidad peritoneal, empeorando el estadio y pronóstico oncológico de la paciente
C) Porque eleva de forma irreversible los niveles plasmáticos de CA-125
D) Porque provoca el cierre precoz de las trompas de Falopio contralaterales
E) Porque desencadena una crisis de tirotoxicosis autoinmune

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.024

4. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas se asocia al mayor riesgo relativo de desarrollar un Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I endometrioide debido a la estimulación estrogénica continua no balanceada?

A) Multiparidad con más de 4 hijos
B) Uso prolongado de anticonceptivos orales combinados durante más de 10 años
C) Obesidad severa (aromatización periférica en tejido adiposo) y Síndrome de Ovario Poliquístico
D) Tabaquismo crónico activo de más de 20 cigarrillos al día
E) Uso continuo de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Más preguntas online de Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario →

20.16. Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.019 3.01.2.016

¿POR QUÉ?

El dolor pélvico agudo ginecológico en una mujer en edad fértil con prueba de embarazo negativa representa un desafío clínico cotidiano en las unidades de emergencia. Las dos principales urgencias no obstétricas son la Torsión Anexial y el Quiste Ovárico Hemorrágico Roto. La Torsión Anexial es una verdadera emergencia isquémica por rotación del ovario y la trompa sobre su pedículo vascular, que cursa clásicamente con dolor paroxístico agudo unilateral y cortejo vegetativo severo (náuseas y vómitos en más del 80%); la conducta de elección actual y pregunta clásica de examen es la laparoscopía urgente con DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA para salvar el órgano, proscribiéndose la ooforectomía de entrada. Por su parte, el Quiste Hemorrágico Roto suele ser autolimitado tras el coito en fase lútea y su manejo primario es médico conservador salvo inestabilidad hemodinámica.

1. TORSIÓN ANEXIAL / OVÁRICA: FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

• **Fisiopatología:** Rotación total o parcial del ovario y trompa de Falopio sobre su eje vascular (el **ligamento infundíbulo-pélvico** o ligamento suspensorio del ovario, que transporta la arteria y vena ováricas). Inicialmente se ocluye el drenaje venoso y linfático (baja presión), provocando congestión pasiva masiva, edema ovárico extremo y hemorragia intraovárica; finalmente se ocluye el flujo arterial provocando **isquemia ovárica irreversible y necrosis gangrenosa** en cuestión de horas si no se desimpacta. 3.01.2.019 3.01.2.016

• **Factores de Riesgo: Presencia de un quiste ovárico preexistente de 5 a 10 cm de diámetro** (los teratomas quísticos maduros o quistes dermoides son los que con mayor frecuencia se tuercen debido a su alto contenido graso flotante y peso excéntrico), hiperestimulación ovárica en técnicas de reproducción asistida y el embarazo temprano (por cuerpo lúteo quístico grande).

• **Cuadro Clínico Clásico:**

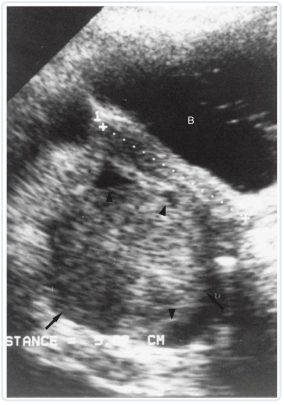
- **Dolor pélvico unilateral hiperagudo, súbito, lancinante y severo (10/10)** en fosa ilíaca derecha o izquierda, con episodios de exacerbación paroxística y alivio transitorio (torsión/detorsión intermitente).

- **Cortejo Vegetativo Acompañante Severo: Náuseas y vómitos profusos en más del 80% de los casos** (por reflejo vagal inducido por la isquemia visceral).

- Al examen: marcada defensa abdominal focal y masa anexial dolorosa exquisita al tacto bimanual.

• **Diagnóstico por Imágenes:**

- **Ecografía Transvaginal con Doppler Color:** Muestra un **ovario marcadamente aumentado de tamaño (> 4-5 cm) y edematoso** con estroma heterogéneo y folículos antrales desplazados a la periferia ('signo del collar de perlas'). En el pedículo vascular se visualiza el **'signo del remolino' (whirlpool sign)**. En el Doppler se aprecia ausencia o disminución del flujo venoso y arterial. *¡ADVERTENCIA EUNACOM!: La presencia de flujo Doppler arterial detectable NO DESCARTA la torsión* (debido a la doble irrigación de la arteria uterina; si la sospecha clínica es alta, debe operarse de inmediato). **(ver Imagen 20.16A, B y C)**



Signo del remolino

2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA TORSIÓN OVÁRICA: ABORDAJE CONSERVADOR

• **Emergencia Quirúrgica Inmediata:** La demora diagnóstica mayor a 24-36 horas condiciona la pérdida irreversible del ovario. 3.01.2.019

• **Vía de Abordaje Estándar: LAPAROSCOPÍA QUIRÚRGICA DE URGENCIA.**

• **Conducta Quirúrgica Moderna (Cambio de Paradigma EUNACOM):**

- Clásicamente se realizaba ooforectomía directa sin desenrollar por temor a embolias venosas. **HOY EN DÍA ESTA CONDUCTA ESTÁ OBSOLETA Y RECHAZADA.**

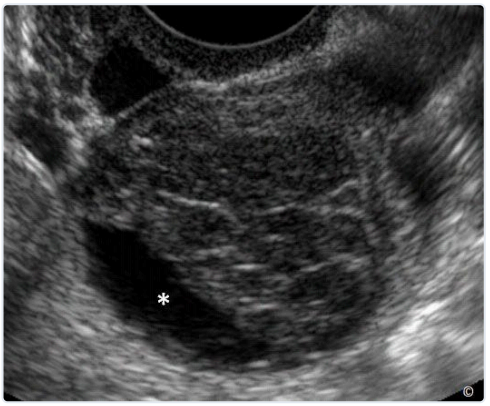
- **LA CONDUCTA DE ELECCIÓN ACTUAL ES LA DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA (Desenrollar el ovario):** El cirujano desenrolla el pedículo vascular y evalúa la viabilidad del órgano. **AUNQUE EL OVARIO SE OBSERVE NEGRUZCO, VIOLÁCEO O CIANÓTICO, SE DEBE CONSERVAR** (en más del 90% de los casos el ovario recupera su función hormonal y folicular a largo plazo).

- Si existe un quiste ovárico evidente (teratoma o cistoadenoma), se puede realizar quistectomía en el mismo acto si el tejido no está excesivamente friable, o diferirse a una segunda cirugía programada semanas después.

- La Ooforectomía total se reserva exclusivamente para mujeres postmenopáusicas o ante necrosis gangrenosa purulenta desintegrada irreversible.

3. QUISTE OVÁRICO HEMORRÁGICO ROTO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• **Fisiopatología:** Hemorragia espontánea dentro del cuerpo lúteo o quiste folicular durante la **fase lútea tardía (días 20 a 26 del ciclo)**. Al distenderse la cápsula, se rompe vertiendo sangre y líquido hemático hacia el fondo de saco de Douglas. 3.01.2.016



Ecografía de quiste hemorrágico del cuerpo lúteo con patrón en red de



Ecografía de quiste hemorrágico del cuerpo lúteo con patrón en red de

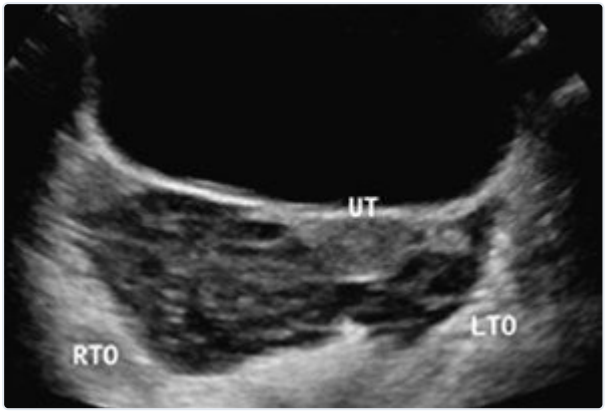
• **Desencadenante Clásico: Dolor pélvico agudo que se inicia durante o inmediatamente después de una relación sexual coital (coito postcoital)** o ejercicio físico vigoroso en los días previos a la menstruación.

• **Hallazgos Ecográficos:** Quiste ovárico con contenido ecogénico complejo heterogéneo que muestra **patrón reticular en 'tela de araña' o 'red de pesca'** (por hebras de fibrina) con coágulo retráctil avascular sin flujo Doppler interno, y presencia de **líquido libre hemático en el fondo de saco de Douglas**.

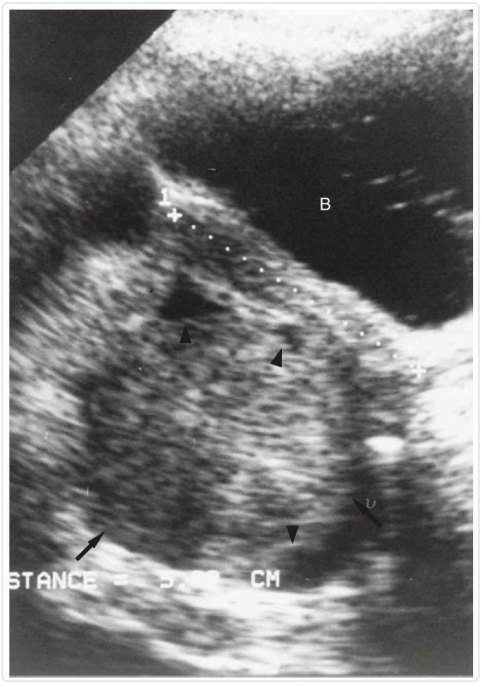
• **Conducta Terapéutica Escalonada:**

- **Paciente Hemodinámicamente ESTABLE (la inmensa mayoría): MANEJO MÉDICO CONSERVADOR EXPECTANTE**. Hospitalización en observación durante 24 horas, reposo en cama, hidratación, analgesia parenteral y control seriado de signos vitales y hematocrito. El sangrado casi siempre se autolimita espontáneamente y el hemoperitoneo se reabsorbe.

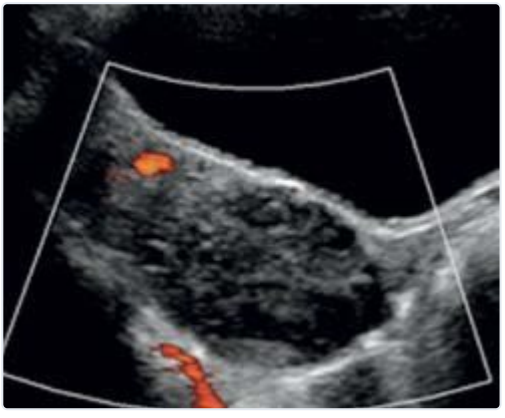
- **Paciente INESTABLE o con Hemoperitoneo Progresivo (Caída de hematocrito o shock): LAPAROSCOPÍA QUIRÚRGICA DE URGENCIA** para aspiración del hemoperitoneo, coagulación hemostática del lecho ovárico o cistectomía conservadora.



A. OVARIO AUMENTADO



B. SIGNO DEL REMOLINO



C. DOPPLER

Imagen 20.16

FIGURA 20.16 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAS URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

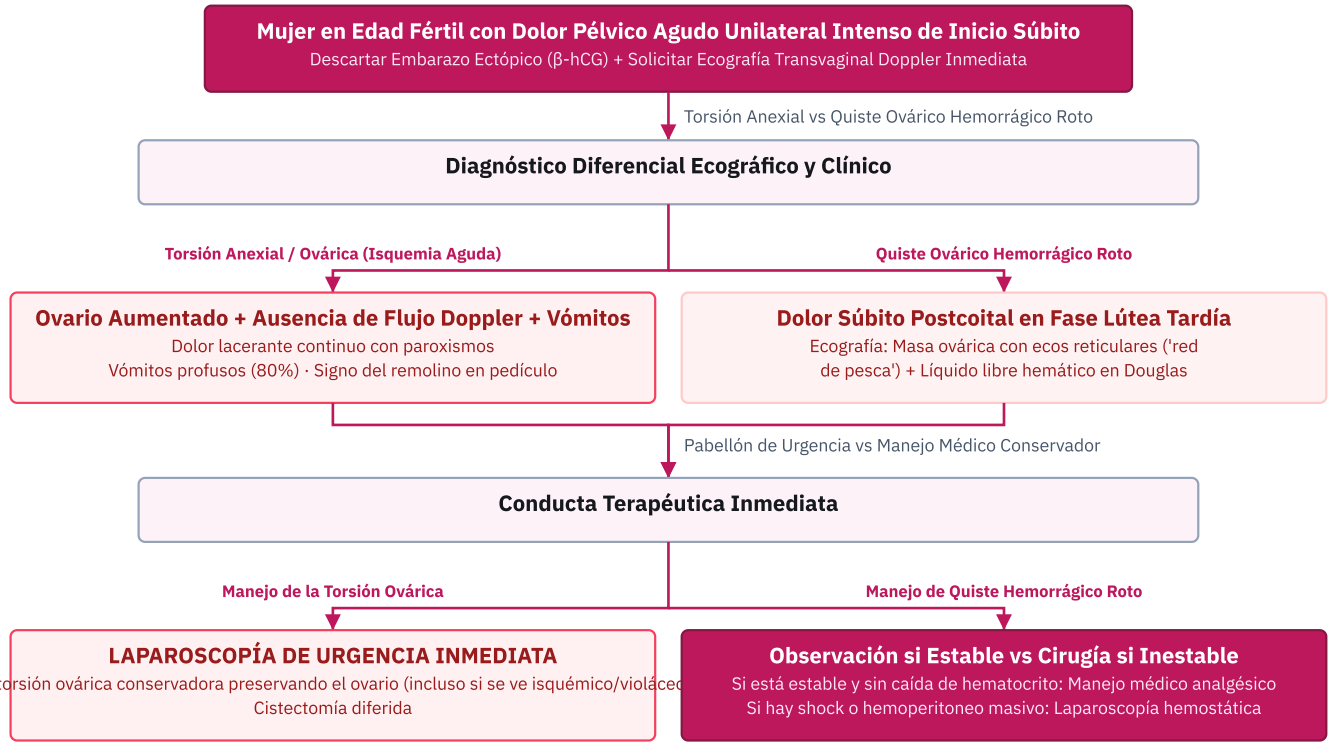


TABLA 20.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TORSIÓN ANEXIAL Y QUISTE OVÁRICO HEMORRÁGICO ROTO

3.01.2.019, 3.01.2.016

PARÁMETRO CLÍNICO	TORSIÓN ANEXIAL / OVÁRICA	QUISTE HEMORRÁGICO ROTO
Fisiopatología	Isquemia tisular aguda por rotación del pedículo vascular	Rotura de la cápsula ovárica con hemoperitoneo libre
Momento Típico del Ciclo	Cualquier momento del ciclo, embarazo o post-TRA	Fase lútea tardía (días 20-26 del ciclo menstrual)
Gatillante Frecuente	Movimientos bruscos o idiopático	Relaciones sexuales coitales recientes (postcoital)
Síntomas Acompañantes	Náuseas y vómitos profusos intensos (reflejo vagal)	Habitualmente sin vómitos; dolor pélvico que cede lentamente
Ecografía Doppler Color	Ovario muy aumentado, edematoso; flujo Doppler disminuido/ausente	Quiste con ecos reticulares en 'red de pesca' + líquido en Douglas
Conducta Inmediata	LAPAROSCOPÍA DE URGENCIA OBLIGATORIA	Manejo médico conservador expectante si estable
Técnica Quirúrgica	Detorsión ovárica conservadora (preservar ovario)	Laparoscopía hemostática solo si hay inestabilidad o hemoperitoneo masivo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 20.16

Mujer de 23 años, nulípara, sin antecedentes mórbidos, consulta en el servicio de urgencia a las 3 de la madrugada por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de inicio repentino hace 4 horas, lancinante y de intensidad 10/10, acompañado de cuatro episodios de vómitos profusos. Al examen físico: paciente quejumbrosa, afebril, PA 120/75 mmHg, FC 100 lpm. Abdomen sensible a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha con contractura muscular voluntaria sin Blumberg franco. Al tacto bimanual se palpa una masa anexial derecha extraordinariamente dolorosa de unos 7 cm. El test rápido de embarazo en orina es negativo y la orina completa es normal. La ecografía transvaginal urgente muestra un ovario derecho aumentado de tamaño a 75 mm, edematoso, que contiene una masa quística de 6 cm compatible con teratoma quístico maduro, con estroma heterogéneo y ausencia de flujo venoso en el estudio Doppler color. El ovario izquierdo es normal.

Conducta oficial. El cuadro clínico de dolor pélvico hiperagudo unilateral severo acompañado de cortejo vegetativo marcado (vómitos profusos), asociado al antecedente ecográfico de un quiste ovárico de 6 cm (teratoma) y un ovario aumentado de tamaño edematoso con cese de flujo Doppler venoso, es diagnóstico certero de Torsión Anexial / Ovárica. Se trata de una emergencia quirúrgica ginecológica donde el tiempo es factor determinante para evitar la necrosis isquémica irreversible del órgano. La conducta médica correcta e inmediata es preparar a la paciente y trasladarla a pabellón para LAPAROSCOPÍA QUIRÚRGICA DE URGENCIA. De acuerdo al estándar quirúrgico moderno de preservación de la fertilidad en mujeres jóvenes, el procedimiento de elección es la DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA (desenrollar el ovario y evaluar recuperación de perfusión), estando formalmente proscrita la ooforectomía de entrada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Torsión anexial: Isquemia aguda del ovario y trompa por rotación sobre el pedículo infundíbulo-pélvico.
- Tríada clásica de sospecha: Dolor pélvico hiperagudo severo + Masa anexial palpable + Vómitos profusos (80%).
- Factor predisponente principal: Quiste ovárico de 5 a 10 cm (especialmente Teratoma o quiste dermoide).
- La presencia de flujo arterial en el Doppler NO descarta la torsión ovárica (si hay sospecha clínica, se opera).
- Tratamiento quirúrgico de elección en torsión: LAPAROSCOPÍA URGENTE CON DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA.
- ¡Aun si el ovario se ve negruzco/isquémico, se debe detorcer y conservar! (La ooforectomía directa es obsoleta).
- Quiste hemorrágico roto: Dolor súbito postcoital en fase lútea tardía; patrón ecográfico en 'red de pesca'.
- Manejo de quiste hemorrágico: Observación médica conservadora si está hemodinámicamente estable.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 20.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.019

1. Una joven de 21 años consulta por dolor intenso y súbito en fosa ilíaca izquierda de 5 horas de evolución que se acompaña de náuseas y múltiples vómitos alimentarios. La prueba de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal Doppler revela un ovario izquierdo aumentado de volumen a 7 cm con estroma marcadamente edematoso y ausencia de flujo vascular al Doppler color, visualizándose el 'signo del remolino' en el pedículo. ¿Cuál es el tratamiento médico-quirúrgico inmediato más adecuado?

A) Prescribir analgesia con ketorolaco endovenoso y enviar a reposo en domicilio
B) Laparoscopía de urgencia inmediata para detorsión ovárica y preservación del anexo
C) Punción transvaginal evacuadora guiada por ecografía
D) Tratamiento antibiótico endovenoso para enfermedad pélvica inflamatoria
E) Ooforectomía radical izquierda abierta sin desenrollar el ovario

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.019

2. Una paciente de 24 años consulta por dolor pélvico agudo de inicio brusco tras mantener relaciones sexuales coitales hace 3 horas. Se encuentra en el día 23 de su ciclo menstrual (fase lútea tardía). Signos vitales: PA 118/74 mmHg, FC 78 lpm, afebril. Abdomen blando, sensible en fosa ilíaca derecha sin signos peritoneales. La prueba rápida de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal muestra una imagen quística ovárica derecha de 3.5 cm con múltiples septos finos reticulares en 'red de pesca' y escaso líquido libre anecoico en el fondo de saco de Douglas. Su hematocrito es de 40% y se mantiene estable tras 4 horas de observación. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Laparotomía exploradora de urgencia para ooforectomía derecha
B) Manejo médico conservador expectante con analgesia oral, reposo y control ambulatorio
C) Cistectomía ovárica laparoscópica inmediata
D) Inicio de quimioterapia con metotrexato parenteral
E) Transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos

Más preguntas online de Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 20.13 A 20.16

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	GES N° 3 Cáncer Cervicouterino: Tamizaje universal con PAP cada 3 años en mujeres de 25...	**Etiología: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en 60% y...**	Estadios avanzados con invasión de parametrios (≥ IIB): ¡PROHIBIDA LA CIRUGÍA! ->...
Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	Cáncer de mama: Primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile (GES N° 4 desde...	**Tamizaje GES: Mamografía bilateral bienal (cada 2 años) en mujeres de 50 a 69 años.**	Biopsia de Ganglio Centinela: De elección en axila clínicamente negativa para evitar...
Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	Regla de oro: Toda metrorragia en la postmenopausia es Cáncer de Endometrio hasta...	**Grosor endometrial normal en postmenopausia: Menor a 4 a 5 mm (si usa TRH hasta 8 mm).**	¡PROHIBIDO PUNCIONAR una masa ovárica sospechosa por riesgo de rotura y siembra...
Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	Torsión anexial: Isquemia aguda del ovario y trompa por rotación sobre el pedículo...	**Tríada clásica de sospecha: Dolor pélvico hiperagudo severo + Masa anexial palpable +...**	La presencia de flujo arterial en el Doppler NO descarta la torsión ovárica (si hay...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

GES N° 3 Cáncer Cervicouterino: Tamizaje universal con PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años.

Etiología: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en 60% y VPH 18 en 15%).

Oncoproteínas oncogénicas: E6 degrada al gen supresor p53; E7 inactiva a la proteína pRb.

PAP con LIEAG (H-SIL) o NIE II-III: DERIVACIÓN INMEDIATA A COLPOSCOPÍA Y BIOPSIA en UPC (Garantía GES < 30 días).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Etiología: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en 60% y VPH 18 en 15%).
- Oncoproteínas oncogénicas: E6 degrada al gen supresor p53; E7 inactiva a la proteína pRb.
- Tamizaje GES: Mamografía bilateral bienal (cada 2 años) en mujeres de 50 a 69 años.
- BI-RADS 3: Probablemente benigno (< 2% riesgo); requiere seguimiento mamográfico en 6 meses.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

GES N° 3 Cáncer Cervicouterino: Tamizaje universal con PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años.	Tema 20.13 →
Cáncer de mama: Primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile (GES N° 4 desde los 15 años).	Tema 20.14 →
Regla de oro: Toda metrorragia en la postmenopausia es Cáncer de Endometrio hasta demostrar lo contrario.	Tema 20.15 →
Torsión anexial: Isquemia aguda del ovario y trompa por rotación sobre el pedículo infundíbulo-pélvico.	Tema 20.16 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 20.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

Una paciente de 25 años, con antecedentes de menstruaciones regulares, consulta por amenorrea de 5 meses. No utiliza...

CLAVE B **Presencia de un endometrio adecuadamente proliferado por estrógenos endógenos pero con anovulación**

A) Incorrecta. En la falla ovárica prematura no hay estrógenos para proliferar el endometrio, por lo que el test de progesterona resulta negativo. B) Correcta. El Test de Progesterona consiste en administrar un progestágeno durante 5 a 10 días para inducir la maduración secretora del endometrio y posterior descamación por deprivación. Si la paciente sangra (Test Positivo), significa con absoluta certeza que su organismo produce cantidades suficientes de Estrógenos endógenos para preparar y proliferar el endometrio, pero no produce progesterona propia debido a la ausencia de cuerpo lúteo, lo que define un estado de Anovulación crónica (la causa más frecuente en mujeres jóvenes es el Síndrome de Ovario Poliquístico). C) Incorrecta. Si hubiera estenosis cervical la sangre no podría exteriorizarse por la vagina. D) Incorrecta. En el síndrome de Asherman no hay endometrio funcionante y el test de progesterona es estrictamente negativo. E) Incorrecta.

> **Perla.** En el hipogonadismo hipogonadotropo no hay estímulo ovárico ni estrógenos.

TEMA 20.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

Una joven de 17 años es evaluada por amenorrea primaria. Al examen físico presenta una talla de 1.70 m, excelente...

CLAVE C **Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (Síndrome de Morris)**

A) Incorrecta. En el síndrome de Rokitansky el cariotipo es 46,XX y el vello pubiano y axilar es completamente normal. B) Incorrecta. El Turner tiene cariotipo 45,X0, talla baja y mamas no desarrolladas. C) Correcta. El Síndrome de Morris (Feminización Testicular o Insensibilidad a los Andrógenos) es una entidad con cariotipo 46,XY caracterizada por la mutación del receptor de andrógenos. Los testículos fetales producen testosterona y hormona antimülleriana (AMH); la AMH produce regresión de los conductos de Müller (por lo que NO hay útero ni tercio superior de vagina). Debido a la insensibilidad androgénica periférica completa, los genitales externos se desarrollan con fenotipo femenino y NO se desarrolla vello púbico ni axilar (signo patognomónico). La testosterona circulante se aromatiza periféricamente a estrógenos, generando un excelente desarrollo de mamas. Las masas inguinales corresponden a los testículos ectópicos, los cuales deben extirparse tras completar la pubertad por riesgo de neoplasia (gonadoblastoma/seminoma). D) Incorrecta. En Swyer no hay desarrollo mamario (mamas infantiles por falta de estrógenos) y sí tienen útero. E) Incorrecta.

> **Perla.** Provoca virilización de genitales en fetos 46,XX.

TEMA 20.1 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

Una paciente de 33 años, con antecedente de legrado uterino instrumental por aborto incompleto hace 6 meses, consulta...

CLAVE B **Histeroscopía diagnóstica**

A) Incorrecta. La RMN sella se solicita ante hiperprolactinemia, pero aquí el problema es endometrial. B) Correcta. El fracaso en presentar sangrado por deprivación tras el ciclo combinado de estrógenos más progesterona demuestra que el endometrio no responde o existe una obliteración mecánica del canal uterino. En una paciente con antecedente reciente de legrado uterino, este hallazgo es patognomónico del Síndrome de Asherman (sinequias o adherencias intrauterinas cicatriciales que obliteran la cavidad endometrial). El estándar de oro diagnóstico y terapéutico indiscutido es la Histeroscopía, la cual permite visualizar directamente las bridas y realizar la lisis quirúrgica de las mismas. C) Incorrecta. El cariotipo es para amenorreas primarias. D) Incorrecta. La TAC no tiene resolución para sinequias endometriales. E) Incorrecta.

> **Perla.** La AMH evalúa reserva ovárica, no la cavidad uterina.

TEMA 20.1 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.012

Una mujer de 19 años es evaluada por amenorrea primaria y ausencia total de desarrollo puberal (Tanner mamario I)...

CLAVE B **Síndrome de Kallmann**

A) Incorrecta. El Turner tiene FSH marcadamente elevada por falla ovárica gonadal, no baja, y no tiene anosmia. B) Correcta. La asociación patognomónica de hipogonadismo hipogonadotropo (FSH y LH muy disminuidas con falta de desarrollo puberal) y Anosmia o Hiposmia congénita define el Síndrome de Kallmann. Se debe a un defecto genético en la migración embrionaria de las neuronas secretoras de GnRH y de las neuronas del bulbo olfatorio desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo. C) Incorrecta. El craneofaringioma produce cefalea, alteraciones del campo visual (hemianopsia) y diabetes insípida, no anosmia congénita aislada. D) Incorrecta. La falla ovárica cursa con FSH elevada. E) Incorrecta.

> **Perla.** En Rokitansky el eje gonadotropo es normal y las pacientes tienen excelente desarrollo mamario.

TEMA 20.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.015

Una mujer de 22 años consulta por ciclos menstruales que se presentan cada 50 a 70 días, asociados a aumento de vello...

CLAVE B **Anticonceptivos orales combinados con progestágeno antiandrogénico (ej. Etinilestradiol con Dienogest o Ciproterona)**

A) Incorrecta. El clomifeno se utiliza para inducir ovulación en mujeres que desean embarazarse activamente. B) Correcta. La paciente cumple con los tres criterios de Rotterdam para SOP (oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico y morfología ovárica ecográfica policística). En mujeres que no buscan fertilidad, la primera línea farmacológica según las guías internacionales y del MINSAL son los Anticonceptivos Orales Combinados (ACOs) con progestágeno antiandrogénico (Dienogest, Drospirenona o Acetato de Ciproterona). Los ACOs reducen la secreción de LH, elevan la SHBG plasmática (disminuyendo la testosterona libre circulante, lo que mejora el acné y el hirsutismo) y regularizan las descamaciones endometriales, previniendo el desarrollo de hiperplasia endometrial. C) Incorrecta. Los corticoides no son el tratamiento del SOP. D) Incorrecta. La cirugía de resección ovárica está en desuso por riesgo de adherencias pelvianas e insuficiencia ovárica. E) Incorrecta.

Perla. El danazol es androgénico y empeoraría el hirsutismo.

TEMA 20.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.015

¿Cuál es la complicación neoplásica ginecológica a largo plazo cuya incidencia se encuentra significativamente...

CLAVE B **Carcinoma de endometrio tipo I (endometrioide)**

A) Incorrecta. El CCU depende de la infección persistente por VPH, no de la anovulación. B) Correcta. En el SOP, la anovulación crónica persistente provoca una ausencia prolongada de cuerpo lúteo y, por ende, de progesterona. Esto genera un ambiente hormonal caracterizado por la presencia continua de estrógenos libres que estimulan de forma ininterrumpida la proliferación celular del endometrio sin la acción maduradora y antiproliferativa de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). Con los años, esta hiperproliferación conduce sucesivamente a hiperplasia endometrial simple, hiperplasia endometrial con atipias y finalmente a Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I (endometrioide), con un riesgo de 3 a 5 veces superior al de mujeres ovuladoras. C) Incorrecta. El cáncer epitelial de ovario se relaciona con mayor número de ovulaciones incesantes (el SOP es anovulatorio). D) Incorrecta. Es un tumor trofoblástico postgestacional. E) Incorrecta.

Perla. Neoplasia mesenquimatosa no vinculada al SOP.

TEMA 20.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

Una paciente de 47 años consulta por sangrado uterino anormal de 4 meses de evolución, con menstruaciones abundantes y...

CLAVE B **Realización de una biopsia de endometrio ambulatoria con cánula de Pipelle**

A) Incorrecta. Instalar un DIU-LNG sin descartar previamente malignidad en una mujer de 47 años con endometrio engrosado puede retrasar catastróficamente el diagnóstico de un adenocarcinoma endometrial. B) Correcta. Según los consensos internacionales (FIGO, ACOG) y las directrices del MINSAL, toda mujer de 45 años o más que consulte por Sangrado Uterino Anormal tiene indicación mandatoria de Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle ambulatoria o histeroscopía) para descartar cáncer de endometrio o hiperplasia endometrial con atipias antes de definir o iniciar un tratamiento médico hormonal definitivo. C) Incorrecta. La histerectomía es desproporcionada y prematura sin un diagnóstico histopatológico previo. D) Incorrecta. El ácido tranexámico solo controla el síntoma pero no descarta malignidad. E) Incorrecta.

Perla. Observar en una paciente perimenopáusica con sangrado abundante es negligencia médica.

TEMA 20.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

Una adolescente de 14 años es traída a la urgencia por metrorragia abundante de 10 días de evolución desde su menarquia...

CLAVE B **Coagulopatía congénita (Enfermedad de von Willebrand)**

A) Incorrecta. La adenomiosis es excepcional en adolescentes y propia de multíparas sobre 35 años. B) Correcta. Dentro de la clasificación PALM-COEIN, la letra 'C' corresponde a Coagulopatías. La Enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía hereditaria más común y se diagnostica en hasta un 20% de las adolescentes que ingresan hospitalizadas por hipermenorrea severa desde su menarquia, especialmente si se acompaña de historia de sangrado mucocutáneo (epistaxis, equimosis, gingivorragia). Debe solicitarse estudio de hemostasia completo (antígeno de vWF, actividad de cofactor de ristocetina y factor VIII). C) Incorrecta. El cáncer endometrial es extraordinariamente infrecuente a los 14 años. D) Incorrecta. Los pólipos son causas estructurales raras en la adolescencia. E) Incorrecta.

Perla. Los miomas son típicos de mujeres en la 4.ª y 5.ª década de la vida.

TEMA 20.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

¿Cuál de los siguientes métodos terapéuticos médicos ha demostrado la mayor tasa de reducción del volumen de sangrado...

CLAVE B **Dispositivo intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG)**

A) Incorrecta. La aspirina es un antiagregante plaquetario que aumenta el sangrado. B) Correcta. El Dispositivo Intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG / Mirena) es el tratamiento farmacológico no quirúrgico más eficaz disponible en la medicina actual para el SUA no estructural. Al liberar diariamente levonorgestrel directamente en la cavidad uterina, produce una intensa decidualización del estroma y una atrofia endometrial marcada y reversible, reduciendo la pérdida sanguínea menstrual en más de un 90% a los 6 meses, superando con creces a cualquier terapia oral y evitando histerectomías en un alto porcentaje de pacientes. C) Incorrecta. El DIU de cobre tiene como efecto secundario común el AUMENTO del sangrado menstrual y la dismenorrea. D) Incorrecta. Los progestágenos orales continuos son eficaces pero inferiores al DIU-LNG en adherencia y reducción neta. E) Incorrecta.

Perla. La vitamina K solo es útil en coagulopatías por déficit de factores dependientes o sobredosis de cumarínicos.

TEMA 20.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.018

Una paciente de 56 años, menopáusica desde hace 5 años sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un episodio de...

CLAVE A **Descartar Cáncer de Endometrio mediante Biopsia Endometrial (Pipelle o histeroscópica)**

A) Correcta. El sangrado uterino en una mujer postmenopáusica es un síntoma de alarma neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. Aunque la atrofia endometrial es la causa más frecuente en número de casos, el Cáncer de Endometrio es la causa maligna subyacente en el 10 al 15% de las pacientes. Un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una postmenopáusica exige de forma mandatoria la toma de una Biopsia Endometrial para estudio histopatológico definitivo. B) Incorrecta. Aunque la vaginitis atrófica es frecuente, un endometrio de 9 mm (> 4-5 mm) prohíbe atribuir el sangrado a atrofia sin biopsia. C) Incorrecta. Administrar hormonas a ciegas sobre un eventual adenocarcinoma retrasa el tratamiento curativo. D) Incorrecta. Conducta negligente ante metrorragia de la postmenopausia. E) Incorrecta.

Perla. La cirugía de ovario no diagnostica el sangrado uterino.

TEMA 20.4 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.021

Una paciente de 34 años, nuligesta, que desea embarazarse en el corto plazo, consulta por hipermenorrea de 7 meses de...

CLAVE B **Resección del mioma mediante Miomectomía Histeroscópica**

A) Incorrecta. La histerectomía mutilaría definitivamente su deseo de fertilidad. B) Correcta. En una paciente con deseo de embarazo que presenta un mioma submucoso intracavitario (FIGO 0 o 1) menor de 4-5 cm que causa sangrado o distorsión de la cavidad endometrial, el tratamiento de elección indiscutido es la Miomectomía por Histeroscopía quirúrgica resectoscópica. Es un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y conservador que extirpa el mioma respetando la pared miometrial y restaurando la anatomía endometrial y la fertilidad. C) Incorrecta. La embolización de arterias uterinas puede comprometer la reserva ovárica y aumentar complicaciones obstétricas posteriores, por lo que está formalmente desaconsejada en mujeres con deseo de gestación. D) Incorrecta. Los análogos de GnRH solo se usan por un máximo de 3-6 meses como puente quirúrgico, no como terapia definitiva por riesgo de osteoporosis severa. E) Incorrecta.

Perla. Los miomas son benignos y la radioterapia no tiene indicación.

TEMA 20.4 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.021

Una embarazada de 22 semanas consulta en la urgencia por dolor abdominal agudo intenso en hipogastrio y flanco derecho...

CLAVE B **Degeneración roja (necrobiosis) de un mioma uterino; manejo médico conservador con reposo, hidratación y analgesia**

A) Incorrecta. La masa dependiente del útero con cambios ecográficos típicos corresponde al mioma, no a apéndice cecal. B) Correcta. La Degeneración Roja o Necrobiosis Aséptica es una complicación clásica de los miomas durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Se produce debido al rápido crecimiento del leiomioma estimulado por las hormonas placentarias que sobrepasa el aporte vascular del pedículo, provocando isquemia tisular, trombosis venosa e infarto hemorrágico. Clínicamente se manifiesta como dolor localizado agudo intenso, febrícula y leucocitosis moderada. El tratamiento es estrictamente CONSERVADOR y MÉDICO (hospitalización, hidratación, analgesia parenteral con paracetamol u opiáceos SOS); la miomectomía está formalmente contraindicada durante el embarazo por el altísimo riesgo de hemorragia masiva incontrolable y pérdida gestacional. C) Incorrecta. No hay antecedente de trabajo de parto ni cese de dinámica. D) Incorrecta. El sarcoma es excepcional en menores de 50 años. E) Incorrecta.

Perla. No hay RPM ni loquios fétidos; el útero no está infectado.

TEMA 20.5 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

Una paciente de 26 años consulta por dismenorrea secundaria severa que le impide asistir al trabajo durante sus...

CLAVE B **Dienogest 2 mg al día por vía oral de forma continua**

A) Incorrecta. Los analgésicos simples son totalmente insuficientes para una endometriosis sintomática. B) Correcta. En pacientes con endometriosis y dolor pélvico (dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico) que NO desean fertilidad activa inmediata, el tratamiento médico de primera línea de elección respaldado por las guías clínicas internacionales (ESHRE) y el MINSAL es el uso continuo de Progestágenos, siendo el DIENOGEST oral a dosis de 2 mg al día el estándar de oro actual. El dienogest produce decidualización y atrofia directa de las lesiones endometriósicas ectópicas, suprime la ovulación y reduce la inflamación pélvica de forma segura y prolongada. C) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico. D) Incorrecta. El clomifeno estimula la foliculogénesis e induciría mayor crecimiento estrogénico de los implantes. E) Incorrecta.

Perla. Los estrógenos solos alimentarían y proliferarían agresivamente las lesiones de endometriosis.

TEMA 20.5 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

Una mujer de 30 años, con antecedente de dolor pélvico crónico e infertilidad primaria de 2 años, se somete a una...

CLAVE B **Endometrioma ovárico**

A) Incorrecta. El cistoadenocarcinoma seroso muestra áreas sólidas, septos gruesos, papilas internas y ascitis con alta vascularización Doppler. B) Correcta. La descripción ecográfica clásica y patognomónica de una masa quística unilocular ovárica con ecos internos finos y homogéneos de bajo nivel descrita como imagen en 'vidrio esmerilado' (ground glass appearance), con pared regular y sin vascularización Doppler interna en una mujer joven con dolor pélvico e infertilidad, corresponde con total precisión a un Endometrioma Ovárico (o 'quiste de chocolate'). C) Incorrecta. El teratoma muestra nódulos ecogénicos murales (tapón de Rokitansky), niveles líquido-grasa y áreas de sombra acústica por calcificaciones o dientes. D) Incorrecta. El quiste folicular es anecoico puro, con refuerzo acústico posterior y sin ecos internos. E) Incorrecta.

Perla. El absceso tubo-ovárico es una masa compleja multiloculada dolorosa con paredes engrosadas y Doppler hiperémico.

TEMA 20.5 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

¿Por qué razón farmacológica el tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales combinados o progestágenos...

CLAVE B **Porque suprimen la ovulación y no mejoran las tasas de fertilidad ni de nacidos vivos tras suspenderlos, retrasando el tratamiento reproductivo efectivo**

A) Incorrecta. No son teratogénicos irreversibles. B) Correcta. La evidencia médica basada en ensayos clínicos aleatorizados y guías internacionales (ESHRE / ASRM) ha demostrado de forma categórica que la supresión médica hormonal de la endometriosis (con ACOs, progestágenos, análogos de GnRH o danazol) NO erradica las adherencias anatómicas ni mejora las tasas acumuladas de embarazo espontáneo tras su retiro, y tiene el efecto deletéreo de anovulación que posterga inútilmente el tiempo reproductivo de la mujer. Ante infertilidad por endometriosis, el camino es la cirugía laparoscópica para reparar la anatomía o la fertilización in vitro (FIV). C) Incorrecta. No ocluyen las trompas. D) Incorrecta. No tienen relación con enfermedad trofoblástica. E) Incorrecta.

Perla. No aceleran la pérdida folicular.

TEMA 20.5 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.015

Una paciente de 42 años, multípara de 3, consulta por hipermenorrea severa y dismenorrea secundaria progresiva. Al...

CLAVE A **Glándulas y estroma endometrial ectópicos en el espesor del miometrio con hipertrofia muscular concéntrica (Adenomiosis)**

A) Correcta. El cuadro de útero uniformemente aumentado de tamaño, blando y doloroso en una multípara de más de 40 años con hipermenorrea y dismenorrea severa corresponde a una Adenomiosis Uterina (o endometriosis interna). La definición anatomopatológica estricta de la adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio a más de 2.5 mm de la capa basal del endometrio, acompañada de hiperplasia e hipertrofia del músculo liso adyacente. B) Incorrecta. Es la definición de mioma. C) Incorrecta. Corresponde a un sarcoma uterino maligno. D) Incorrecta. Es un pólipo cervical. E) Incorrecta.

Perla. Describe implantes de endometriosis externa peritoneal.

TEMA 20.6 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.032

Una paciente de 62 años consulta por sensación de peso genital y escapes de orina involuntarios que ocurren...

CLAVE A **Colocación de cabestrillo mediouretral libre de tensión (cinta TOT o TVT)**

A) Correcta. La Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) confirmada clínicamente que no responde al tratamiento conservador tiene como estándar de oro quirúrgico indiscutido la colocación de un Cabestrillo Mediouretral Libre de Tensión (Slings tipo TOT [Trans-Obturator Tape] o TVT [Tension-free Vaginal Tape]). Estas cintas de polipropileno se ubican debajo de la uretra media por vía vaginal, restableciendo el soporte suburetral y logrando tasas de continencia y curación superiores al 85-90% con baja morbilidad. B) Incorrecta. La toxina botulínica vesical es para la incontinencia de urgencia severa refractaria, no para la de esfuerzo. C) Incorrecta. La oxibutinina es un anticolinérgico para la hiperactividad del detrusor; en la IUE es ineficaz. D) Incorrecta. Es una cirugía mayor reservada para vejigas neurógenas espásticas de escasa capacidad. E) Incorrecta.

Perla. Procedimiento en desuso y sin rol en IUE.

TEMA 20.6 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.032

Una mujer de 68 años acude a control refiriendo que con frecuencia experimenta una sensación urgente, súbita e...

CLAVE B **Iniciar reeducación vesical combinada con un fármaco anticolinérgico como Solifenacina o un agonista beta-3 como Mirabegrón**

A) Incorrecta. La cirugía de TOT/TVT está contraindicada en la incontinencia de urgencia porque no trata la hiperactividad del detrusor e incrementa el riesgo de retención urinaria y empeoramiento de la urgencia. B) Correcta. El cuadro clínico de deseo miccional imperioso seguido de escape, acompañado de polaquiuria diurna y nicturia sin esfuerzo asociado corresponde a una Incontinencia Urinaria de Urgencia (Vejiga Hiperactiva). El tratamiento de primera línea no invasivo consiste en medidas higiénico-dietéticas y reeducación vesical con micciones programadas, asociado a tratamiento farmacológico con Antimuscarínicos (Solifenacina, Oxibutinina) para bloquear los receptores colinérgicos del detrusor, o un agonista de receptores beta-3 adrenérgicos (Mirabegrón) que promueve la relajación del detrusor durante el llenado vesical. C) Incorrecta. La restricción extrema de líquidos concentra la orina y estimula aún más el detrusor. D) Incorrecta. No hay estenosis uretral. E) Incorrecta.

Perla. El sedimento es normal y el uso prolongado de antibióticos genera resistencia innecesaria.

TEMA 20.7 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.020

Una pareja acude a consulta por no lograr embarazo tras 2 años de búsqueda. En el estudio básico inicial se realiza una...

CLAVE C **Fertilización In Vitro (FIV)**

A) Incorrecta. El semen del esposo es normal y las trompas de la mujer están bloqueadas, por lo que la IIU fracasará independientemente del origen del semen. B) Incorrecta. Las relaciones programadas no sirven si los gametos no pueden encontrarse por la obstrucción física tubárica. C) Correcta. La obstrucción tubárica bilateral no corregible es la indicación clásica y primordial de la Fertilización In Vitro (FIV). La FIV 'bypasea' o salta completamente la necesidad funcional de las trompas de Falopio al aspirar los ovocitos directamente del ovario mediante punción transvaginal, fertilizarlos con los espermatozoides en la placa de cultivo del laboratorio y transferir el embrión resultante directamente a la cavidad endometrial. D) Incorrecta. La Inseminación Intrauterina (IIU) exige como condición indispensable que al menos una trompa esté permeable; al estar ambas bloqueadas, la tasa de éxito de la IIU es del 0%. E) Incorrecta.

Perla. Los antibióticos no resuelven la fibrosis cicatrizal tubárica establecida.

TEMA 20.7 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.020

En el estudio de un varón de 30 años cuya pareja no logra concebir, se solicita un espermiograma de control. Para que...

CLAVE B **De 3 a 5 días de abstinencia estricta**

A) Incorrecta. Una abstinencia menor a 48 horas reduce artificialmente el volumen y el recuento total de espermatozoides. B) Correcta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías clínicas de fertilidad establecen de forma estricta que la recolección de semen para un espermiograma diagnóstico debe realizarse tras un período mínimo de 2 a 3 días y un máximo de 5 a 7 días de abstinencia sexual previa (la recomendación estándar óptima es de 3 a 5 días). Períodos más cortos disminuyen el volumen y concentración espermática, mientras que períodos más prolongados aumentan el recuento a expensas de una drástica caída en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides por envejecimiento celular. C) Incorrecta. Abstinencias muy prolongadas aumentan las formas muertas y detritos. D) Incorrecta. Es el parámetro preanalítico más crítico de estandarización. E) Incorrecta.

Perla. La recolección seminal masculina no depende del día del ciclo femenino.

TEMA 20.8 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

Una paciente de 36 años, sin antecedentes cardiovasculares pero fumadora activa de una cajetilla diaria (20 cigarrillos...

CLAVE C **Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol con levonorgestrel**

A) Incorrecta. El DIU de cobre es Categoría 1 (sin ninguna restricción). B) Incorrecta. El implante de etonogestrel contiene solo progestágeno y es Categoría 1 en fumadoras. C) Correcta. De acuerdo a los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS y a las normas de anticoncepción del MINSAL, ser mujer de 35 años o más y fumar 15 o más cigarrillos al día es una contraindicación formal absoluta (CATEGORÍA 4: Riesgo inaceptable para la salud) para el uso de Anticonceptivos Hormonales Combinados que contengan estrógenos. El sinergismo entre el etinilestradiol y los componentes del tabaco altera severamente la función endotelial y la hemostasia, disparando el riesgo de infarto de miocardio, trombosis venosa y ACV isquémico. D) Incorrecta. El DIU-LNG contiene solo progestágeno local y es totalmente seguro (Categoría 1). E) Incorrecta.

Perla. La minipíldora de solo progestágeno es Categoría 1 en fumadoras.

TEMA 20.8 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

Una joven de 20 años consulta en el servicio de urgencia 18 horas después de una relación sexual no protegida por...

CLAVE B **Levonorgestrel 1.5 mg oral en dosis única; retraso o inhibición del pico ovulatorio de LH**

A) Incorrecta. La mifepristona es un antiprogestágeno utilizado en interrupción del embarazo, no la PAE estándar en Chile. B) Correcta. El método de anticoncepción de emergencia farmacológico de elección en Chile y en los protocolos del MINSAL es el LEVONORGESTREL a dosis única de 1.5 mg por vía oral (o dos comprimidos de 0.75 mg juntos), administrado preferentemente dentro de las primeras 72 horas del coito no protegido. Su mecanismo de acción biológico comprobado consiste en impedir o postergar el pico ovulatorio de LH y la consecuente expulsión del ovocito; NO actúa como un método abortivo, no afecta el endometrio receptivo ni daña un embrión ya implantado. C) Incorrecta. El misoprostol es un abortivo sintético, no anticoncepción de emergencia. D) Incorrecta. El metotrexato es un citotóxico para ectópico. E) Incorrecta.

Perla. El método de Yuzpe clásico con estrógenos está en desuso por su alta tasa de náuseas y menor eficacia.

TEMA 20.8 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.008

Una paciente de 28 años con antecedente de migraña clásica con aura visual (escotomas centelleantes) frecuente acude a...

CLAVE A **Anillo vaginal liberador de etinilestradiol y etonogestrel**

A) Correcta. La Migraña con AURA a cualquier edad es una condición de CATEGORÍA 4 de la OMS (Riesgo inaceptable para la salud / contraindicación absoluta) para TODOS los métodos anticonceptivos hormonales combinados (ACOs, parche transdérmico y anillo vaginal). Los estrógenos provocan vasoconstricción y microtrombosis cerebral que, sumados a la fisiopatología vasoespástica del aura migrañosa, elevan drásticamente el riesgo de Infarto Cerebral Isquémico (ACV). En cambio, los métodos de solo progestágeno (implante, DIU-LNG, minipíldora) y el DIU de cobre son completamente seguros. B) Incorrecta. El implante es de solo progestágeno y es seguro en migraña con aura. C) Incorrecta. El DIU de cobre no tiene hormonas y es totalmente seguro. D) Incorrecta. El desogestrel no contiene estrógenos. E) Incorrecta.

Perla. El DIU-LNG es de solo progestágeno local y seguro.

TEMA 20.8 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.006

Una paciente que tomó la píldora de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 1.5 mg presenta un episodio de...

CLAVE B **Repetir de inmediato la dosis completa de 1.5 mg de Levonorgestrel, idealmente asociando un antiemético oral**

A) Incorrecta. La absorción gástrica y duodenal de los comprimidos tarda entre 1 y 2 horas. B) Correcta. De acuerdo a las directrices de la OMS y a la Norma General Técnica de Regulación de la Fertilidad del MINSAL, si una mujer vomitara dentro de las PRIMERAS 2 HORAS posteriores a la ingestión de la píldora de anticoncepción de emergencia de Levonorgestrel, se asume que el fármaco no fue absorbido en cantidad terapéutica suficiente y la paciente DEBE tomar una nueva dosis completa de 1.5 mg lo antes posible, pudiendo administrarse previamente un antiemético (como metoclopramida o domperidona) para asegurar la retención gástrica. C) Incorrecta. El método aún puede ser administrado y no se sabe si habrá fecundación. D) Incorrecta. Los antibióticos no tienen ningún rol en la anticoncepción. E) Incorrecta.

Perla. No resolver la falta de absorción deja a la paciente totalmente desprotegida.

TEMA 20.9 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

Una paciente de 25 años acude por flujo vaginal abundante con olor fétido a pescado, que se acentúa después de las...

CLAVE B **Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días a la paciente**

A) Incorrecta. El fluconazol es antifúngico para candidiasis. B) Correcta. La paciente cumple con los 4 Criterios de Amsel para Vaginosis Bacteriana (flujo fino homogéneo blanco-grisáceo, pH > 4.5, test de aminas positivo con KOH y presencia de más de un 20% de células clave o 'clue cells' en el frotis). El tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la OMS es el Metronidazol oral a dosis de 500 mg cada 12 horas durante 7 días (o gel de metronidazol tópico). Es un hecho clínico comprobado que la vaginosis bacteriana NO requiere tratamiento de la pareja sexual masculina de rutina, a diferencia de la tricomoniasis. C) Incorrecta. La ceftriaxona es para cervicitis gonocócica. D) Incorrecta. La nistatina es para hongos. E) Incorrecta.

Perla. La doxiciclina es para clamidia.

TEMA 20.9 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.008

Una mujer de 29 años en tratamiento con amoxicilina por una sinusitis acude a consulta por prurito vulvar desesperante...

CLAVE B **Candidiasis vulvovaginal**

A) Incorrecta. La vaginosis cursa con pH elevado > 4.5 y test de aminas positivo, sin prurito intenso ni eritema. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar severo, antecedente reciente de tratamiento antibiótico, leucorrea espesa grumosa en 'leche cortada' con placas adherentes a una mucosa intensamente eritematosa, asociado a un pH vaginal NORMAL ÁCIDO (5.0 y colpitis en fresa. D) Incorrecta. La cervicitis cursa con secreción endocervical purulenta sin afectación vulvar primaria. E) Incorrecta.

Perla. La vaginitis atrófica ocurre en la postmenopausia con mucosa pálida y pH alcalino.

TEMA 20.9 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

¿En cuál de las siguientes infecciones ginecológicas del tracto genital inferior es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO...

CLAVE C **Tricomoniasis vaginal**

A) Incorrecta. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que tratar a la pareja masculina en la vaginosis bacteriana no previene las recurrencias. B) Incorrecta. La candidiasis no se clasifica como una ITS; el tratamiento de la pareja asintomática no está indicado. C) Correcta. La Tricomoniasis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) clásica en la que el varón suele actuar como portador asintomático del protozoo en la uretra y próstata. Por esta razón, el tratamiento simultáneo de la pareja sexual (con Metronidazol 2g oral en dosis única o 500 mg cada 12 horas por 7 días) junto con la indicación de abstinencia coital es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO en todos los casos para prevenir la reinfección inmediata de la mujer y detener la transmisión comunitaria. D) Incorrecta. Es un cuadro no infeccioso idiopático mediado por inmunidad. E) Incorrecta.

Perla. La cistitis por E. coli no es una ITS y no requiere tratamiento de la pareja.

TEMA 20.9 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.017

Una paciente de 21 años consulta por leucorrea purulenta y sangrado postcoital ocasional. A la especuloscopía se...

CLAVE B **Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días**

A) Incorrecta. El metronidazol no cubre Neisseria gonorrhoeae ni Chlamydia trachomatis. B) Correcta. El cuadro de secreción purulenta endocervical con cuello friable corresponde a una Cervicitis Mucopurulenta aguda. Dado que los dos agentes causales más frecuentes y graves son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis y que la coinfección es muy habitual, la norma ministerial y los CDC recomiendan el tratamiento empírico inmediato combinado de amplio espectro: Ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única (para gonococo) MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral por 7 días (para Chlamydia). Se debe citar a la pareja para tratamiento simultáneo. C) Incorrecta. El gonococo tiene altísima resistencia a aminopenicilinas y no cubre Chlamydia. D) Incorrecta. Es un antifúngico ineficaz contra bacterias. E) Incorrecta.

Perla. El clotrimazol es un antifúngico tópico.

TEMA 20.10 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.004

Una paciente de 31 años consulta por dolor vulvar progresivo e invalidante que le impide sentarse. Al examen...

CLAVE B **Incisión, drenaje y marsupialización de la glándula (o colocación de catéter de Word)**

A) Incorrecta. La punción con aguja tiene una tasa de recidiva superior al 80-90% y está proscrita. B) Correcta. El tratamiento de elección para el absceso agudo de la glándula de Bartolino es la incisión y drenaje amplio seguido de MARSUPIALIZACIÓN (sutura de los bordes de la pared de la cápsula a la mucosa vestibular para formar un ostium permanente permeable), o alternativamente la colocación de un Catéter de Word. Estos procedimientos permiten la evacuación del pus y garantizan la formación de una nueva apertura fistulosa definitiva que previene la reobstrucción y recidiva. C) Incorrecta. La vulvectomía es una cirugía mutilante exclusiva de neoplasias malignas invasoras. D) Incorrecta. Los antibióticos no penetran adecuadamente una colección purulenta cerrada a tensión; el drenaje es imperativo. E) Incorrecta.

Perla. El nitrato de plata quema la superficie sin resolver la cavidad abscedada profunda.

TEMA 20.10 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.002

Una mujer de 64 años consulta por prurito vulvar intenso y constante de más de 8 meses de evolución que le interrumpe...

CLAVE B **Liquen Escleroso Vulvar; Propionato de Clobetasol al 0.05% en ungüento tópico**

A) Incorrecta. La candidiasis produce eritema inflamatorio agudo y leucorrea en requesón, no atrofia blanquecina esclerosante. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar crónico intratable en una mujer postmenopáusica con placas atróficas blanquecinas apergaminadas en forma de cerradura o en ocho, con reabsorción de labios menores y encapuchamiento del clítoris, es la descripción patognomónica del Liquen Escleroso Vulvar. El tratamiento de primera línea respaldado por todas las guías dermatológicas y ginecológicas consiste en la aplicación tópica de Corticoides Ultrapotentes, siendo el ungüento de Propionato de Clobetasol al 0.05% el fármaco de elección para frenar la inflamación autoinmune y aliviar el prurito. C) Incorrecta. Los condilomas son vegetaciones verrugosas exofíticas por VPH. D) Incorrecta. El herpes causa vesículas dolorosas agrupadas que se ulceran. E) Incorrecta.

Perla. La psoriasis vulvar se manifiesta como placas eritematosas brillantes no atróficas.

TEMA 20.11 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

Una joven de 20 años acude por dolor en hipogastrio de 3 días de evolución y secreción vaginal amarillenta. Al examen...

CLAVE B **Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 14 días MÁS Metronidazol 500 mg cada 12 horas oral por 14 días**

A) Incorrecta. Las fluoroquinolonas tienen elevadísima resistencia para Neisseria gonorrhoeae en Chile y no se recomiendan como monoterapia. B) Correcta. La paciente presenta una Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP) Estadio I de Monif diagnosticada por los Criterios de Hager (dolor hipogástrico, dolor cervical a la movilización, dolor anexial y fiebre). Al ser de manejo ambulatorio, el esquema oficial ministerial y de los CDC es la triple terapia durante 14 DÍAS: 1) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única (cobertura de gonococo); 2) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura de Chlamydia trachomatis); y 3) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura indispensable para anaerobios pélvicos). Requiere control clínico en 48-72 horas. C) Incorrecta. No cubre adecuadamente Chlamydia ni alcanza niveles tubáricos óptimos. D) Incorrecta. No cubre gonococo ni clamidia. E) Incorrecta.

Perla. No cubre clamidia y una dosis única es inútil para EIP.

TEMA 20.11 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas una paciente con diagnóstico clínico de Enfermedad Pélvica Inflamatoria...

CLAVE B **Presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) evidenciado en la ecografía transvaginal**

A) Incorrecta. Monif I tolera vía oral y es de manejo ambulatorio. B) Correcta. La presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) (Monif Estadio III) es un criterio absoluto e indiscutido de HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA. El ATO conlleva un alto riesgo de rotura intraperitoneal catastrófica con sepsis grave y peritonitis fecal/purulenta, y requiere antibioticoterapia endovenosa continua de amplio espectro a dosis máximas (ej. Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol o Clindamicina + Gentamicina) y monitorización intrahospitalaria estricta para definir si responde o requiere drenaje quirúrgico. C) Incorrecta. El antecedente previo no obliga a hospitalizar si el episodio actual es leve. D) Incorrecta. Se trata ambulatoriamente. E) Incorrecta.

Perla. Se debe insistir en el contacto, pero no es criterio médico de ingreso.

TEMA 20.11 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.025

Una paciente de 25 años en tratamiento ambulatorio por una EIP consulta en la urgencia por persistencia del dolor...

CLAVE A **Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatitis por Chlamydia o Gonococo)**

A) Correcta. El Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis o Perihepatitis asociada a EIP es una complicación clásica provocada por la diseminación ascendente transperitoneal de Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae desde la pelvis a lo largo de las correderas parietocólicas hacia el espacio perihepático. Cursa con dolor agudo en hipocondrio derecho (que simula colecistitis o pleuritis) y formación característica de adherencias peritoneales translúcidas en 'cuerdas de violín' entre la cápsula hepática y el diafragma/pared anterior. El tratamiento consiste en completar el esquema antibiótico para EIP, el cual es altamente curativo. B) Incorrecta. No produce adherencias en cuerdas de violín. C) Incorrecta. Es la trombosis de suprahepáticas con hepatomegalia y ascitis masiva. D) Incorrecta. Lesión ocupante de espacio piógena hepática. E) Incorrecta.

Perla. Infección supurativa con trombosis portal.

TEMA 20.11 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.018

Una paciente hospitalizada hace 48 horas por un Absceso Tubo-Ovárico de 8 cm en tratamiento con Clindamicina más...

CLAVE B **Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Monif IV) con shock séptico; traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora de urgencia**

A) Incorrecta. La colonoscopía está absolutamente contraindicada ante peritonitis perforada. B) Correcta. El deterioro clínico catastrófico repentino con dolor peritoneal difuso, contractura abdominal en tabla (vientre peritoneal) e inestabilidad hemodinámica severa (shock séptico/hipovolémico) en una paciente hospitalizada por un ATO representa una Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Estadio IV de Monif). Es una emergencia quirúrgica de extrema gravedad con altísima mortalidad materna. La conducta mandatoria es la resucitación hemodinámica con fluidos y traslado inmediato a pabellón para LAPAROTOMÍA EXPLORADORA DE URGENCIA con lavado profuso de la cavidad abdominal, desbridamiento y salpingooforectomía del anexo comprometido. C) Incorrecta. La heparina no trata la peritonitis purulenta. D) Incorrecta. Esperar ante un shock séptico por rotura de ATO conduce a la muerte de la paciente en pocas horas. E) Incorrecta.

Perla. El cuadro es estrictamente peritoneal pélvico.

TEMA 20.12 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.027

Una paciente de 51 años con antecedentes de histerectomía total por miomatosis hace 3 años consulta por bochornos...

CLAVE A **Estrógenos solos en monoterapia (vía oral o transdérmica)**

A) Correcta. En una mujer menopáusica sintomática histerectomizada (sin útero) que no tiene contraindicaciones, el tratamiento hormonal de elección indiscutido es la Monoterapia con Estrógenos Solos (ej. 17-beta estradiol oral o transdérmico). Dado que la paciente no tiene útero, no existe riesgo de hiperplasia ni adenocarcinoma de endometrio, por lo que NO se debe prescribir progestágeno; la adición innecesaria de progestágenos aumenta el riesgo de cáncer de mama y eventos adversos sin aportar ningún beneficio clínico adicional. B) Incorrecta. El progestágeno solo se añade para proteger el endometrio en pacientes con útero intacto. C) Incorrecta. Los progestágenos solos son inferiores para sofocos y no aportan protección ósea ni vascular. D) Incorrecta. No es la indicación para síntomas vasomotores del climaterio. E) Incorrecta.

Trampa. La histerectomía previa no es contraindicación; al contrario, simplifica la TRH a estrógenos puros.

TEMA 20.12 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.027

¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas constituye una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para la prescripción de...

CLAVE A **Antecedente personal tratado de Cáncer de Mama ductal infiltrante**

A) Correcta. El antecedente personal o la sospecha de Cáncer de Mama es una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para cualquier formulación de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica, debido a que los estrógenos estimulan la proliferación de células mamarias residuales y aumentan drásticamente el riesgo de recidiva o progresión tumoral. En estas pacientes, los bochornos deben manejarse con alternativas no hormonales (como venlafaxina, paroxetina o gabapentina). B) Incorrecta. La osteoporosis es una indicación aprobada de TRH en mujeres dentro de la ventana de oportunidad. C) Incorrecta. La atrofia es una indicación directa de tratamiento. D) Incorrecta. La menopausia precoz es una indicación prioritaria de TRH para proteger corazón y hueso hasta los 50 años. E) Incorrecta.

Perla. Es la indicación clásica y óptima de TRH.

TEMA 20.13 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.016

Una paciente de 38 años recibe el resultado de su Papanicolaou de tamizaje rutinario que informa: 'Lesión...

CLAVE B **Notificar GES y derivar inmediatamente a la Unidad de Patología Cervical (UPC) para Colposcopía y biopsia dirigida**

A) Incorrecta. Repetir el PAP posterga inaceptablemente el diagnóstico de una lesión premaligna de alto grado que puede albergar cáncer invasor oculto. B) Correcta. En el marco del Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino (GES N° 3), todo informe de PAP con Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL) exige la notificación de garantía GES y la derivación inmediata y obligatoria a la Unidad de Patología Cervical (UPC) de nivel secundario para la realización de una Colposcopía con biopsia dirigida y eventual legrado endocervical en un plazo máximo garantizado de 30 días. C) Incorrecta. Los óvulos no tratan las neoplasias intraepiteliales. D) Incorrecta. La histerectomía sin confirmación diagnóstica colposcópica e histológica previa es una mala praxis quirúrgica grave. E) Incorrecta.

Perla. La vacuna es profiláctica, no tiene ningún efecto terapéutico sobre lesiones preexistentes.

TEMA 20.13 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.013

Una paciente de 49 años consulta por sangrado genital postcoital y fetidez vaginal de 3 meses. Al examen ginecológico...

CLAVE C **Quimiorradioterapia concomitante (Radioterapia externa + Braquiterapia + Cisplatino semanal)**

A) Incorrecta. La cirugía radical está formalmente CONTRAINDICADA cuando el tumor invade los parametrios (Estadio IIB en adelante), debido a que no permite lograr bordes quirúrgicos libres y aumenta masivamente las fístulas urinarias sin beneficio en sobrevida. B) Incorrecta. La conización es exclusiva de lesiones preinvasoras o microinvasoras IA1. C) Correcta. El límite biológico y quirúrgico consensuado internacionalmente (FIGO, NCCN, MINSAL) para operar el cáncer cervicouterino es la indemnidad de los parametrios. Desde el momento en que existe invasión parametrial demostrada al tacto rectovaginal (Estadio IIB), el tratamiento curativo estándar de elección es la Quimiorradioterapia Concomitante basada en Cisplatino semanal asociado a Radioterapia Externa pélvica y Braquiterapia intracavitaria de alta tasa de dosis. Este esquema alcanza excelentes tasas de control local sin la morbilidad de una cirugía no R0. D) Incorrecta. La histerectomía simple deja tumor parametrial activo. E) Incorrecta.

Perla. El Estadio IIB es potencialmente curable con quimiorradioterapia definitiva.

TEMA 20.13 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.013

¿Cuál es la edad y la periodicidad del tamizaje poblacional universal garantizado por el régimen GES para la detección...

CLAVE B **Cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años de edad**

A) Incorrecta. El tamizaje masivo anual en menores de 25 años sobretrata infecciones transitorias por VPH sin reducir la mortalidad. B) Correcta. La Guía Clínica de Cáncer Cervicouterino del MINSAL y las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 3) definen que la población beneficiaria de tamizaje poblacional universal está constituida por las mujeres de 25 a 64 años de edad, mediante el examen de Papanicolaou (PAP) cada 3 años (tras dos controles anuales iniciales consecutivos negativos). Este intervalo trienal maximiza el costo-efectividad y reduce la incidencia de cáncer invasor en más del 80%. C) Incorrecta. El rango 50 a 69 años bienal corresponde al tamizaje de Cáncer de Mama por mamografía. D) Incorrecta. El uso de ACOs no altera el intervalo trienal de tamizaje. E) Incorrecta.

Perla. El tamizaje debe ser periódico a lo largo de toda la vida reproductiva y perimenopáusica.

TEMA 20.13 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.013

¿Cuáles son los dos genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo más prevalentes a nivel...

CLAVE B **VPH tipos 16 y 18**

A) Incorrecta. Los serotipos 6 y 11 son de bajo riesgo oncogénico y son los causantes del 90% de los condilomas acuminados (verrugas anogenitales benignas). B) Correcta. Los serotipos 16 y 18 del Virus Papiloma Humano son los principales agentes carcinogénicos de alto riesgo oncogénico para el epitelio cervical. El serotipo 16 es responsable de aproximadamente el 55-60% de los carcinomas epidermoides de cuello uterino, y el serotipo 18 es responsable del 15% de los carcinomas epidermoides y de más del 50% de los adenocarcinomas endocervicales. Ambos están cubiertos por la vacuna del PNI chileno. C) Incorrecta. Los serotipos 1 y 2 causan verrugas vulgares y plantares cutáneas. D) Incorrecta. Son serotipos de bajo riesgo. E) Incorrecta.

Perla. Asociados a epidermodisplasia verruciforme en piel.

TEMA 20.14 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

Una paciente de 52 años asintomática se realiza una mamografía de tamizaje rutinario que informa: 'En el cuadrante...

CLAVE B **Realización de Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy) guiada por imágenes**

A) Incorrecta. El control a los 6 meses es la conducta exclusiva de la categoría BI-RADS 3 (95%) tiene indicación formal y mandatoria de confirmación histológica mediante Biopsia Percutánea con Aguja Gruesa (Core Biopsy o Tru-Cut) guiada por ecografía o estereotaxia. Este procedimiento obtiene cilindros de tejido que permiten diagnosticar invasión del estroma y realizar el panel inmunohistoquímico completo (RE, RP, HER2 y Ki-67). C) Incorrecta. Mutilar una mama sin diagnóstico histológico previo es una mala praxis inadmisible. D) Incorrecta. La PAAF solo aporta células aisladas que no permiten distinguir carcinoma in situ de carcinoma invasor ni medir adecuadamente los receptores. E) Incorrecta.

Perla. La hormonoterapia requiere confirmación histológica de neoplasia con receptores positivos.

TEMA 20.14 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

Una mujer de 58 años es sometida a una tumorectomía conservadora de mama con márgenes quirúrgicos libres por un...

CLAVE A **Radioterapia externa sobre la glándula mamaria restante**

A) Correcta. El estándar oncológico internacional y las guías del MINSAL establecen como regla de oro indiscutible que TODA Cirugía Conservadora de Mama (tumorectomía o cuadrantectomía) DEBE ir seguida obligatoriamente de RADIOTERAPIA EXTERNA ADYUVANTE sobre la glándula mamaria residual. Los ensayos clínicos clásicos (NSABP B-06) demostraron que la cirugía conservadora MÁS radioterapia ofrece exactamente la misma tasa de sobrevida global a largo plazo que la mastectomía radical, pero omitir la radioterapia eleva la tasa de recidiva local a más del 25-35%. B) Incorrecta. El metotrexato intratecal es para leucemias o metástasis meníngeas. C) Incorrecta. El vaciamiento axilar se evita si el ganglio centinela es negativo. D) Incorrecta. No tiene indicación en cáncer de mama. E) Incorrecta.

Trampa. Omitir la radioterapia tras tumorectomía es un error terapéutico grave.

TEMA 20.14 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.029

Una paciente de 46 años, no lactante, consulta por la salida espontánea de secreción serohemática (líquido rosado con...

CLAVE B **Papiloma intraductal solitario**

A) Incorrecta. El fibroadenoma es un nódulo móvil que no se comunica con los conductos principales ni produce telorrea hemática. B) Correcta. La causa benigna más frecuente de telorrea serohemática o hemática unilateral, unicanalicular (que brota por un único poro del pezón) y espontánea en mujeres en edad reproductiva o perimenopáusica es el Papiloma Intraductal Benigno. Consiste en una pequeña proliferación de epitelio ductal vascularizado que asienta en los conductos galactóforos principales retroareolares. Debe estudiarse con ecografía/mamografía y resolverse mediante resección del conducto afectado (microdoquectomía) para descartar un carcinoma papilar subyacente. C) Incorrecta. El prolactinoma produce galactorrea (leche blanquecina) bilateral, pluriorificial y sin sangre. D) Incorrecta. Cursa con masa inflamatoria dolorosa abscedada recurrente. E) Incorrecta.

Perla. La ectasia ductal produce secreción pluriorificial, bilateral, espesa y verdosa/pardusca.

TEMA 20.14 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.030

Una paciente de 42 años diagnosticada de cáncer de mama invasor presenta el siguiente informe de inmunohistoquímica...

CLAVE B **Subtipo Triple Negativo; NO responderá a hormonoterapia ni a Trastuzumab, requiriendo quimioterapia citotóxica**

A) Incorrecta. El tamoxifeno requiere que los receptores de estrógeno sean positivos. B) Correcta. El tumor que resulta negativo para los tres marcadores clásicos (RE negativo, RP negativo y HER2 negativo) se clasifica como Cáncer de Mama Triple Negativo. Representa aproximadamente el 15% de los cánceres mamarios y se asocia con mayor frecuencia a pacientes jóvenes y portadoras de mutaciones en el gen BRCA1. Desde el punto de vista terapéutico, al carecer de receptores hormonales y de la proteína HER2, este tumor NO se beneficia de la hormonoterapia (tamoxifeno/anastrozol) ni de la terapia dirigida anti-HER2 (Trastuzumab); su tratamiento médico descansa fundamentalmente en la Quimioterapia Citotóxica combinada. C) Incorrecta. El HER2 es negativo; el trastuzumab es ineficaz. D) Incorrecta. Los inhibidores de aromatasa exigen receptores hormonales positivos. E) Incorrecta.

Perla. El triple negativo es un carcinoma muy agresivo con alta tasa de recidiva temprana.

TEMA 20.15 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.024

Una paciente de 63 años consulta por sangrado vaginal rojo oscuro escaso de 2 semanas de evolución tras 12 años de...

CLAVE B **Realización de una Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle o histeroscopía)**

A) Incorrecta. Los estrógenos locales tratan la atrofia, pero ante un endometrio de 12 mm retrasarían el diagnóstico de un adenocarcinoma. B) Correcta. El sangrado postmenopáusico es el síntoma de presentación del Cáncer de Endometrio en el 90% de los casos. La presencia de un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una mujer menopáusica exige de forma mandatoria e impostergable la obtención de una muestra histológica mediante Biopsia Endometrial (la aspiración ambulatoria con cánula de Pipelle es el método de primera línea por su alta sensibilidad y bajo costo, recurriéndose a histeroscopía si la muestra no es concluyente). C) Incorrecta. El PET-CT no sustituye la biopsia histológica primaria. D) Incorrecta. La conducta expectante ante sospecha de neoplasia ginecológica es negligencia. E) Incorrecta.

Perla. La causa del sangrado reside en el endometrio uterino, no en los ovarios.

TEMA 20.15 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.028

Una mujer de 65 años consulta por distensión abdominal progresiva, dispepsia y saciedad precoz de 3 meses de evolución...

CLAVE B **Cáncer epitelial de ovario avanzado; derivar de inmediato a Ginecología Oncológica para laparotomía etapificadora y citorreducción primaria**

A) Incorrecta. Los quistes foliculares solo ocurren en mujeres fértiles ovuladoras, no en postmenopáusicas de 65 años. B) Correcta. La constelación clínica de síntomas digestivos subagudos (distensión, saciedad precoz) asociada a ascitis, una masa anexial con todos los criterios IOTA de malignidad (multiloculada, tabiques gruesos, papilas sólidas y flujo Doppler central) y un marcador tumoral CA-125 marcadamente elevado en una mujer postmenopáusica es diagnóstica de Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado. La conducta es la derivación urgente a un centro terciario oncológico para cirugía citorreductora primaria máxima (debulking) y posterior quimioterapia con carboplatino y paclitaxel. C) Incorrecta. La punción percutánea o transvaginal de una masa ovárica con sospecha de cáncer está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA por el gravísimo riesgo de rotura capsular y siembra masiva de células tumorales en la cavidad peritoneal. D) Incorrecta. Los endometriomas no tienen papilas ni se asocian a ascitis masiva en postmenopáusicas. E) Incorrecta.

Perla. El cuadro es una neoplasia ovárica primaria con carcinomatosis.

TEMA 20.15 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.028

¿Por qué razón oncológica fundamental está FORMALMENTE CONTRAINDICADO realizar una punción-aspiración con aguja de una...

CLAVE B **Porque la rotura de la cápsula quística provoca la siembra y diseminación de células malignas en la cavidad peritoneal, empeorando el estadio y pronóstico oncológico de la paciente**

A) Incorrecta. No causa hemorragia digestiva. B) Correcta. La punción evacuadora de un tumor ovárico sospechoso de cáncer está estrictamente proscrita en la ginecología oncológica moderna. Si el tumor corresponde a un carcinoma ovárico confinado al ovario (Estadio IA), la punción accidental o deliberada de la cápsula produce el derrame de líquido cargado de células neoplásicas viables hacia el peritoneo libre, transformando inmediatamente la enfermedad en un Estadio IC (peor pronóstico) y multiplicando drásticamente el riesgo de carcinomatosis peritoneal y muerte. Toda masa ovárica sospechosa debe extirparse quirúrgicamente íntegra sin romper su cápsula. C) Incorrecta. La elevación de CA-125 es un marcador tumoral secundario, no el daño biológico. D) Incorrecta. No tiene que ver con permeabilidad tubárica. E) Incorrecta.

Perla. Salvo el excepcional estruma ovárico, no causa tirotoxicosis.

TEMA 20.15 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.024

¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas se asocia al mayor riesgo relativo de desarrollar un Adenocarcinoma de...

CLAVE C **Obesidad severa (aromatización periférica en tejido adiposo) y Síndrome de Ovario Poliquístico**

A) Incorrecta. La multiparidad es un factor protector (la progesterona del embarazo descama y protege el endometrio). B) Incorrecta. Los ACOs combinados protegen fuertemente contra el cáncer de endometrio (reducen el riesgo en un 50%). C) Correcta. El adenocarcinoma de endometrio tipo I es un tumor hormonodependiente vinculado a la exposición prolongada a estrógenos sin la oposición protectora de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). La Obesidad es el factor de riesgo más importante en países occidentales, debido a que el exceso de tejido adiposo contiene enzima aromatasa que convierte masivamente los andrógenos suprarrenales (androstenediona) en estrona. Asimismo, el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) perpetúa ciclos anovulatorios crónicos sin fase lútea ni secreción de progesterona. D) Incorrecta. Curiosamente, el tabaquismo ejerce un leve efecto antiestrogénico hepático y reduce discretamente el riesgo de cáncer de endometrio (aunque aumenta muchos otros cánceres). E) Incorrecta.

Perla. El DIU-LNG produce atrofia endometrial y es fuertemente protector.

TEMA 20.16 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.019

Una joven de 21 años consulta por dolor intenso y súbito en fosa ilíaca izquierda de 5 horas de evolución que se...

CLAVE B **Laparoscopía de urgencia inmediata para detorsión ovárica y preservación del anexo**

A) Incorrecta. Enviar a domicilio a una paciente con torsión ovárica causa la necrosis y pérdida irreversible del ovario en pocas horas. B) Correcta. La Torsión Ovárica es una emergencia quirúrgica isquémica por compromiso vascular del ligamento infundíbulo-pélvico. En mujeres jóvenes en edad reproductiva, el estándar quirúrgico internacional exige la intervención inmediata mediante Laparoscopía de urgencia para realizar la DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA (desenrollar el anexo sobre su eje) para restaurar el flujo sanguíneo y preservar el parénquima ovárico y la fertilidad. El ovario tiene una extraordinaria capacidad de recuperación funcional aun tras horas de isquemia clínica. C) Incorrecta. La punción no resuelve la torsión del pedículo y agrega riesgo de infección. D) Incorrecta. No es un cuadro infeccioso; el compromiso es isquémico mecánico. E) Incorrecta.

Perla. La ooforectomía sistemática de entrada sin intentar detorsión es una práctica desaconsejada y mutilante en mujeres jóvenes.

TEMA 20.16 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.019

Una paciente de 24 años consulta por dolor pélvico agudo de inicio brusco tras mantener relaciones sexuales coitales...

CLAVE B **Manejo médico conservador expectante con analgesia oral, reposo y control ambulatorio**

A) Incorrecta. La cirugía abierta es invasiva y desproporcionada para un cuadro estable. B) Correcta. El cuadro clínico de dolor pélvico agudo postcoital en fase lútea tardía, asociado a los hallazgos ecográficos patognomónicos de un quiste con patrón reticular en 'red de pesca' y líquido libre escaso en una paciente hemodinámicamente estable (PA 118/74, FC 78, hematocrito normal de 40%), corresponde a un Quiste Ovárico Hemorrágico Roto no complicado. La conducta de elección es el MANEJO MÉDICO CONSERVADOR EXPECTANTE con analgesia, reposo y observación clínica. El sangrado del lecho quístico se autolimitada espontáneamente y el hemoperitoneo leve se reabsorbe sin necesidad de cirugía. C) Incorrecta. La laparoscopía solo está indicada si existe inestabilidad hemodinámica, hemoperitoneo masivo o caída persistente del hematocrito. D) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico (la prueba de gestación fue negativa). E) Incorrecta.

Perla. La paciente tiene un hematocrito normal y no requiere transfusión.